Estilo UERJ

Simulado 3
Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	27	1, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 22, 26, 27, 30, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 68, 75, 76, 79
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	8	20, 38, 49, 53, 62, 66, 71, 73
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	3	18, 29, 32
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	3	10, 28, 67
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	14	2, 5, 17, 21, 35, 39, 42, 47, 55, 64, 70, 72, 78, 80
Qualificador	o comando restringe o que se pede	2	15, 31
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	10	4, 11, 12, 13, 19, 24, 36, 41, 65, 77
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	8	23, 25, 33, 34, 37, 43, 48, 74
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	5	6, 40, 44, 59, 69

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 D	2 D	3 C	4 B	5 B	6 C	7 D	8 A	9 C	10 C
11 A	12 B	13 D	14 A	15 A	16 D	17 D	18 A	19 D	20 D
21 D	22 B	23 B	24 C	25 C	26 B	27 A	28 C	29 D	30 A
31 B	32 C	33 D	34 B	35 D	36 B	37 B	38 A	39 D	40 C
41 A	42 D	43 B	44 A	45 C	46 B	47 D	48 D	49 D	50 B
51 B	52 C	53 A	54 C	55 A	56 C	57 C	58 C	59 B	60 B
61 B	62 D	63 C	64 B	65 C	66 C	67 A	68 C	69 D	70 B
71 B	72 A	73 B	74 A	75 A	76 A	77 C	78 A	79 A	80 C

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 19, B 21, C 21, D 19.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Hematologia · Leucemia/linfoma de células T do adulto pelo HTLV-1 em pessoa com HIV controlado

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 46 anos, natural de Salvador, vive com HIV há 10 anos, em TARV regular, com carga viral indetectável e CD4 de 620 células/mm³. Procura atendimento por sede intensa, constipação e sonolência há 1 semana e placas eritematosas descamativas no tronco há 2 meses. Exame: linfonodos cervicais e axilares de 2 a 3 cm, fígado a 4 cm do rebordo costal. Exames: cálcio total 14,2 mg/dL, albumina 3,8 g/dL, PTH 6 pg/mL (VR 15 a 65), 1,25-di-hidroxivitamina D baixa, PTHrP elevado, creatinina 1,8 mg/dL, leucócitos 38.000/mm³ com 70% de linfócitos atípicos de núcleo convoluto e multilobulado, LDH 1.100 U/L. Imunofenotipagem do sangue periférico: CD3+, CD4+, CD25+, CD7 negativo. O agente etiológico mais provavelmente implicado é:

O DADO QUE DECIDE

CD3+, CD4+, CD25+, CD7 negativo

Resolução. O rótulo verdadeiro é o HIV, que puxa para os linfomas associados ao EBV (Burkitt, difuso de grandes células B, primário do SNC) e ao HHV-8 (linfoma primário de efusões). Mas o HIV está controlado, com CD4 de 620, e o linfoma aqui é de células T CD4+ CD25+, com linfócitos de núcleo multilobulado no sangue (as células em flor), lesões cutâneas e hipercalcemia grave. Esse conjunto é a leucemia/linfoma de células T do adulto, causada pelo HTLV-1, endêmico em Salvador e transmitido pelas mesmas vias que o HIV (sexual, sangue, aleitamento), o que torna a coinfecção comum. A hipercalcemia aqui é por PTHrP e ativação de osteoclastos (1,25-vitamina D baixa), diferente da hipercalcemia por calcitriol de outros linfomas. A confirmação é a sorologia para HTLV-1, e a doença também predispõe a estrongiloidíase grave.

A) Herpesvírus humano 8

Errada. O HHV-8 causa sarcoma de Kaposi, linfoma primário de efusões e Castleman multicêntrico, nenhum com linfocitose T CD4+ CD25+ no sangue.

B) Vírus Epstein-Barr ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o EBV causa os linfomas B do HIV, sobretudo com CD4 baixo; não explica linfoma T CD4+ CD25+ com núcleos multilobulados.

C) HIV por ação oncogênica direta

Errada. O HIV não é oncogênico direto para linfócitos T; ele favorece linfomas por imunossupressão, que aqui não há.

D) HTLV-1 CORRETA

Correta. Células T CD4+ CD25+ CD7 negativas com núcleo multilobulado, lesões de pele e hipercalcemia por PTHrP em baiano: leucemia/linfoma T do adulto, pelo HTLV-1.

Para levar. Linfocitose T CD4+ CD25+ com núcleos multilobulados (células em flor), lesões cutâneas e hipercalcemia é leucemia/linfoma T do adulto pelo HTLV-1, endêmico na Bahia e frequente em quem vive com HIV.

Classificação OMS 2022 (5ª edição) das neoplasias linfoides; consenso internacional sobre ATL (Cook et al., J Clin Oncol 2019); Ministério da Saúde, Guia de manejo clínico da infecção pelo HTLV (2021).

---

2 Reumatologia · Gota: dose inicial do alopurinol e profilaxia anti-inflamatória ao iniciar o hipouricemiante

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 54 anos tem gota, com três crises de podagra e uma de joelho nos últimos 12 meses, a última resolvida há 3 semanas com colchicina. É hipertenso e usava hidroclorotiazida, trocada por losartana há 1 mês. Sem tofos ao exame e sem litíase renal. Exames: ácido úrico 9,4 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL (TFGe 92 mL/min/1,73 m²), ALT e hemograma normais. Será iniciado alopurinol. Quanto à dose inicial do alopurinol e à profilaxia das crises, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Será iniciado alopurinol

Resolução. A dose de 300 mg/dia, a mais prescrita, é a armadilha: iniciar o alopurinol em dose plena aumenta as crises de mobilização e o risco de hipersensibilidade grave. A recomendação é começar com no máximo 100 mg/dia (menos na doença renal crônica moderada a grave) e subir 100 mg a cada 2 a 5 semanas até o ácido úrico ficar abaixo de 6 mg/dL, o que muitas vezes exige 300 a 600 mg/dia ou mais. Ao mesmo tempo, a queda do urato mobiliza cristais e precipita crises, por isso se associa profilaxia anti-inflamatória (colchicina 0,5 a 1 mg/dia, ou AINE ou prednisona em dose baixa) por 3 a 6 meses, prolongando se ainda houver crises. Dispensar a profilaxia é o erro que faz o paciente abandonar o hipouricemiante na primeira crise. A troca da hidroclorotiazida por losartana, que tem efeito uricosúrico leve, foi correta e não muda as duas decisões.

A) 300 mg/dia / sem profilaxia
Errada nas duas metades. Dose plena sem profilaxia é a combinação que mais produz crises no início e abandono do tratamento.

B) 300 mg/dia / colchicina por 3 a 6 meses ARMADILHA
Errada na primeira metade. A profilaxia está certa, mas iniciar com 300 mg/dia aumenta crises e o risco de hipersensibilidade; 300 mg é dose a que se chega pela titulação.

C) 100 mg/dia / sem profilaxia
Errada na segunda metade. A dose está certa, mas sem profilaxia a mobilização dos cristais precipita crises nos primeiros meses.

D) 100 mg/dia / colchicina por 3 a 6 meses CORRETA
Correta. Dose inicial baixa com titulação até o alvo, e colchicina profilática por 3 a 6 meses.

Para levar. Alopurinol começa com até 100 mg/dia e sobe até urato abaixo de 6 mg/dL, sempre com profilaxia anti-inflamatória por 3 a 6 meses.

ACR 2020 Guideline for the Management of Gout; EULAR 2016 updated recommendations for the management of gout.

3

Pneumologia · Tumor do sulco superior em tabagista com laudo de hérnia discal cervical

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 63 anos, pedreiro, tabagista (40 maços-ano), tem dor intensa no ombro direito irradiada pela face medial do braço e do antebraço até o 4º e o 5º dedos há 4 meses, com piora noturna e sem melhora com anti-inflamatório e fisioterapia. Perdeu 6 kg. Radiografia de tórax em PA feita há 2 meses, laudada como normal. Ressonância de coluna cervical: protrusão discal C5-C6 sem compressão radicular significativa e uncoartrose difusa. Exame: atrofia dos interósseos e da eminência hipotenar à direita, hipoestesia na face medial do antebraço direito, pupila direita menor que a esquerda, com ptose palpebral discreta à direita e menos sudorese na hemiface direita. Reflexos bicipitais e tricipitais simétricos. A causa mais provável do quadro é:

O DADO QUE DECIDE

pupila direita menor que a esquerda, com ptose palpebral discreta à direita e menos sudorese na hemiface direita

Resolução. Pedreiro com dor cervicobraquial, ressonância com protrusão discal e radiografia de tórax normal tem dois laudos que parecem fechar o caso. Mas a protrusão é em C5-C6, que comprimiria a raiz C6 (face lateral do antebraço e polegar), e o déficit é de C8 e T1 (face medial, 4º e 5º dedos, interósseos e hipotênar). Junto há síndrome de Horner do mesmo lado (miose, ptose e anidrose), dor noturna refratária e perda de peso num tabagista de 40 maços-ano: invasão do plexo braquial inferior e da cadeia simpática cervical por tumor do ápice pulmonar (Pancoast). A radiografia em PA normal não afasta, porque o ápice é zona cega da incidência frontal e o tumor do sulco costuma ser pequeno no início. Desfiladeiro torácico pode dar déficit de C8 e T1, mas não Horner nem perda de peso. O passo seguinte é a imagem do ápice (TC de tórax e ressonância do plexo).

A) Siringomielia cervical
Errada. Siringomielia dá perda sensitiva dissociada (dor e temperatura) em capa, em geral bilateral, sem dor noturna intensa nem emagrecimento.

B) Síndrome do desfiladeiro torácico
Errada. O desfiladeiro neurogênico dá dor e atrofia em território C8 e T1, mas sem Horner, sem perda de peso e com piora à elevação do braço.

C) Tumor do sulco pulmonar superior CORRETA
Correta. Plexopatia de C8 e T1 com síndrome de Horner, dor noturna e emagrecimento em tabagista: tumor do sulco superior.

D) Radiculopatia por hérnia discal cervical ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A protrusão C5-C6 afetaria C6, não C8 e T1, não comprime a raiz no laudo e não explica Horner nem perda de peso.

Para levar. Dor no território C8 e T1 com Horner do mesmo lado em tabagista é tumor do sulco superior até prova em contrário, mesmo com ressonância cervical alterada.

ACCP 2013 (diagnóstico e estadiamento do câncer de pulmão)

4

Nefrologia · Anemia da doença renal crônica com ferritina normal · ferro antes do estimulador da eritropoese

Limiar **Gabarito B**

Em adulto com doença renal crônica não dialítica (TFGe 24 mL/min/1,73 m²), hemoglobina de 9,2 g/dL, VCM de 86 fL, saturação de transferrina de 17%, ferritina de 340 ng/mL, sem sangramento e sem uso prévio de agente estimulador da eritropoese, a primeira medida para a anemia é:

O DADO QUE DECIDE

saturação de transferrina de 17%

Resolução. A ferritina de 340 parece afastar ferropenia, e anemia da DRC lembra eritropoetina. Mas na DRC a ferritina sobe com a inflamação, e o limiar para tentar ferro é outro: a KDIGO recomenda ferro (oral ou intravenoso) quando a saturação de transferrina é de até 30% e a ferritina de até 500 ng/mL, antes de iniciar o agente estimulador da eritropoese. Repletar ferro primeiro corrige parte da anemia sem os riscos do estimulador (hipertensão, trombose, AVC) e evita a falta de ferro, que é a causa mais comum de má resposta a ele. A alfaepoetina entra depois, com hemoglobina abaixo de 10 g/dL apesar do ferro repleto, e com alvo que não passa de 11,5 g/dL. A UERJ cobra exatamente essa ordem: ferro antes da eritropoetina.

A) Iniciar alfaepoetina ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria considerada com ferro repleto e hemoglobina abaixo de 10; iniciar com saturação de 17% dá resposta ruim e exige dose maior.

B) Reposição de ferro CORRETA

Correta. Saturação de 17% (até 30%) com ferritina de 340 (até 500) indica prova terapêutica com ferro antes de qualquer estimulador.

C) Alfaepoetina associada a ferro

Errada. Associar desde o início expõe ao estimulador quem pode responder só ao ferro; a sequência é ferro, reavaliar e, se preciso, estimulador.

D) Transfusão de hemácias

Errada. Transfusão é para anemia sintomática grave ou instabilidade, e ainda sensibiliza contra um futuro transplante renal.

Para levar. Anemia da DRC: ferro antes da eritropoetina quando a saturação de transferrina é de até 30% e a ferritina de até 500 ng/mL; ferritina normal não exclui ferropenia funcional.

KDIGO 2012 (Anemia in CKD); PCDT Anemia na Doença Renal Crônica (Ministério da Saúde).

5

Grade X / Y **Gabarito B**

Cardiologia · Síndrome de Marfan com raiz aórtica normal: prolapso mitral e efeito do ortostatismo

Rapaz de 17 anos, 1,92 m, com envergadura maior que a altura, aracnodactilia, sinais do punho e do polegar positivos, pectus excavatum e ectopia lentis bilateral operada aos 12 anos. O pai morreu aos 41 anos de dissecção de aorta. Assintomático, joga vôlei na escola. PA 118×64 mmHg, FC 68 bpm. Ecocardiograma de triagem feito há 8 meses: raiz da aorta de 31 mm (escore Z +1,4), aorta ascendente normal, sem refluxo aórtico, função ventricular normal. Ao auscultá-lo deitado e, em seguida, em pé, o achado mais provável e o efeito da mudança para a posição de pé são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

raiz da aorta de 31 mm (escore Z +1,4), aorta ascendente normal, sem refluxo aórtico

Resolução. Quem acabou de fixar 'Marfan, raiz dilatada, insuficiência aórtica, sopro paraesternal direito' vai marcar a armadilha sem ler o ecocardiograma. Mas a raiz tem escore Z de +1,4 (normal) e não há refluxo: a insuficiência aórtica é uma complicação da dilatação, que este adolescente ainda não tem. A lesão valvar mais frequente no Marfan, sobretudo no jovem, é o prolapso da valva mitral (até 40 a 80%), que se ausculta como clique mesossistólico, às vezes seguido de sopro telessistólico. Tudo que reduz o volume do VE (ficar de pé, Valsalva) faz o folheto prolapsar mais cedo e o clique se aproxima de B1; agachar ou elevar as pernas aumenta o volume e atrasa o clique. Marfan leva à aorta e à mitral, e qual das duas aparece depende do dado do caso.

A) Sopro diastólico paraesternal direito / mais intenso ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a ausculta do Marfan com raiz dilatada e insuficiência aórtica; o ecocardiograma mostra raiz normal e nenhum refluxo.

B) Clique mesossistólico / mais precoce CORRETA
Correta. Prolapso mitral é a valvopatia mais frequente no Marfan jovem, e de pé o VE menor faz o clique surgir mais cedo na sístole.

C) Clique mesossistólico / mais tardio
Errada na segunda metade. O clique está certo, mas atrasa com o que aumenta o volume ventricular (cócoras, elevação das pernas), não com o ortostatismo.

D) Sopro diastólico paraesternal direito / inalterado
Errada nas duas metades. Não há insuficiência aórtica, e o sopro de refluxo aórtico diminuiria de pé, pela queda do retorno venoso, em vez de ficar igual.

Para levar. Marfan tem duas lesões: prolapso mitral (frequente e precoce, clique mesossistólico que antecipa de pé e com Valsalva) e insuficiência aórtica por dilatação da raiz (sopro diastólico paraesternal direito). O ecocardiograma do caso diz qual delas está presente.

ESC 2024 (peripheral arterial and aortic diseases); Ghent revisado 2010; ACC/AHA 2020 (valvular heart disease); Braunwald's Heart Disease, 12ª ed.

6 Gastroenterologia · Pseudoacalasia: manometria de acalasia tipo II em idoso com disfagia curta e emagrecimento

Cronologia **Gabarito C**

Homem de 71 anos, ex-tabagista, há 4 meses com disfagia progressiva para sólidos e depois para líquidos, regurgitação e perda de 11 kg. Endoscopia digestiva alta: esôfago discretamente dilatado, com resíduos, e resistência leve à passagem do aparelho pela junção esofagogástrica, cuja mucosa é normal à visão direta e na retrovisão; biópsias da cárdia sem neoplasia. Esofagograma baritado: afilamento distal em bico de pássaro. Manometria de alta resolução: pressão de relaxamento integrada da junção esofagogástrica de 28 mmHg e pressurização panesofágica em 100% das deglutições. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

há 4 meses com disfagia progressiva para sólidos e depois para líquidos, regurgitação e perda de 11 kg

Resolução. A manometria fecha o padrão de acalasia tipo II e o esofagograma mostra bico de pássaro, e quem confia no exame vai direto à dilatação ou à miotomia. Mas a cronologia não é a da acalasia idiopática: 71 anos, sintomas há só 4 meses e perda de 11 kg, além de resistência à passagem do aparelho pela junção. Esses dados (idade acima de 55 a 60 anos, história menor que 1 ano e emagrecimento importante) são as bandeiras de pseudoacalasia, quase sempre adenocarcinoma infiltrativo da cárdia ou outra neoplasia que envolve o plexo da junção. Biópsia de mucosa normal não afasta, porque a infiltração é submucosa. O próximo passo é ecoendoscopia (ou TC) antes de qualquer tratamento.

A) Dilatação pneumática da cárdia

Errada. Seria uma opção na acalasia idiopática confirmada; dilatar uma neoplasia infiltrativa atrasa o diagnóstico e arrisca perfuração.

B) Toxina botulínica na cárdia

Errada. Toxina botulínica é reservada a quem não pode fazer tratamento definitivo e não resolve a dúvida diagnóstica.

C) Ecoendoscopia da cárdia CORRETA

Correta. Idade, história de 4 meses, perda de 11 kg e resistência à passagem pedem ecoendoscopia para procurar infiltração neoplásica submucosa.

D) Miotomia endoscópica peroral ARMADILHA

Errada. É a isca: a miotomia endoscópica é excelente na acalasia tipo II, mas só depois de afastada a pseudoacalasia neste perfil.

Para levar. Manometria de acalasia em idoso com sintomas há menos de 1 ano e emagrecimento importante é pseudoacalasia até prova em contrário: ecoendoscopia ou TC antes de tratar.

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Achalasia (2020); Classificação de Chicago versão 4.0 (2021)

7 Infectologia · Doença de Chagas aguda por transmissão oral durante epidemia de dengue

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Em município do Baixo Tocantins (PA), em plena epidemia de dengue, um homem de 34 anos procura atendimento com febre diária há 12 dias, cefaleia, mialgia, edema de face e de membros inferiores e dispneia aos esforços há 3 dias. Outros quatro membros da família, que tomaram juntos açaí comprado de um vendedor ambulante há cerca de 3 semanas, têm quadro semelhante. Não há lesão de porta de entrada nem edema palpebral unilateral. Exame: T 38,2 °C, FC 118 bpm, PA 104 × 68 mmHg, edema facial e de membros inferiores, estertores em bases, terceira bulha. Hb 12,8 g/dL, leucócitos 9.200/mm³ com linfocitose, plaquetas 168.000/mm³, ALT 84 U/L. ECG: taquicardia sinusal, baixa voltagem e alterações difusas da repolarização. Ecocardiograma: derrame pericárdico pequeno e FE 45%. NS1 e IgM para dengue não reagentes. O exame mais adequado para confirmar o diagnóstico nesta fase é:

O DADO QUE DECIDE

tomaram juntos açaí comprado de um vendedor ambulante há cerca de 3 semanas

Resolução. A epidemia de dengue é verdadeira e faz o candidato insistir na arbovirose, mas febre de 12 dias com edema facial, miocardite (B3, baixa voltagem, FE de 45%), derrame pericárdico e surto familiar após açaí ingerido em conjunto é doença de Chagas aguda por transmissão oral, endêmica na Amazônia. A ausência de chagoma e de sinal de Romaña é esperada nessa via. Na fase aguda a parasitemia é alta, e o diagnóstico se confirma pela pesquisa direta do T. cruzi no sangue (exame a fresco, gota espessa ou esfregaço, ou concentração por Strout). A sorologia IgG é o exame da fase crônica e ainda pode estar negativa; se usada na fase aguda, vale a IgM ou a soroconversão. O tratamento é benznidazol, e o caso deve ser notificado de imediato como surto.

A) RT-PCR para dengue ARMADILHA
Errada. É a armadilha: RT-PCR serve à dengue até o 5º dia; no 12º dia, com NS1 e IgM negativos e miocardite com edema facial, a epidemia não explica o quadro.

B) Sorologia IgG para T. cruzi
Errada. IgG é o exame da fase crônica e pode ainda ser negativa na aguda; o diagnóstico agudo é parasitológico.

C) Hemoculturas para bactérias
Errada. Hemoculturas investigariam endocardite ou sepse bacteriana, sem relação com o surto familiar após açaí.

D) Pesquisa direta do parasito no sangue CORRETA
Correta. Fase aguda tem parasitemia alta: a pesquisa direta do T. cruzi no sangue confirma o diagnóstico.

Para levar. Surto familiar de febre, edema facial e miocardite após açaí na Amazônia é Chagas agudo oral: confirme pela pesquisa direta do parasito no sangue, não pela IgG.

II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (Epidemiol Serv Saúde, 2016); Guia de Vigilância em Saúde (MS, 6ª edição, 2023).

8 Endocrinologia · Macroadenoma gigante com prolactina modesta: efeito gancho antes da cirurgia

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 46 anos procura atendimento por cefaleia frontal há oito meses e perda de libido e disfunção erétil há dois anos. Exame: hemianopsia temporal bilateral à confrontação, ginecomastia discreta, sem galactorreia, testículos de volume normal. Ressonância magnética: macroadenoma hipofisário de 4,3 cm, com invasão do seio cavernoso direito e compressão do quiasma óptico. Exames: prolactina 62 ng/mL (até 15), testosterona total 98 ng/dL (300 a 1.000), LH 1,1 UI/L, cortisol às 8 horas 16,8 µg/dL, T4 livre 0,9 ng/dL (0,8 a 1,8), IGF-1 normal para a idade. A neurocirurgia programa cirurgia transesfenoidal para a próxima semana por adenoma não funcionante com desconexão de haste. Antes de decidir, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

macroadenoma hipofisário de 4,3 cm, com invasão do seio cavernoso direito

Resolução. Prolactina abaixo de 100 a 150 ng/mL com macroadenoma é, na maioria das vezes, hiperprolactinemia por desconexão de haste, e esse rótulo verdadeiro já está escrito no parecer. O problema é o tamanho: num adenoma de 4,3 cm, invasivo, prolactinoma gigante produz prolactina na casa dos milhares, e o excesso de antígeno satura os dois anticorpos do ensaio imunométrico, devolvendo um valor falsamente baixo (efeito gancho). Uma prolactina modesta, portanto, não separa os dois diagnósticos nesse tamanho. Repetir a dosagem com diluição seriada (1:100) resolve, e o resultado muda tudo: prolactinoma se trata com cabergolina, mesmo com compressão do quiasma, e não com cirurgia. O cortisol de 16,8 já afasta deficiência adrenal relevante, e macroprolactina não é a dúvida com tumor desse porte.

A) Prolactina com diluição da amostra CORRETA
Correta. Macroadenoma grande com prolactina modesta exige excluir efeito gancho com diluição antes de rotular como não funcionante.

B) Teste de estímulo com cosintropina
Errada. Seria o exame com cortisol matinal entre 3 e 15 µg/dL; 16,8 µg/dL dispensa estímulo.

C) Pesquisa de macroprolactina
Errada. Macroprolactina explica prolactina alta com pouca clínica; aqui a dúvida é o valor estar falsamente baixo.

D) Nenhum exame antes da cirurgia ARMADILHA
Errada. Seria aceitável num macroadenoma pequeno, de 1 a 2 cm; com 4,3 cm, operar um prolactinoma gigante é trocar o tratamento clínico eficaz por cirurgia de alto risco.

Para levar. Macroadenoma acima de 3 cm com prolactina abaixo de 200: peça dosagem com diluição para excluir efeito gancho antes de chamar de não funcionante e operar.

Endocrine Society, Hyperprolactinemia 2011; Pituitary Society consensus on prolactinomas (Petersenn et al., Nat Rev Endocrinol 2023).

9

Reumatologia · Pancitopenia no transplantado renal: interação do alopurinol com a azatioprina

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Homem de 52 anos, transplantado renal há 6 anos, usa tacrolimo, azatioprina 100 mg/dia e prednisona 5 mg/dia, com creatinina estável de 1,5 mg/dL e hemograma normal há 2 meses. Teve três crises de gota no último ano e, há 4 semanas, outro médico iniciou alopurinol 300 mg/dia, com colchicina 0,5 mg/dia como profilaxia. Há 5 dias apresenta febre de 38,4 °C, odinofagia e úlceras orais. Exame físico: FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg, mucosite oral, sem exantema, sem linfonodomegalias, enxerto indolor. Exames: Hb 7,9 g/dL, VCM 108 fL, leucócitos 900/mm³ (neutrófilos 200/mm³), plaquetas 41.000/mm³, reticulócitos 0,2%, creatinina 1,6 mg/dL, AST e ALT normais, eosinófilos ausentes. PCR quantitativo para citomegalovírus no sangue: 380 cópias/mL, mesmo valor de 6 meses antes. A causa mais provável da pancitopenia é:

O DADO QUE DECIDE

há 4 semanas, outro médico iniciou alopurinol 300 mg/dia

Resolução. Transplantado com febre e citopenias é o cenário que puxa citomegalovírus, e há até uma carga viral positiva para reforçar o rótulo. Mas a carga é baixa e estável há 6 meses, sem hepatite, e o que mudou há 4 semanas foi o alopurinol em dose plena. A azatioprina é inativada pela xantina oxidase; o alopurinol bloqueia essa via, desvia a droga para os nucleotídeos de tioguanina e produz mielotoxicidade grave, com macrocitose, aplasia e mucosite, em 2 a 6 semanas. A combinação deve ser evitada, ou a azatioprina reduzida a um quarto da dose com controle rigoroso; no transplantado, o habitual é trocar a azatioprina por micofenolato antes de iniciar o hipouricemiante. A conduta agora é suspender as duas drogas, tratar a neutropenia febril e acompanhar a recuperação medular.

A) Infecção por citomegalovírus ARMADILHA

Errada. Seria a resposta com carga viral alta ou em ascensão, hepatite ou colite; 380 cópias estáveis há 6 meses não explicam aplasia aguda após nova droga.

B) Mielotoxicidade da colchicina

Errada. A colchicina em dose de profilaxia raramente causa aplasia; a toxicidade pede dose alta ou inibidor potente de CYP3A4 e glicoproteína P, e vem com diarreia e miopatia.

C) Interação do alopurinol com a azatioprina CORRETA

Correta. Alopurinol em dose plena com azatioprina, aplasia com macrocitose e mucosite 4 semanas depois: é a interação pela xantina oxidase.

D) Reação de hipersensibilidade ao alopurinol

Errada. A hipersensibilidade grave ao alopurinol tem exantema, eosinofilia, hepatite e piora renal, ausentes aqui.

Para levar. Alopurinol ou febuxostate com azatioprina causam aplasia: troque a azatioprina ou reduza a um quarto da dose. Antes de culpar o vírus no imunossuprimido, olhe a droga que entrou.

ACR 2020 Guideline for the Management of Gout; KDIGO 2009 Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients; bula da azatioprina (interação com inibidores da xantina oxidase).

10

Droga a deduzir

Gabarito C

Neurologia · Crise miastênica precipitada pelo sulfato de magnésio na pré-eclâmpsia

Gestante de 31 anos, 34 semanas, com miastenia gravis generalizada AChR positiva estável com piridostigmina 60 mg de 6/6 h, é internada com PA 168/112 mmHg, cefaleia e proteinúria de 2,1 g/24 h. Recebe nifedipino oral e a medicação padrão para prevenção de eclâmpsia, em dose de ataque IV seguida de infusão contínua. Duas horas depois apresenta ptose bilateral, disfagia, fraqueza cervical e dispneia, com CVF caindo de 2,8 L para 1,4 L. Reflexos patelares presentes, FC 88 bpm, pupilas normais, sem fasciculações, sem sialorreia, lacrimejamento ou cólicas. A causa mais provável da piora é:

O DADO QUE DECIDE

a medicação padrão para prevenção de eclâmpsia

Resolução. A droga não é nomeada: a medicação padrão para prevenir eclâmpsia, em ataque IV e infusão, é o sulfato de magnésio. O magnésio reduz a liberação de acetilcolina na placa e a sensibilidade pós-sináptica, e na miastenia pode precipitar crise mesmo em nível terapêutico (os reflexos presentes mostram que não há intoxicação). A relação temporal de 2 horas decide contra a exacerbação gestacional, que é possível mas não começa em horas após uma droga. Crise colinérgica exigiria excesso de piridostigmina (dose inalterada) e sinais muscarínicos e nicotínicos: miose, sialorreia, cólicas, bradicardia, fasciculações, todos ausentes. Na miastenia, o sulfato de magnésio é relativamente contraindicado: suspender, e prevenir eclâmpsia com outra droga anticrise (levetiracetam é a mais citada), além de tratar a crise (imunoglobulina ou plasmaférese) e vigiar a CVF.

A) Efeito do nifedipino na junção neuromuscular
Errada. Bloqueadores de canal de cálcio têm efeito teórico pequeno; o nifedipino oral não precipita crise com essa intensidade e relação temporal.

B) Exacerbação própria do terceiro trimestre
Errada. A gestação pode piorar a miastenia, sobretudo no primeiro trimestre e no puerpério, mas não explica piora em 2 horas logo após uma droga.

C) Bloqueio neuromuscular pelo sulfato de magnésio CORRETA
Correta. Sulfato de magnésio, a droga padrão contra eclâmpsia, bloqueia a junção neuromuscular e precipita crise miastênica horas após o início.

D) Crise colinérgica pela piridostigmina ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Crise colinérgica vem de excesso de anticolinesterásico e tem miose, sialorreia, cólicas, bradicardia e fasciculações; a dose não mudou e esses sinais estão ausentes.

Para levar. Na miastenia, evitar sulfato de magnésio, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, macrolídeos, betabloqueador e bloqueadores neuromusculares. Na pré-eclâmpsia com miastenia, a profilaxia de eclâmpsia é outra droga.

International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis 2020; FEBRASGO 2023 (pré-eclâmpsia); ACOG 2020.

11

Hematologia · Plasmocitoma ósseo solitário com envolvimento medular mínimo: radioterapia local, não tratamento de mieloma

Limiar **Gabarito A**

Homem de 57 anos procura atendimento por dor lombar há 3 meses, sem déficit neurológico. Ressonância de coluna: lesão expansiva única no corpo vertebral de T11, com componente de partes moles, sem compressão medular e sem instabilidade. Biópsia guiada por tomografia: infiltrado de plasmócitos monoclonais kappa. Exames: Hb 13,8 g/dL, cálcio 9,5 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, pico monoclonal IgG kappa de 0,4 g/dL, razão de cadeias leves livres kappa/lambda de 3,1. PET-CT de corpo inteiro sem outras lesões. Biópsia de medula óssea da crista ilíaca com plasmócitos clonais em 6%. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

plasmócitos clonais em 6%

Resolução. Plasmócitos monoclonais, pico monoclonal e plasmócitos clonais na medula puxam para mieloma, e o reflexo é tratar como mieloma, com indução e transplante. O limiar decide: mieloma exige plasmócitos clonais na medula de 10% ou mais (ou plasmocitoma comprovado) com evento definidor, e aqui há uma lesão única, PET sem outras lesões, nenhum CRAB além da própria lesão e medula com 6%. É plasmocitoma ósseo solitário com envolvimento medular mínimo (abaixo de 10%), categoria do IMWG com risco maior de progressão que o plasmocitoma sem envolvimento medular, mas cujo tratamento continua sendo radioterapia local em dose curativa (cerca de 40 a 50 Gy), que controla a lesão em mais de 80% dos casos. A cirurgia entra só com instabilidade ou compressão medular, ausentes. O seguimento com eletroforese, cadeias leves e imagem detecta a progressão para mieloma.

A) Radioterapia local em dose curativa CORRETA
Correta. Plasmocitoma ósseo solitário com envolvimento medular mínimo (6%) e PET sem outras lesões: radioterapia local curativa.

B) Ressecção cirúrgica isolada da vértebra
Errada. A cirurgia se reserva para instabilidade da coluna ou compressão medular, e mesmo assim se complementa com radioterapia.

C) Indução de mieloma e transplante autólogo ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria o tratamento com plasmócitos medulares de 10% ou mais e evento definidor; com 6% e lesão única, não é mieloma.

D) Observação com eletroforese seriada
Errada. Observar seria o caminho para GMSI; aqui há tumor plasmocitário destrutivo e sintomático, que precisa de tratamento local.

Para levar. Lesão plasmocitária única, PET sem outras lesões e medula com menos de 10% de plasmócitos clonais é plasmocitoma solitário: radioterapia local; com 10% ou mais e evento definidor, é mieloma.

IMWG 2014 criteria (Rajkumar, Lancet Oncol 2014); IMWG 2018 recomendações para plasmocitoma solitário (Caers et al., J Hematol Oncol 2018); NCCN Multiple Myeloma 2025.

12

Limiar **Gabarito B**

Pneumologia · DPOC exacerbador em dupla broncodilatação com eosinófilos abaixo de 100

Homem de 68 anos, ex-tabagista há 5 anos (55 maços-ano), com DPOC em uso regular e com técnica correta de tiotrópio e olodaterol, teve no último ano duas exacerbações tratadas com antibiótico e prednisona em domicílio. Não tem tosse produtiva crônica nem história de asma. Teve pneumonia há 8 meses, tratada em enfermaria. Espirometria pós-broncodilatador: VEF1/CVF 0,52, VEF1 54% do previsto. Eosinófilos no sangue de 70/mm³ e de 80/mm³ em duas dosagens fora de exacerbação. ECG: QTc 420 ms. Audiometria normal. Além de manter a dupla broncodilatação e a reabilitação, a conduta mais adequada para reduzir exacerbações é:

O DADO QUE DECIDE

Eosinófilos no sangue de 70/mm³ e de 80/mm³

Resolução. O reflexo do escalonamento é a tripla terapia, mas aqui o número que escolhe o degrau está escrito: abaixo de 100 por mm³ o corticoide inalatório quase não reduz exacerbações e aumenta pneumonia, que ele já teve. Para exacerbador em LABA e LAMA com eosinófilos baixos, o GOLD indica azitromicina (preferencialmente em ex-tabagistas) ou roflumilaste. O roflumilaste exige VEF1 abaixo de 50% e bronquite crônica, e ele tem VEF1 de 54% sem tosse produtiva. A azitromicina pede QTc normal e audiometria, ambos conferidos no enunciado. Dupilumabe é para eosinófilos de 300 ou mais com bronquite crônica.

A) Acrescentar budesonida inalatória ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Corticoide inalatório é o passo do exacerbador em LABA e LAMA com eosinófilos de 100 ou mais; abaixo de 100, e com pneumonia prévia, não se acrescenta.

B) Acrescentar azitromicina contínua CORRETA

Correta. Exacerbador em dupla broncodilatação, eosinófilos abaixo de 100, ex-tabagista, QTc e audição normais: azitromicina contínua.

C) Acrescentar roflumilaste

Errada. Roflumilaste exige VEF1 abaixo de 50% e fenótipo de bronquite crônica; VEF1 de 54% sem tosse produtiva derruba.

D) Acrescentar dupilumabe

Errada. Dupilumabe é para DPOC com eosinófilos de 300 ou mais e bronquite crônica, em geral já em tripla.

Para levar. No exacerbador em LABA e LAMA, o eosinófilo escolhe o passo: 100 ou mais, tripla com corticoide inalatório; abaixo de 100, azitromicina (de preferência no ex-tabagista) ou roflumilaste (VEF1 abaixo de 50% com bronquite crônica).

GOLD 2025

13

Cardiologia · IC de fração de ejeção preservada com FE de 52%: iSGLT2 como a classe de maior recomendação

Limiar **Gabarito D**

Mulher de 76 anos, hipertensa, obesa (IMC 34 kg/m²), com fibrilação atrial permanente em uso de rivaroxabana e metoprolol, volta ao ambulatório 1 mês após internação por IC descompensada. Hoje em NYHA II, euvolêmica com furosemida 40 mg ao dia, PA 132×78 mmHg, FC 74 bpm. TFG 52 mL/min, potássio 4,4 mEq/L. Ecocardiograma: hipertrofia concêntrica, átrio esquerdo de 52 mm, E/e' de 16, PSAP de 44 mmHg e fração de

ejeção de 52%. NT-proBNP 1.480 pg/mL. Para reduzir nova hospitalização por IC, a medicação a acrescentar com maior nível de recomendação é:

O DADO QUE DECIDE

fração de ejeção de 52%

Resolução. Fração de ejeção de 52% é preservada (50% ou mais), e com hipertrofia concêntrica, átrio grande, E/e' elevado e NT-proBNP alto, o diagnóstico é IC de fração de ejeção preservada. Nela, os pilares da ICFEr não reduzem desfecho: IECA e sacubitril-valsartana têm benefício fraco ou limitado à faixa levemente reduzida. A espironolactona, a resposta da questão antiga do banco, ficou com recomendação fraca (IIb), por um estudo neutro no desfecho principal. Os iSGLT2 (dapagliflozina e empagliflozina) reduziram hospitalização por IC e morte cardiovascular em toda a faixa de fração de ejeção acima de 40% e são hoje a classe de recomendação mais alta na ICFEp. Ler o número da FE antes de aplicar a regra é o que separa as quatro.

A) Enalapril

Errada. O IECA é pilar da ICFEr; na ICFEp trata a hipertensão, mas não reduz hospitalização por IC.

B) Espironolactona ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. A espironolactona tem recomendação fraca (IIb) na ICFEp, abaixo do iSGLT2; era a melhor resposta antes dos estudos com iSGLT2.

C) Sacubitril-valsartana

Errada. A sacubitril-valsartana teve benefício limítrofe na ICFEp, concentrado na FE entre 45% e 57% e em mulheres, com recomendação fraca.

D) Dapagliflozina CORRETA

Correta. O iSGLT2 reduziu hospitalização por IC na FE acima de 40% e tem a recomendação mais forte na ICFEp; TFG de 52 permite o uso.

Para levar. FE de 50% ou mais é ICFEp, ainda que ela seja 51 a 53%. Na ICFEp, a classe de maior recomendação é o iSGLT2; diurético para congestão e controle de comorbidades, e espironolactona e sacubitril-valsartana são recomendações fracas.

ESC 2023 (focused update on heart failure); AHA/ACC/HFSA 2022 (heart failure); EMPEROR-Preserved (NEJM 2021); DELIVER (NEJM 2022)

---

14 Oncologia · Agitação no fim de vida: retenção urinária por anticolinérgico antes de rotular delirium terminal

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 79 anos com adenocarcinoma de próstata metastático para ossos, em cuidados de fim de vida domiciliares (PPS 30%), usa morfina de liberação regular 10 mg a cada 4 horas há 3 semanas, sem mudança de dose, e recebeu ontem à noite, por insônia, amitriptilina 25 mg prescrita pelo plantão. Há 8 horas está agitado, tenta sair da cama, puxa o cateter de hipodermóclise e geme ao ser tocado no abdome. Exame: Tax 36,7 °C, FC 104 bpm, PA 150 × 90 mmHg, desatento, sem mioclonias; massa suprapúbica dolorosa, macicez até a cicatriz umbilical; última diurese há 10 horas. Glicemia capilar 118 mg/dL. A causa mais provável da agitação é:

O DADO QUE DECIDE

massa suprapúbica dolorosa, macicez até a cicatriz umbilical

Resolução. Paciente em fim de vida que fica agitado e desatento parece estar em delirium terminal, e a resposta automática é sedar com haloperidol ou midazolam. Mas delirium terminal é diagnóstico de exclusão, depois de afastadas as causas reversíveis, e a mais simples está no exame: globo vesical até a cicatriz umbilical e 10 horas sem diurese. A amitriptilina de ontem (anticolinérgico), somada à morfina e à próstata, explica a retenção. A conduta é cateterismo vesical e suspensão da amitriptilina, e a agitação costuma ceder em minutos. Neurotoxicidade por morfina exigiria aumento de dose, desidratação ou piora renal e traria mioclonias, que não há.

A) Retenção urinária aguda CORRETA

Correta. Globo vesical doloroso e 10 horas sem diurese após anticolinérgico, em homem com doença prostática: retenção urinária causando a agitação.

B) Dor óssea não controlada

Errada. Dor óssea mal controlada causaria agitação, mas a dor está no abdome, sobre a bexiga distendida.

C) Neurotoxicidade por morfina

Errada. A dose de morfina está estável há 3 semanas, sem mioclonias e sem piora renal descrita.

D) Delirium terminal ARMADILHA

Errada. É a isca: delirium terminal só se diagnostica após afastar causas reversíveis, e há uma evidente no exame.

Para levar. Agitação no fim de vida: antes de sedar, procure globo vesical, fecaloma, dor, hipoxemia e droga anticolinérgica.

NICE NG31: Care of dying adults in the last days of life (2015); ESMO Clinical Practice Guidelines on delirium in adult cancer patients (2018)

---

15 Infectologia · Paracoccidioidomicose no tabagista etilista: o exame que confirma sem biópsia

Qualificador **Gabarito A**

Homem de 52 anos, lavrador desde a infância no interior do estado do Rio de Janeiro, tabagista de 40 maços-ano e etilista, procura atendimento por lesões dolorosas na boca há 4 meses, com dificuldade para mastigar, rouquidão, tosse e perda de 10 kg. Exame: lesões ulceradas de fundo granuloso com pontilhado hemorrágico fino em gengiva, palato e lábio inferior; linfonodos submandibulares de 2 cm, endurecidos; estertores esparsos à ausculta. Radiografia de tórax: infiltrado reticulonodular bilateral e simétrico em campos médios, com ápices e bases poupados. Baciloscopia de escarro negativa em 2 amostras. Anti-HIV não reagente. O exame que, isoladamente, pode confirmar o diagnóstico mais provável de forma mais rápida e menos invasiva é:

O DADO QUE DECIDE

pontilhado hemorrágico fino

Resolução. Tabagismo pesado, etilismo, úlcera oral, rouquidão e linfonodo endurecido evocam carcinoma epidermoide de boca e laringe, e com ele a biópsia. O comando, porém, pede o exame que, isoladamente, confirma de forma mais rápida e menos invasiva, e o quadro é de paracoccidioidomicose crônica: lavrador,

úlceras de fundo granuloso com pontilhado hemorrágico, acometimento multifocal da mucosa e infiltrado pulmonar bilateral simétrico em campos médios. O exame micológico direto do raspado da lesão (ou do escarro) mostrando leveduras com múltiplos brotamentos confirma o diagnóstico na hora, sem procedimento. A biópsia também confirma, mas é mais demorada e invasiva, e fica para quando o direto é negativo ou a dúvida com neoplasia persiste. A sorologia apoia o diagnóstico e serve ao seguimento, mas sozinha não confirma. O tratamento é itraconazol (ou sulfametoxazol-trimetoprima) por meses.

A) Exame micológico direto do raspado CORRETA
Correta. Leveduras com múltiplos brotamentos no raspado confirmam a paracoccidioidomicose de imediato, sem procedimento invasivo.

B) Biópsia da lesão com histopatologia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a biópsia seria o exame se a lesão fosse única e a hipótese principal fosse carcinoma; aqui confirma, mas não é o mais rápido nem o menos invasivo.

C) Sorologia por imunodifusão dupla
Errada. A imunodifusão apoia o diagnóstico e mede resposta ao tratamento, mas não confirma isoladamente.

D) TRM-TB no escarro
Errada. TRM-TB caberia se a hipótese fosse tuberculose laríngea e pulmonar; o padrão pulmonar poupando ápices e as lesões orais apontam a micose.

Para levar. Úlcera oral granulosa com pontilhado hemorrágico em trabalhador rural é paracoccidioidomicose até prova em contrário: o micológico direto do raspado confirma antes da biópsia.

II Consenso Brasileiro em Paracoccidioidomicose (Rev Soc Bras Med Trop, 2017).

---

16 Nefrologia · Poliúria abrupta em usuária de lítio com câncer de mama · teste da desmopressina: diabetes insípido central

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 52 anos, com transtorno bipolar em uso de carbonato de lítio há nove anos (litemia de 0,6 mEq/L há um mês) e carcinoma de mama tratado há três anos, em uso de tamoxifeno, procura atendimento por sede intensa e diurese de cerca de 6 litros por dia, iniciadas de forma abrupta há cinco semanas. Exames: glicemia de jejum 92 mg/dL, cálcio 9,4 mg/dL, potássio 4,1 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, sódio 145 mEq/L. Teste de restrição hídrica: após seis horas, sódio 148 mEq/L, osmolalidade plasmática 304 mOsm/kg e osmolalidade urinária 140 mOsm/kg. Uma hora após 2 µg de desmopressina subcutânea, a osmolalidade urinária subiu para 460 mOsm/kg. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

a osmolalidade urinária subiu para 460 mOsm/kg

Resolução. Lítio há nove anos e poliúria é a associação que todo candidato conhece, e o rótulo empurra para o diabetes insípido nefrogênico. Mas o teste da desmopressina decide: no nefrogênico o rim não responde ao hormônio, e a osmolalidade urinária sobe menos de 10% na forma completa (entre 10 e 50% fica a zona cinzenta das formas parciais, central ou nefrogênica); aqui ela foi de 140 para 460 mOsm/kg, mais de 200%, o que só acontece quando o receptor V2 funciona e falta o ADH: diabetes insípido central (deficiência de arginina vasopressina, na nomenclatura de 2022). O início abrupto também não é o do lítio, que instala o

defeito de concentração aos poucos, ao longo de anos. Com antecedente de carcinoma de mama, a primeira hipótese é metástase para a neuro-hipófise ou a haste (mama e pulmão são as fontes mais comuns), e o próximo passo é ressonância de sela. A polidipsia primária concentraria a urina com a restrição antes de o sódio subir, e não há glicosúria ou carga de soluto para diurese osmótica.

A) Polidipsia primária
Errada. Na polidipsia primária a restrição concentra a urina antes de o sódio subir; aqui o sódio passou de 145 para 148 com urina diluída.

B) Diabetes insípido nefrogênico pelo lítio ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a resposta se a osmolalidade urinária pouco subisse após a desmopressina; o aumento de mais de 200% mostra um rim que responde ao ADH.

C) Diurese osmótica
Errada. Diurese osmótica exige carga de soluto (glicose, ureia, manitol) e urina com osmolalidade próxima à plasmática; a urina é hipotônica e a glicemia é normal.

D) Diabetes insípido central CORRETA
Correta. Urina diluída com plasma hiperosmolar que se concentra mais de 50% com desmopressina é diabetes insípido central; neste contexto, metástase hipofisária de carcinoma de mama.

Para levar. Após a restrição hídrica, a desmopressina separa: aumento da osmolalidade urinária acima de 50% indica diabetes insípido central, abaixo de 10% indica nefrogênico, e entre os dois é zona cinzenta das formas parciais. O lítio em uso não impede o diagnóstico de diabetes insípido central.

Fenske et al., NEJM 2018 (copeptina no diagnóstico do diabetes insípido); Consenso de nomenclatura AVP-D e AVP-R (2022); Harrison 21ª ed. (Posterior Pituitary).

17

Endocrinologia · Hipofisite por imunoterapia combinada: eixo central e ordem da reposição

Grade X / Y

Gabarito D

Homem de 58 anos, com melanoma metastático, recebe ipilimumabe e nivolumabe há dez semanas. Há duas semanas tem cefaleia, astenia intensa, anorexia e náuseas. Sem febre ou diarreia. Exame: PA 96/60 mmHg, FC 104 bpm, sem hiperpigmentação, tireoide sem bócio. Exames: sódio 128 mEq/L, potássio 4,4 mEq/L, glicemia 72 mg/dL, cortisol às 8 horas 1,9 µg/dL, ACTH 6 pg/mL (10 a 60), TSH 0,22 µUI/mL (0,4 a 4,5), T4 livre 0,6 ng/dL (0,8 a 1,8), testosterona baixa com LH baixo. Ressonância de sela: aumento difuso e homogêneo da hipófise, com espessamento da haste. O diagnóstico e a primeira medida terapêutica são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

cortisol às 8 horas 1,9 µg/dL, ACTH 6 pg/mL (10 a 60)

Resolução. Tireoidite é o evento endócrino mais frequente dos inibidores de checkpoint, e TSH baixo com T4 livre baixo pode ser lido como a transição de uma tireoidite destrutiva para o hipotireoidismo, levando à levotiroxina. O que decide é o eixo adrenal: cortisol de 1,9 com ACTH baixo é insuficiência adrenal central, e junto com hipogonadismo hipogonadotrófico, hipotireoidismo central e hipófise aumentada na ressonância fecha hipofisite, mais associada ao anti-CTLA-4 (ipilimumabe), sobretudo em combinação. O potássio normal e a pele sem hiperpigmentação confirmam que a adrenal está íntegra. A ordem é a mesma de todo hipopituitarismo: hidrocortisona primeiro, e levotiroxina só alguns dias depois, porque o hormônio tireoidiano

antes do cortisol pode precipitar crise adrenal. Dose alta de glicocorticoide só para efeito de massa grave; a imunoterapia em geral pode continuar.

A) Tireoidite por imunoterapia / levotiroxina ARMADILHA
Errada. Erra nas duas metades: ACTH baixo e hipófise aumentada indicam doença central, e levotiroxina antes do cortisol arrisca crise adrenal.

B) Hipofisite / levotiroxina
Errada. O diagnóstico está certo, mas a levotiroxina antes da hidrocortisona inverte a ordem.

C) Tireoidite por imunoterapia / hidrocortisona
Errada. A medida está certa, mas tireoidite não explica cortisol e ACTH baixos nem a hipófise aumentada.

D) Hipofisite / hidrocortisona CORRETA
Correta. Hipofisite por anti-CTLA-4 com deficiência de ACTH, TSH e gonadotrofinas: repor hidrocortisona antes da levotiroxina.

Para levar. Sob imunoterapia, TSH baixo com T4 livre baixo é hipotireoidismo central até prova em contrário: dose cortisol e ACTH, e reponha hidrocortisona antes da levotiroxina.

ASCO Guideline: Management of Immune-Related Adverse Events 2021; ESMO Clinical Practice Guideline on toxicities from immunotherapy 2022; Endocrine Society, Hypopituitarism 2016.

---

18 Reumatologia · Osteomalácia pós-bariátrica tratada como osteoporose com alendronato

Dado omitido **Gabarito A**

Mulher de 52 anos, submetida a gastroplastia com derivação em Y de Roux há 9 anos, procura atendimento por dor óssea difusa em quadris, costelas e pernas há 8 meses, com dificuldade para subir escadas e marcha anserina. Há 1 ano, por T-escore de -2,8 em colo femoral, outro médico iniciou alendronato 70 mg/semana e carbonato de cálcio 500 mg/dia, com piora progressiva da dor desde então. Usa polivitamínico de forma irregular. Exame físico: dor à compressão do esterno e das costelas, força 4 em flexores do quadril. Exames: cálcio 8,3 mg/dL (albumina 3,9 g/dL), fósforo 2,1 mg/dL, fosfatase alcalina 410 U/L (VR até 120), GGT normal, PTH 168 pg/mL, creatinina 0,7 mg/dL, calciúria 40 mg/24 h. Radiografia de bacia: faixas radiotransparentes perpendiculares à cortical nos ramos púbicos, bilaterais e simétricas. O diagnóstico que explica a piora é:

O DADO QUE DECIDE
fósforo 2,1 mg/dL, fosfatase alcalina 410 U/L (VR até 120)

Resolução. O T-escore de -2,8 é o rótulo que leva a falar em osteoporose e, com a piora, em falha do bisfosfonato. Mas osteoporose não dói difusamente sem fratura e não mexe no laboratório: aqui há cálcio baixo, fósforo baixo, fosfatase alcalina quatro vezes acima com GGT normal (origem óssea), PTH alto e calciúria baixa. Esse é o perfil da osteomalácia por deficiência de vitamina D e de cálcio após derivação em Y de Roux, que exclui o duodeno e o jejuno proximal; a 25-hidroxivitamina D nem precisou ser mostrada. As faixas radiotransparentes bilaterais e simétricas nos ramos púbicos são pseudofraturas (zonas de Looser), e a densitometria baixa reflete osso pouco mineralizado, não perda de massa. O antirreabsortivo piora o quadro, porque reduz a remodelação de um osso que não mineraliza e agrava a hipocalcemia. A conduta é suspender o alendronato e repor vitamina D em dose alta com citrato de cálcio, que é absorvido sem ácido gástrico; densitometria e indicação de antirreabsortivo só depois da correção.

A) Osteomalácia por má absorção CORRETA

Correta. Bariátrica disabsortiva, dor óssea difusa, miopatia proximal, hipocalcemia, hipofosfatemia, fosfatase alta, PTH alto e zonas de Looser.

B) Osteoporose refratária ao bisfosfonato ARMADILHA

Errada. Seria pensada com laboratório normal e fratura nova sob tratamento; com fósforo baixo, fosfatase alta e PTH alto, a densitometria baixa é de osteomalácia.

C) Hiperparatireoidismo primário

Errada. O hiperparatireoidismo primário tem cálcio alto ou normal-alto com PTH alto; aqui o cálcio é baixo e o PTH alto é secundário.

D) Fratura atípica por bisfosfonato

Errada. A fratura atípica é subtrocantérica ou diafisária, na cortical lateral do fêmur, após anos de bisfosfonato; não explica o laboratório nem as faixas púbicas simétricas.

Para levar. Densitometria baixa com fosfatase alcalina e PTH altos e fósforo baixo é osteomalácia: corrija vitamina D e cálcio (citrato na bariátrica) e só depois pense em antirreabsortivo.

AACE/TOS/ASMBS 2019 clinical practice guidelines for perioperative nutritional and metabolic support of bariatric patients; Manual Brasileiro de Osteoporose: orientações práticas (2021); Endocrine Society 2024 vitamin D guideline.

19

Hematologia · Síndrome mielodisplásica de baixo risco dependente de transfusão: eritropoetina sérica abaixo de 500

Limiar **Gabarito D**

Homem de 74 anos, hipertenso, tem anemia macrocítica há 1 ano e passou a precisar de 2 concentrados de hemácias por mês nos últimos 3 meses. Não há sangramento. Vitamina B12, folato, cobre, TSH e função hepática normais; não consome álcool nem usa drogas mielotóxicas. Mielograma: medula hipercelular, diseritropoese em 30% dos eritroblastos, blastos 2%, sem sideroblastos em anel. Cariótipo normal, sem mutação de SF3B1 ou TP53. Hemograma: Hb 7,9 g/dL, VCM 104 fL, neutrófilos 2.100/mm³, plaquetas 160.000/mm³. IPSS-R de baixo risco (2,5 pontos). Eritropoetina sérica endógena de 140 U/L e ferritina de 620 ng/mL. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Eritropoetina sérica endógena de 140 U/L

Resolução. Diagnóstico firmado (displasia eritroide acima de 10%, blastos abaixo de 5%, causas secundárias excluídas), a decisão é pelo risco: IPSS-R baixo. A armadilha é tratar a SMD como neoplasia agressiva, com hipometilante ou transplante, que são para alto risco. No baixo risco o objetivo é a anemia, e o limiar que decide é a eritropoetina endógena: abaixo de 500 U/L a resposta aos agentes estimuladores da eritropoese é boa (e melhor ainda com necessidade transfusional baixa), e ele tem 140. A quelação de ferro entra com ferritina acima de 1.000 a 2.500 em quem tem expectativa de vida longa, e não trata a anemia. O luspatercepte é alternativa nesse cenário, sobretudo com sideroblastos em anel, e o hipometilante fica para falha.

A) Azacitidina subcutânea ARMADILHA

Errada. É a armadilha: azacitidina é para SMD de alto risco ou baixo risco refratário; aqui a primeira linha é estimular a eritropoese.

B) Transplante alogênico de medula

Errada. O transplante é a única cura, mas se reserva ao alto risco em candidato elegível; em baixo risco aos 74 anos o risco supera o benefício.

C) Quelação de ferro isolada

Errada. A ferritina de 620 não indica quelação, que de todo modo não corrige a anemia.

D) Alfaepoetina CORRETA

Correta. SMD de baixo risco, dependente de transfusão, com eritropoetina endógena de 140 (abaixo de 500): agente estimulador da eritropoese.

Para levar. SMD de baixo risco com anemia sintomática e eritropoetina sérica abaixo de 500 U/L: agente estimulador da eritropoese (ou luspatercepte); hipometilante e transplante são do alto risco.

NCCN Myelodysplastic Syndromes 2025; ESMO 2021 Clinical Practice Guidelines para SMD; IPSS-R (Greenberg, 2012).

20

Neurologia · Paralisia facial central que acorda com o paciente: testa poupada derruba a paralisia de Bell

Negativo no meio | Gabarito D

Homem de 66 anos, hipertenso e tabagista, acorda às 7 h com a boca 'torta' para a esquerda e babando ao beber café; foi dormir às 23 h sem queixas, após dormir com a janela aberta numa noite fria. Nega dor retroauricular, hiperacusia e alteração do paladar. Exame: apagamento do sulco nasolabial direito e queda da comissura labial à direita; franze a testa e eleva as sobrancelhas simetricamente e fecha os olhos com força igual dos dois lados; disartria discreta; força 5/5 e coordenação normal nos membros. PA 172/96 mmHg, glicemia 118 mg/dL, otoscopia normal. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

franze a testa e eleva as sobrancelhas simetricamente

Resolução. Noite fria, janela aberta e boca torta ao acordar montam o cenário de paralisia de Bell, e a resposta reflexa é corticoide, com ou sem antiviral. O dado que decide é um negativo do exame: a musculatura frontal e o orbicular dos olhos estão preservados. A porção superior da face recebe inervação cortical bilateral; por isso a lesão do neurônio motor superior poupa a testa, enquanto a do nervo facial (Bell) paralisa a hemiface inteira. Paralisia facial que poupa a testa, ainda que isolada e só com disartria discreta (que a própria paralisia facial causa), em hipertenso tabagista, é AVC até prova em contrário. Como acordou com o déficit, o último momento bem é 23 h, e a neuroimagem urgente (TC e angiotomografia, ou RM com difusão e FLAIR) define o diagnóstico e a elegibilidade para reperfusão. Corticoide aqui atrasaria o protocolo de AVC.

A) Prednisona oral por 10 dias

Errada. Prednisona nas primeiras 72 horas é o tratamento da paralisia de Bell, que acomete a hemiface inteira, inclusive a testa.

B) Prednisona com valaciclovir oral ARMADILHA

Errada, é a armadilha. O antiviral associado ao corticoide é considerado na Bell grave, mas o quadro não é de Bell: a testa está poupada, o que localiza a lesão acima do núcleo do facial.

C) Eletroneuromiografia em 72 horas

Errada. ENMG estima prognóstico da paralisia periférica completa após 72 horas a 2 semanas; não é exame de lesão central.

D) Neuroimagem de crânio com urgência CORRETA

Correta. Paralisia facial central (testa poupada), instalada durante o sono em vascular: neuroimagem urgente pelo protocolo de AVC.

Para levar. Paralisia facial que poupa a testa é central: protocolo de AVC, não corticoide. Bell paralisa a hemiface inteira.

AAO-HNS 2013 (paralisia de Bell); AAN 2012; AHA/ASA 2026 (AVC isquêmico agudo).

---

21 Gastroenterologia · Pancreatite biliar leve sem colangite: sem CPRE e colecistectomia na mesma internação

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 52 anos, sem comorbidades, está internada há 36 horas por pancreatite aguda biliar (lipase 2.400 U/L; ultrassonografia com colelitíase múltipla, colédoco de 7 mm, sem cálculo visível no colédoco). Na admissão: bilirrubina total 3,1 mg/dL, fosfatase alcalina 260 U/L, ALT 410 U/L. Recebeu Ringer lactato em ritmo moderado e analgesia, e já aceita dieta oral leve. Hoje: Tax 36,8 °C, FC 84 bpm, PA 124 × 78 mmHg, anictérica, dor abdominal leve. Exames: leucócitos 9.800/mm³, bilirrubina total 1,4 mg/dL, ALT 190 U/L, creatinina 0,8 mg/dL. Escore BISAP 1. Quanto à CPRE e ao momento da colecistectomia, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

bilirrubina total 1,4 mg/dL

Resolução. A bilirrubina de 3,1 e o colédoco de 7 mm na admissão puxam para CPRE, e é o reflexo de fazer mais. A CPRE de urgência na pancreatite biliar só se indica com colangite; com suspeita de obstrução persistente sem colangite, a decisão vem depois de colangiorressonância ou ecoendoscopia. Aqui não há febre, a bilirrubina caiu de 3,1 para 1,4 e as enzimas caem: o cálculo passou. CPRE sem indicação acrescenta pancreatite pós-CPRE, sangramento e perfuração sem reduzir mortalidade. A outra metade é o momento da colecistectomia: na pancreatite leve ela se faz na mesma internação, porque adiar por semanas multiplica a recorrência de eventos biliares (estudo PONCHO); esperar cerca de 6 semanas é para a pancreatite necrosante com coleções.

A) CPRE em 24 horas / após 6 semanas

Errada nas duas metades: CPRE sem colangite e colecistectomia adiada, que seriam condutas da colangite associada à pancreatite necrosante.

B) CPRE em 24 horas / na mesma internação ARMADILHA

Errada. É a isca: a colecistectomia na mesma internação está certa, mas a CPRE não tem indicação sem colangite e com bilirrubina em queda.

C) Sem CPRE / após 6 semanas

Errada. Dispensar a CPRE está certo, mas adiar a colecistectomia por 6 semanas na pancreatite leve aumenta a recorrência de eventos biliares.

D) Sem CPRE / na mesma internação CORRETA

Correta. Sem colangite e com bilirrubina caindo para 1,4, não há CPRE; pancreatite leve, colecistectomia antes da alta.

Para levar. Pancreatite biliar: CPRE urgente só com colangite; na forma leve, colecistectomia na mesma internação; na necrosante, adiar até a resolução das coleções.

ACG Guideline: Management of Acute Pancreatitis (2024); IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis (2013); PONCHO (Lancet, 2015)

22

Pneumologia · Pletismografia: CVF reduzida por aprisionamento aéreo em usuário de amiodarona

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 70 anos, ex-tabagista (50 maços-ano), em uso de amiodarona 200 mg/dia há 3 anos por fibrilação atrial, refere dispneia progressiva há 1 ano. Nega tosse, febre e perda de peso. Exame: tórax em tonel, murmúrio vesicular difusamente reduzido, sem estertores em velcro, sem baqueteamento. TC de tórax: enfisema centrolobular nos lobos superiores, sem reticulado, vidro fosco ou faveolamento. Espirometria pós-broncodilatador: CVF 60% do previsto, VEF1 57% do previsto, VEF1/CVF 0,72. Pletismografia: CPT 116% do previsto, VR 205% do previsto, VR/CPT 0,64. DLCO 48% do previsto. O distúrbio funcional que explica a redução da CVF é:

O DADO QUE DECIDE

CPT 116% do previsto, VR 205% do previsto

Resolução. CVF baixa com relação VEF1/CVF acima de 0,70 parece restrição, e a amiodarona oferece a causa, com DLCO baixa para confirmar. Mas restrição se define por CPT reduzida, e a CPT aqui é de 116%. O que reduziu a CVF foi o volume residual de 205%, com VR/CPT de 0,64: o ar fica preso no fim da expiração, a capacidade vital encolhe e a relação VEF1/CVF se pseudonormaliza, porque o denominador também caiu. A DLCO baixa vem do enfisema, que a TC mostra, e não exige toxicidade pulmonar, que daria vidro fosco ou reticulado, ausentes. É o padrão de hiperinsuflação e aprisionamento da DPOC com enfisema.

A) Distúrbio misto obstrutivo e restritivo

Errada. Distúrbio misto exige relação reduzida e CPT reduzida ao mesmo tempo; a CPT é de 116%.

B) Aprisionamento aéreo por obstrução CORRETA

Correta. CPT normal ou alta com VR de 205% e VR/CPT de 0,64: aprisionamento aéreo reduzindo a CVF e pseudonormalizando a relação VEF1/CVF.

C) Restrição parenquimatosa por amiodarona ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. A droga existe e dá pneumonite intersticial, mas restrição exige CPT abaixo do limite inferior, e a TC não mostra reticulado nem vidro fosco.

D) Restrição extraparenquimatosa
Errada. Obesidade, deformidade torácica ou doença neuromuscular reduzem a CPT com DLCO normal ou corrigida alta; aqui a CPT está aumentada e a DLCO baixa.

Para levar. CVF baixa com relação normal não é restrição até a CPT confirmar; VR alto com CPT normal ou alta é aprisionamento aéreo, que pseudonormaliza a relação.

ATS/ERS 2022 (interpretação de testes de função pulmonar); GOLD 2025; Diretrizes SBPT para testes de função pulmonar (2002)

---

23 Infectologia · Meningite pneumocócica: contactantes não recebem quimioprofilaxia

Omissão **Gabarito B**

Homem de 45 anos é internado com meningite; o Gram do líquor mostra diplococos Gram-positivos e a cultura identifica Streptococcus pneumoniae. Mora com a esposa e dois filhos de 8 e 12 anos, vacinados conforme o calendário, e divide uma sala fechada com três colegas de trabalho. Quanto à quimioprofilaxia dos contactantes, o correto é:

O DADO QUE DECIDE

a cultura identifica Streptococcus pneumoniae

Resolução. Meningite com contactantes evoca a rifampicina, porque é o que se faz na doença meningocócica e na meningite por Haemophilus influenzae tipo b. O agente aqui é o pneumococo, que não causa surtos entre contactantes nem tem portador nasofaríngeo que a profilaxia elimine com benefício. Por isso não há quimioprofilaxia para nenhum contactante na meningite pneumocócica; a prevenção é vacinal, conforme o calendário e as indicações do CRIE. A equipe de saúde, mesmo na meningocócica, só recebe profilaxia se teve contato com secreção respiratória sem proteção, como na intubação.

A) Rifampicina para os domiciliares ARMADILHA
Errada. É a armadilha: rifampicina para contactantes íntimos seria a conduta na doença meningocócica ou por Hib; no pneumococo não há indicação.

B) Não indicada para nenhum contactante CORRETA
Correta. Meningite pneumocócica não exige quimioprofilaxia de contactantes.

C) Ciprofloxacino para domiciliares e colegas
Errada. Ciprofloxacino em dose única é alternativa na doença meningocócica, e mesmo nela colegas de trabalho só entram se houve contato íntimo prolongado.

D) Ceftriaxona dose única para os filhos
Errada. Ceftriaxona em dose única é a alternativa para gestantes na profilaxia meningocócica, não para contactantes de pneumococo.

Para levar. Quimioprofilaxia de contactantes existe para meningococo e Hib; para pneumococo, não.

Guia de Vigilância em Saúde (MS, 6ª edição, 2023), capítulo de meningites.

---

24 Cardiologia · Febre reumática com cardite e IM leve residual: duração da profilaxia secundária

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 24 anos teve o primeiro e único surto de febre reumática aos 16 anos, com cardite, e ficou com insuficiência mitral leve, estável nos ecocardiogramas anuais. Usa penicilina G benzatina a cada 21 dias, sem falhas. Pela diretriz brasileira, a profilaxia secundária deve ser mantida até:

O DADO QUE DECIDE

aos 16 anos, com cardite, e ficou com insuficiência mitral leve

Resolução. A duração da profilaxia secundária tem três degraus, e cada um tem duas condições, valendo a que cobrir maior período. Sem cardite: até os 21 anos ou 5 anos após o último surto. Cardite prévia com insuficiência mitral leve residual ou com regressão da lesão: até os 25 anos ou 10 anos após o último surto. Lesão residual moderada ou grave: até os 40 anos ou por toda a vida; após cirurgia valvar, por toda a vida. Ela está no degrau do meio, e quem lembra só de 'até os 25 anos' marca a armadilha: o último surto foi aos 16, e 10 anos depois são 26, que cobre mais tempo.

A) Os 21 anos, já cumpridos
Errada. Até os 21 anos (ou 5 anos após o surto) é para febre reumática sem cardite.

B) Os 25 anos ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Os 25 anos são metade da regra; os 10 anos após o surto (aos 26) cobrem período maior e prevalecem.

C) Os 26 anos CORRETA
Correta. Cardite com IM leve residual: 25 anos ou 10 anos após o último surto, o que for maior; surto aos 16 dá 26 anos.

D) Os 40 anos
Errada. Até os 40 anos ou por toda a vida é para lesão residual moderada ou grave.

Para levar. Profilaxia secundária da febre reumática: sem cardite, 21 anos ou 5 anos após o surto; cardite com lesão leve ou regredida, 25 anos ou 10 anos após; lesão moderada ou grave, 40 anos ou a vida toda. Sempre o que cobrir maior período.

Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Febre Reumática (SBC 2009); AHA Scientific Statement 2009 e WHF 2023

---

25 Nefrologia · Creatinina e potássio subindo após IECA na doença renal do diabetes · elevação de até 30% é aceitável

Omissão **Gabarito C**

Homem de 66 anos, com diabetes tipo 2, hipertensão e doença renal crônica (TFGe 46 mL/min/1,73 m², relação albumina/creatinina 480 mg/g), em uso de anlodipino, metformina e dapagliflozina. Há três semanas iniciou ramipril, titulado para 10 mg/dia. Nega anti-inflamatório, diarreia ou vômitos. Exame: PA 132/80 mmHg (era 154/92), sem hipotensão postural, sem edema, sem sopro abdominal. Nunca teve edema agudo de pulmão. Exames de hoje comparados aos de antes do ramipril: creatinina de 1,40 para 1,70 mg/dL, potássio de 4,9 para

5,4 mEq/L, bicarbonato 23 mEq/L, relação albumina/creatinina de 480 para 210 mg/g. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

creatinina de 1,40 para 1,70 mg/dL

Resolução. Creatinina subindo e potássio de 5,4 depois de um IECA levam o apressado a suspender a droga. Mas o IECA dilata a arteríola eferente e reduz a pressão intraglomerular, e uma elevação de até 30% da creatinina nas primeiras semanas é esperada e marca o efeito nefroprotetor, confirmado aqui pela albuminúria que caiu de 480 para 210 mg/g. A elevação foi de 21% (1,40 para 1,70). A KDIGO 2024 orienta manter o IECA ou BRA e só reavaliar se a creatinina subir mais de 30% em quatro semanas, situação em que se procuram depleção, nefrotóxico ou estenose bilateral de artéria renal. O potássio de 5,4 também não obriga a suspender: maneja-se com orientação dietética individualizada, diurético ou quelante de potássio, e o bloqueio do sistema renina-angiotensina só é reduzido se a hipercalemia não for controlada pelas outras medidas. A dapagliflozina que ele já usa ainda reduz o risco de hipercalemia.

A) Suspender o ramipril ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Suspender seria a conduta com elevação acima de 30%, hipercalemia refratária ou acima de 6 mEq/L, ou depleção de volume; aqui a elevação é de 21% e o potássio é 5,4.

B) Trocar o ramipril por losartana
Errada. Trocar IECA por BRA não muda o efeito hemodinâmico nem o potássio, porque as duas classes agem na mesma via.

C) Manter o ramipril e repetir exames CORRETA
Correta. Elevação de 21% com potássio de 5,4 e albuminúria em queda: manter a dose e repetir creatinina e potássio em duas a quatro semanas.

D) Investigar estenose de artéria renal
Errada. Estenose de artéria renal entra em suspeita com elevação acima de 30%, edema agudo de pulmão súbito, assimetria renal ou hipertensão refratária; nada disso está presente.

Para levar. Com IECA ou BRA, creatinina subindo até 30% é esperada: mantenha a droga. Potássio até 5,5 se maneja com outras medidas antes de suspender o bloqueio.

KDIGO 2024 (Evaluation and Management of CKD); KDIGO 2021 (Blood Pressure in CKD); Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (SBC 2020).

---

26 Endocrinologia · Tireoidite subaguda tratada com metimazol: destruição, não síntese

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 42 anos procurou a UPA há cinco dias por palpitações e foi medicada com metimazol 20 mg/dia e propranolol. Retorna com piora de dor na região anterior do pescoço, irradiada para a mandíbula e o ouvido esquerdo, iniciada três semanas após um quadro gripal, e febre baixa. Usou ibuprofeno 600 mg três vezes ao dia por quatro dias, sem melhora da dor. Exame: T 37,9 °C, FC 92 bpm, tireoide endurecida, dolorosa à palpação, sem nódulos. Exames: TSH 0,01 µUI/mL, T4 livre 3,4 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 210 ng/dL (80 a 200), VHS 92 mm/h, TRAb negativo, leucócitos 9.800/mm³. Ultrassonografia: áreas hipoecogênicas mal definidas, com fluxo reduzido ao Doppler. Além de manter o propranolol, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

áreas hipoecogênicas mal definidas, com fluxo reduzido ao Doppler

Resolução. O metimazol já prescrito é o rótulo verdadeiro: há tireotoxicose bioquímica franca, e a tendência é manter a tionamida e só somar algo para a dor. Mas a tireoidite subaguda é tireotoxicose por destruição: o hormônio sai pronto do folículo inflamado, e a síntese está desligada (fluxo reduzido ao Doppler, captação baixa se medida, TRAb negativo, VHS de 92). Tionamida bloqueia síntese, não tem efeito aqui e só acrescenta risco e hipotireoidismo posterior. O tratamento é sintomático: betabloqueador para a adrenérgica e anti-inflamatório para a dor; como o ibuprofeno em dose plena falhou, prednisona (cerca de 40 mg/dia, com retirada em semanas).

A) Manter metimazol e associar prednisona ARMADILHA
Errada. A prednisona está certa, mas o metimazol não tem papel na tireotoxicose destrutiva.

B) Suspender metimazol e iniciar prednisona CORRETA
Correta. Na tireoidite subaguda, a tionamida não age; com falha do anti-inflamatório, prednisona e betabloqueador.

C) Manter metimazol e trocar o anti-inflamatório
Errada. Manter a tionamida não tem base na destruição folicular, e trocar um anti-inflamatório não esteroide por outro após falha não é o passo indicado.

D) Suspender metimazol e programar iodo radioativo
Errada. Iodo radioativo não é captado na glândula inflamada e não tem indicação numa doença autolimitada.

Para levar. Tireotoxicose com tireoide dolorosa, VHS alta e fluxo reduzido é destruição: betabloqueador e anti-inflamatório (prednisona se falhar), nunca tionamida.

ATA Guidelines for Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis 2016; Consenso Brasileiro de Hipertireoidismo SBEM 2013.

27

Reumatologia · Síndrome antissintetase com fator reumatoide positivo imitando artrite reumatoide com pneumopatia

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 49 anos procura atendimento por poliartrite simétrica de mãos e punhos há 4 meses, com rigidez matinal de 1 hora, e, há 6 semanas, tosse seca e dispneia aos médios esforços. Refere febre baixa intermitente e dedos que ficam brancos e roxos no frio. Nega lesões em pálpebras, disfagia e fraqueza para subir escadas. Exame físico: sinovite em metacarpofalângicas e punhos, pele espessada, fissurada e hiperceratótica nas faces radiais dos indicadores e polegares, estertores em velcro bibasais, força muscular grau 5. Exames: fator reumatoide 48 UI/mL (VR < 14), anti-CCP não reagente, FAN 1:160 com padrão citoplasmático pontilhado fino, CK 410 U/L (VR até 170), VHS 50 mm/h. Radiografia de mãos sem erosões. TC de tórax: vidro fosco e reticulação basais e subpleurais, com consolidações peribroncovasculares, padrão de pneumonia intersticial não específica com componente em organização. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

pele espessada, fissurada e hiperceratótica nas faces radiais dos indicadores e polegares

Resolução. Poliartrite simétrica de mãos com fator reumatoide positivo e pneumopatia intersticial é a combinação que leva à artrite reumatoide com doença pulmonar, um tema que ele já errou duas vezes. Mas o restante não é de artrite reumatoide: mãos de mecânico (hiperceratose fissurada na face radial dos dedos), Raynaud, febre, CK discretamente elevada mesmo sem fraqueza e FAN com padrão citoplasmático, que é o padrão dos anticorpos antissintetase como o anti-Jo-1. A pneumopatia também ajuda: na artrite reumatoide predomina a pneumonia intersticial usual, enquanto na antissintetase é a não específica com organização. Artrite, pneumopatia, mãos de mecânico, Raynaud e febre com anticorpo antissintetase fecham a síndrome, que pode ter miosite leve ou ausente. O fator reumatoide em título baixo aparece em várias doenças do tecido conjuntivo, e o anti-CCP negativo e a ausência de erosões enfraquecem a artrite reumatoide. O próximo passo é confirmar com o painel de anticorpos de miosite.

A) Síndrome antissintetase CORRETA
Correta. Artrite, pneumopatia não específica, mãos de mecânico, Raynaud, febre e FAN citoplasmático com CK alta definem a antissintetase.

B) Doença mista do tecido conjuntivo
Errada. A doença mista dá Raynaud, mãos edemaciadas e miosite, mas com FAN nuclear pontilhado em título alto (anti-U1RNP), não citoplasmático.

C) Artrite reumatoide com pneumopatia intersticial ARMADILHA
Errada. Seria a resposta com anti-CCP reagente, erosões e padrão de pneumonia intersticial usual; não explica mãos de mecânico, CK elevada e FAN citoplasmático.

D) Esclerose sistêmica com pneumopatia intersticial
Errada. Não há esclerodactilia nem espessamento cutâneo proximal; a hiperceratose da face radial dos dedos é mão de mecânico, não esclerodermia.

Para levar. Artrite com pneumopatia e mãos de mecânico é antissintetase até prova contrária, mesmo com FR positivo e força normal. FAN citoplasmático é pista do anti-Jo-1.

Critérios de Connors (2010) e de Solomon (2011) para síndrome antissintetase; EULAR/ACR 2017 critérios das miopatias inflamatórias; ACR 2023 ILD in SARD.

28

Hematologia · Pancitopenia megaloblástica por metotrexato associado a sulfametoxazol-trimetoprima: ácido folínico

Droga a deduzir **Gabarito C**

Mulher de 68 anos, com artrite reumatoide há 10 anos e DRC estágio 3b (creatinina basal de 1,7 mg/dL), usa "um remédio semanal, tomado aos domingos, e ácido fólico às segundas", além de prednisona 5 mg/dia. Há 8 dias recebeu na UPA um antibiótico para cistite, de nome que não lembra, "dois comprimidos grandes por dia". Hoje chega com úlceras orais dolorosas, febre de 38,4 °C e equimoses. Exames: Hb 7,9 g/dL, VCM 108 fL, leucócitos 900/mm³ (neutrófilos 300/mm³), plaquetas 22.000/mm³, creatinina 2,1 mg/dL, AST 88 U/L. Esfregaço: neutrófilos hipersegmentados. Além de suspender as drogas e iniciar antibiótico de largo espectro, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

um remédio semanal, tomado aos domingos, e ácido fólico às segundas

Resolução. A droga não foi nomeada, mas o esquema é inconfundível: remédio semanal na artrite reumatoide com ácido fólico no dia seguinte é metotrexato. O antibiótico de "dois comprimidos grandes por dia" para cistite é sulfametoxazol-trimetoprima, que também inibe a di-hidrofolato redutase e reduz a excreção renal do metotrexato; com DRC, a associação produz pancitopenia megaloblástica, mucosite e hepatotoxicidade. O reflexo de quem lê "megaloblástica" é dar ácido fólico, mas o ácido fólico precisa da di-hidrofolato redutase, que está bloqueada, para virar folato ativo. O antídoto é o ácido folínico (leucovorina), que já entra como folato reduzido e contorna o bloqueio. O suporte inclui antibiótico para a neutropenia febril e, em casos graves, fator estimulador de colônias associado, nunca isolado.

A) Ácido fólico em dose alta ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o ácido fólico depende da enzima que o metotrexato e o trimetoprima bloqueiam, e não reverte a toxicidade.

B) Vitamina B12 intramuscular
Errada. Seria a resposta numa megaloblástica por carência de B12; aqui a causa é antifolato, e a B12 não contorna o bloqueio.

C) Ácido folínico endovenoso CORRETA
Correta. Metotrexato potencializado por sulfametoxazol-trimetoprima na DRC: o antídoto é o ácido folínico, que entra após a di-hidrofolato redutase.

D) Filgrastim isolado
Errada. O filgrastim pode ser adjuvante na neutropenia grave, mas isolado não reverte o bloqueio do folato nem trata mucosite e plaquetopenia.

Para levar. Metotrexato com sulfametoxazol-trimetoprima, sobretudo na DRC, causa pancitopenia megaloblástica; o antídoto é o ácido folínico, não o fólico.

ACR 2021 guideline for the treatment of rheumatoid arthritis; UpToDate 2025, Major side effects of low-dose methotrexate.

29

Hepatologia · Insuficiência hepática aguda por doença de Wilson: reconhecer sem ceruloplasmina e indicar transplante

Dado omitido **Gabarito D**

Mulher de 19 anos, previamente hígida, sem uso de medicamentos, chás ou álcool, tem icterícia progressiva há 10 dias e, há 2 dias, sonolência e desorientação. Exame: ictérica, com asterixis, sem estigmas de hepatopatia crônica, Tax 36,9 °C. Exames: hemoglobina 7,9 g/dL, reticulócitos 9%, DHL 980 U/L, teste de Coombs direto negativo, bilirrubina total 28 mg/dL (direta 12 mg/dL), AST 196 U/L, ALT 64 U/L, fosfatase alcalina 22 U/L (40 a 130), INR 3,4, creatinina 1,9 mg/dL. Sorologias para hepatites A, B, C e E negativas, paracetamol sérico indetectável, FAN e antimúsculo liso negativos. O diagnóstico mais provável e a conduta definitiva são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

fosfatase alcalina 22 U/L (40 a 130)

Resolução. Mulher jovem com insuficiência hepática aguda, autoanticorpos negativos e sem droga lembra hepatite autoimune soronegativa, e quem reconhece Wilson tende a prescrever quelante. Os dados que decidem estão no laboratório, sem ceruloplasmina nem anel de Kayser-Fleischer: hemólise com Coombs negativo (o cobre liberado lesa as hemácias), fosfatase alcalina baixa (22 U/L), relação fosfatase

alcalina/bilirrubina total abaixo de 4 e AST/ALT acima de 2,2. Essa combinação tem alta acurácia para Wilson fulminante. Com encefalopatia, INR de 3,4 e lesão renal, o escore prognóstico de Wilson é alto e a mortalidade sem transplante se aproxima de 100%: a conduta definitiva é transplante hepático de urgência. Quelante age em semanas e não resgata a forma fulminante; plasmaférese ou diálise com albumina servem só como ponte.

A) Hepatite autoimune fulminante / pulsoterapia com corticoide
Errada. Hepatite autoimune aguda grave cursa com transaminases muito mais altas, IgG elevada e sem hemólise com fosfatase alcalina baixa; e pulsoterapia não é a conduta com encefalopatia e INR de 3,4.

B) Hepatite autoimune fulminante / transplante hepático de urgência
Errada. Transplante seria a conduta de insuficiência hepática aguda grave de qualquer causa sem resposta, mas hepatite autoimune não explica hemólise com fosfatase alcalina baixa.

C) Doença de Wilson / D-penicilamina ARMADILHA
Errada. É a isca: acerta o diagnóstico e erra o porte; D-penicilamina é para a doença hepática crônica ou compensada, e na forma fulminante não há tempo de resposta.

D) Doença de Wilson / transplante hepático de urgência CORRETA
Correta. Hemólise com Coombs negativo, fosfatase alcalina de 22 com relação FA/bilirrubina menor que 4 e AST/ALT maior que 2,2: Wilson fulminante, transplante de urgência.

Para levar. Insuficiência hepática aguda em jovem com hemólise Coombs negativa, fosfatase alcalina baixa (FA/bilirrubina menor que 4) e AST/ALT maior que 2,2 é Wilson fulminante: transplante.

AASLD Practice Guidance on Wilson disease (2022); EASL Clinical Practice Guidelines on acute (fulminant) liver failure (2017)

30

Neurologia · Distonia aguda (crise oculógira) por metoclopramida em paciente com epilepsia: biperideno, não anticrise

Rótulo verdadeiro | Gabarito A

Homem de 24 anos, com epilepsia focal controlada com carbamazepina (última crise há 3 anos), foi atendido ontem à noite no PS por vômitos após uma festa, recebeu duas doses de metoclopramida 10 mg IV e teve alta com metoclopramida oral. Retorna 14 horas depois, angustiado, porque os olhos 'travam para cima' por vários minutos e o pescoço se estende e gira para a direita contra a vontade. Responde às perguntas durante os episódios e se lembra de tudo; fala com dificuldade pela contração da mandíbula. PA 132/80 mmHg, FC 104 bpm, Tax 36,8 °C, sem rigidez muscular generalizada, sem déficit focal. Glicemia 96 mg/dL, sódio 139 mEq/L. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Responde às perguntas durante os episódios e se lembra de tudo

Resolução. O rótulo é verdadeiro e forte: ele tem epilepsia, e movimento involuntário recorrente no PS puxa para crise e anticrise. Mas olhos que travam para cima, pescoço em extensão e rotação e trismo, com consciência preservada e memória de cada episódio, horas depois de um antagonista dopaminérgico, são distonia aguda (crise oculógira, retrocolo e distonia oromandibular). Crise focal motora com consciência preservada existe, mas não produz desvio ocular sustentado por minutos com postura cervical torcional e não começa justo após metoclopramida. O tratamento é anticolinérgico parenteral (biperideno 2 a 5 mg IV ou IM, ou difenidramina), com melhora em minutos, e suspensão da metoclopramida; mantém-se anticolinérgico

oral por 1 a 2 dias para evitar recorrência. Fenitoína não age sobre distonia, e o controle da epilepsia não mudou.

A) Biperideno IV CORRETA
Correta. Distonia aguda por bloqueio dopaminérgico responde a anticolinérgico parenteral em minutos; suspende-se a metoclopramida.

B) Aumentar a dose de carbamazepina
Errada. Seria considerado se houvesse crises epilépticas por nível baixo de carbamazepina; os episódios não são crises.

C) Dantroleno IV
Errada. Dantroleno se usa na síndrome neuroléptica maligna ou hipertermia maligna, com febre, rigidez generalizada e CPK alta, ausentes aqui.

D) Fenitoína IV em dose de ataque ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Fenitoína seria para crise epiléptica prolongada ou estado de mal; aqui a consciência está preservada, o movimento é distônico e o gatilho é a metoclopramida.

Para levar. Movimento anormal com consciência preservada horas após metoclopramida, haloperidol ou bromoprida é distonia aguda: biperideno IV. Epilepsia prévia não muda isso.

MDS (distúrbios do movimento induzidos por drogas); UpToDate 2026 (Acute dystonia); bula ANVISA da metoclopramida.

31

Medicina baseada em evidências · Valor preditivo positivo de teste bom aplicado em baixa prevalência

Qualificador **Gabarito B**

Um teste para detectar uma doença tem sensibilidade de 90% e especificidade de 90%. Ele será usado como rastreio numa população em que a prevalência da doença é de 1%. Entre as pessoas com resultado positivo nessa população, a proporção que de fato tem a doença é, aproximadamente:

O DADO QUE DECIDE
a prevalência da doença é de 1%

Resolução. O comando pede o valor preditivo positivo, e não a sensibilidade, e o qualificador é a população de prevalência de 1%. Em 10.000 pessoas, 100 têm a doença, e o teste detecta 90 (verdadeiros positivos). Das 9.900 sem a doença, 10% dão positivo: 990 falsos positivos. Entre 1.080 positivos, só 90 estão doentes: cerca de 8%. O 90% é a sensibilidade (e a especificidade), propriedades do teste que não mudam com a prevalência; o valor preditivo muda. O 99% é o valor preditivo negativo (8.910 de 8.920).

A) 1%
Errada. 1% é a prevalência, a probabilidade antes do teste; um positivo aumenta essa probabilidade para cerca de 8%.

B) 8% CORRETA
Correta. 90 verdadeiros positivos entre 1.080 positivos: VPP de cerca de 8% com prevalência de 1%.

C) 90% ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. 90% é a sensibilidade, a proporção de doentes com teste positivo; o comando pergunta o inverso.

D) 99%

Errada. 99% (99,9%) é o valor preditivo negativo, que fica alto quando a prevalência é baixa.

Para levar. Valor preditivo depende da prevalência: teste bom em população de baixa prevalência gera mais falsos que verdadeiros positivos.

Fletcher, Epidemiologia Clínica: elementos essenciais, 6ª ed.; Guyatt, Users' Guides to the Medical Literature, 3ª ed.

---

32 Infectologia · Colite fulminante por Clostridioides difficile com íleo e sem diarreia

Dado omitido **Gabarito C**

Mulher de 74 anos, no 9º dia de internação por pneumonia aspirativa tratada com clindamicina e ceftriaxona, em uso de omeprazol, evolui com distensão abdominal progressiva, dor difusa e febre. Teve duas evacuações amolecidas no 6º dia; desde então não evacua nem elimina flatos. Exame: T 38,6 °C, FC 122 bpm, PA 84 × 50 mmHg após 2 L de cristaloide, iniciada noradrenalina; abdome distendido, timpânico, doloroso, ruídos hidroaéreos ausentes, sem peritonite. Leucócitos 34.000/mm³, creatinina 2,4 mg/dL (basal 0,8), lactato 4,0 mmol/L. TC de abdome: cólon transverso com 7 cm, espessamento parietal difuso com sinal do acordeão, sem pneumoperitônio. PCR para o gene da toxina B de C. difficile em swab retal positiva. A cirurgia geral avaliou e acompanha. Além da suspensão da clindamicina, o tratamento antimicrobiano mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

desde então não evacua nem elimina flatos

Resolução. A diarreia, o dado mais lembrado da infecção por C. difficile, foi retirada: a paciente parou de evacuar porque desenvolveu íleo e megacólon, e é isso que define a forma fulminante (hipotensão ou choque, íleo ou megacólon). Diante de choque séptico, o reflexo é escalar para vancomicina intravenosa e carbapenêmico, mas a vancomicina intravenosa não chega à luz do cólon e não trata a colite. Na forma fulminante, a vancomicina vai por via oral (ou sonda) em dose alta, 500 mg de 6/6 horas; com íleo, acrescenta-se vancomicina por enema de retenção, porque o trânsito não leva a droga ao cólon, e metronidazol intravenoso, que atinge a parede colônica pela circulação. A cirurgia (colectomia ou ileostomia em alça com lavagem) entra se houver perfuração, peritonite ou piora apesar do tratamento.

A) Metronidazol intravenoso isolado

Errada. Metronidazol isolado já não é tratamento de primeira linha nem no episódio leve; na forma fulminante, é só adjuvante intravenoso.

B) Vancomicina oral 125 mg de 6/6 horas

Errada. Vancomicina oral 125 mg serve ao episódio não fulminante; com íleo e choque, a dose oral sobe para 500 mg e se associam via retal e metronidazol IV.

C) Vancomicina oral e retal com metronidazol IV CORRETA

Correta. Forma fulminante com íleo: vancomicina oral em dose alta mais enema de vancomicina e metronidazol intravenoso.

D) Vancomicina intravenosa com meropenem ARMADILHA

Errada. É a armadilha: vancomicina intravenosa não é excretada na luz colônica e não trata C. difficile; meropenem amplia a pressão seletiva.

Para levar. C. difficile fulminante pode não ter diarreia (íleo): vancomicina oral 500 mg de 6/6 h, vancomicina retal se íleo e metronidazol IV; vancomicina intravenosa não serve.

IDSA/SHEA Clinical Practice Guideline for Clostridioides difficile Infection in Adults (2017, atualização focada 2021); ACG Clinical Guidelines: Clostridioides difficile Infection (2021).

---

33 Cardiologia · Estratégia fármaco-invasiva: fibrinólise bem-sucedida não pede resgate, pede cateterismo em 2 a 24 h

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 61 anos, hipertensa, chega a um hospital sem hemodinâmica com dor torácica há 2 horas e supradesnivelamento de ST de V1 a V5. O serviço de referência com angioplastia fica a 3 horas de transporte. Recebe AAS, clopidogrel, enoxaparina e tenecteplase 25 minutos após a chegada. Aos 70 minutos da fibrinólise está sem dor, com redução de 70% do supradesnivelamento na derivação de maior elevação, e o monitor registra ritmo idioventricular acelerado a 88 bpm, autolimitado. PA 124×76 mmHg, Killip I. A conduta mais adequada em relação à estratégia invasiva é:

O DADO QUE DECIDE

redução de 70% do supradesnivelamento na derivação de maior elevação

Resolução. Com transporte de 3 horas, o tempo até a angioplastia passaria de 120 minutos, e a fibrinólise em até 30 minutos estava certa. A pergunta é o que fazer depois, e o ritmo idioventricular acelerado assusta e empurra para o resgate imediato, que é a armadilha. Ele é, ao contrário, um marcador de reperfusão, junto com o alívio da dor e a redução do supradesnivelamento acima de 50% em 60 a 90 minutos, que aqui foi de 70%. Fibrinólise eficaz não dispensa o cateterismo: a estratégia fármaco-invasiva manda transferir e estudar entre 2 e 24 horas, para tratar a lesão residual e reduzir reinfarto. O resgate imediato fica para quem não reperfundiu (redução abaixo de 50%, dor persistente) ou tem instabilidade elétrica ou hemodinâmica.

A) Cateterismo eletivo após a alta

Errada. Adiar para depois da alta deixa a artéria com a lesão residual e trombo na fase de maior risco de reoclusão.

B) Cateterismo só se houver isquemia induzida

Errada. Estratificar com teste de isquemia após fibrinólise é a conduta antiga; mesmo com sucesso, o cateterismo de rotina reduz reinfarto.

C) Angioplastia de resgate imediata ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. O resgate é para fibrinólise que falhou; aqui há três critérios de sucesso, e o ritmo idioventricular acelerado é um deles, não instabilidade.

D) Cateterismo entre 2 e 24 horas CORRETA

Correta. Fibrinólise eficaz com transporte longo: transferir e fazer cateterismo de rotina entre 2 e 24 horas.

Para levar. Após fibrinólise: sucesso (redução do ST acima de 50% em 60 a 90 min, alívio da dor, ritmo idioventricular acelerado) leva a cateterismo entre 2 e 24 h; falha ou instabilidade leva a angioplastia de resgate imediata.

ESC 2023 (acute coronary syndromes); V Diretriz da SBC sobre Tratamento do IAM com Supradesnível do Segmento ST (2015)

---

34 Oncologia · Rastreamento do câncer do colo após histerectomia total por doença benigna

Omissão **Gabarito B**

Em mulher de 47 anos, imunocompetente, submetida há 6 anos a histerectomia total por miomatose, com histopatológico do colo uterino sem neoplasia intraepitelial e citopatológicos anteriores normais, a conduta quanto ao rastreamento do câncer do colo do útero é:

O DADO QUE DECIDE

histopatológico do colo uterino sem neoplasia intraepitelial

Resolução. A faixa de rastreamento dos 25 aos 64 anos faz manter o exame, agora com o teste de DNA-HPV, que vem substituindo a citologia no programa brasileiro. Mas o rastreamento existe para detectar lesão precursora no colo, e a histerectomia total por doença benigna, sem NIC 2 ou mais grave no histórico, retirou o órgão-alvo. Câncer primário de vagina é raro demais para justificar rastreio: encerra-se o rastreamento. A exceção é quem foi histerectomizada por NIC 2 ou mais grave ou câncer, ou é imunossuprimida, que segue com controle da cúpula.

A) Citologia da cúpula a cada 3 anos
Errada. Citologia de cúpula se mantém só quando a histerectomia foi por NIC de alto grau ou câncer, ou na imunossupressão.

B) Encerrar o rastreamento CORRETA
Correta. Histerectomia total por doença benigna, sem NIC 2 ou mais grave: rastreamento encerrado.

C) Teste de DNA-HPV a cada 5 anos ARMADILHA
Errada. É a isca: DNA-HPV a cada 5 anos é o novo rastreio de quem tem colo; após histerectomia total por doença benigna não há órgão-alvo.

D) Colposcopia anual da cúpula
Errada. Colposcopia não é exame de rastreamento; é investigação de exame alterado.

Para levar. Histerectomia total por doença benigna, sem NIC 2 ou mais grave: não se rastreia câncer do colo.

Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (INCA, 2016); USPSTF: Screening for Cervical Cancer (2018)

---

35 Nefrologia · Pielonefrite obstrutiva com cálculo coraliforme e urina alcalina · estruvita e descompressão antes da litotripsia

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 52 anos, com infecções urinárias de repetição, procura o pronto-socorro por dor em flanco direito há dois dias, febre de 39,2 °C e calafrios. Exame: PA 104/62 mmHg após 2 litros de cristaloide, FC 112 bpm, punho-percussão lombar direita dolorosa. Exames: leucócitos 19.800/mm³, creatinina 1,8 mg/dL, lactato 2,8 mmol/L; urina com pH 8,0, nitrito positivo, leucocitúria intensa e bacilos gram-negativos no Gram. Tomografia sem contraste: cálculo de 9 mm no ureter proximal direito com hidronefrose moderada e cálculo coraliforme parcial no rim direito. Já recebeu a primeira dose de ceftriaxona. A composição mais provável do cálculo coraliforme e a conduta urológica imediata são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

cálculo de 9 mm no ureter proximal direito com hidronefrose moderada

Resolução. A tentação é resolver tudo de uma vez: o cálculo está visível e acessível, e a ureteroscopia com litotripsia trataria a causa. Mas pielonefrite obstrutiva com sepse é emergência urológica em que o objetivo imediato é só descomprimir o rim: cateter duplo J ou nefrostomia percutânea, com antibiótico e cultura da urina drenada. Manipular o cálculo num sistema coletor infectado e sob pressão dissemina bactérias e endotoxina e piora a sepse; o tratamento definitivo fica para depois da resolução da infecção. Quanto à composição, urina com pH 8,0, infecções de repetição e cálculo coraliforme apontam estruvita (fosfato amoníaco-magnesiano), formada quando bactérias produtoras de urease (Proteus, Klebsiella) hidrolisam a ureia em amônia e alcalinizam a urina. O ácido úrico precipita em urina ácida (pH abaixo de 5,5).

A) Ácido úrico / ureteroscopia com litotripsia
Errada. Erra nas duas metades: ácido úrico precipita em urina ácida, e a litotripsia não é a medida imediata.

B) Ácido úrico / drenagem com duplo J ou nefrostomia
Errada. A drenagem está certa, mas pH urinário de 8,0 com infecção recorrente e coraliforme não é ácido úrico.

C) Estruvita / ureteroscopia com litotripsia ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A composição está certa, mas a ureteroscopia definitiva num rim obstruído e infectado com sepse é contraindicada; primeiro se drena, depois se trata o cálculo.

D) Estruvita / drenagem com duplo J ou nefrostomia CORRETA
Correta. Urina alcalina com gram-negativo e coraliforme é estruvita por germe produtor de urease; com obstrução e sepse, a conduta imediata é a descompressão com duplo J ou nefrostomia.

Para levar. Cálculo com obstrução e infecção: descomprimir (duplo J ou nefrostomia) e antibiótico, e só depois tratar o cálculo. Coraliforme em urina alcalina com Proteus ou Klebsiella é estruvita.

EAU Guidelines on Urolithiasis (2025); AUA/Endourological Society, Surgical Management of Stones (2016); Harrison 21ª ed. (Nephrolithiasis).

36 Reumatologia · Espondilite anquilosante: falha de AINE só depois de dois AINEs em dose plena

Limiar **Gabarito B**

Homem de 27 anos tem dor lombar inflamatória há 14 meses, com rigidez matinal de 1 hora, melhora com exercício e despertar na segunda metade da noite. Há 2 meses recebeu diagnóstico de espondilite anquilosante (sacroiliíte bilateral grau 3 na radiografia, HLA-B27 reagente). Usou paracetamol sem melhora e, depois, ibuprofeno 400 mg quando a dor apertava, em média uma vez ao dia, por 3 semanas, com alívio parcial. Sem artrite periférica, entesite, uveíte, psoríase ou sintomas intestinais. Função renal normal, sem doença péptica, PA 122 × 78 mmHg. BASDAI 5,8, PCR 2,4 mg/dL. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ibuprofeno 400 mg quando a dor apertava, em média uma vez ao dia, por 3 semanas

Resolução. BASDAI acima de 4 com PCR elevada é o critério de atividade para biológico, e quem para aí prescreve adalimumabe. Mas o biológico exige falha de pelo menos dois AINEs em dose plena por um total de 4 semanas, e o paciente usou um único AINE, em subdose (400 mg uma vez ao dia) e sob demanda, por 3 semanas. Paracetamol não é anti-inflamatório e não conta. O passo correto é AINE em dose anti-inflamatória plena e contínua (por exemplo, naproxeno 500 mg de 12/12 horas), avaliando resposta em 2 a 4 semanas, e trocar por outro AINE se falhar. Sulfassalazina e metotrexato não agem na doença axial, e corticoide sistêmico não é recomendado na espondiloartrite axial.

A) Associar sulfassalazina
Errada. A sulfassalazina só tem papel na artrite periférica; sem sinovite periférica, não age na coluna.

B) Naproxeno em dose plena contínua CORRETA
Correta. Antes de declarar falha, o AINE precisa ser usado em dose plena e contínua; é o degrau que ainda não foi cumprido.

C) Prednisona 20 mg/dia
Errada. Corticoide sistêmico não é recomendado na doença axial e não muda o curso; seria tratar com a droga errada.

D) Iniciar adalimumabe ARMADILHA
Errada. Seria a resposta após falha de dois AINEs em dose plena por 4 semanas no total; aqui houve um AINE em subdose, sob demanda.

Para levar. Espondiloartrite axial: falha de AINE só conta com dois AINEs em dose plena por 4 semanas no total. Subdose sob demanda não é falha.

ASAS-EULAR 2022 recommendations for axial spondyloarthritis; SBR 2019 recomendações para o tratamento da espondilite anquilosante.

---

37 Hematologia · PTI do adulto com plaquetas acima de 30.000 e sem sangramento: observação

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 32 anos tem plaquetopenia descoberta em hemograma admissional, sem queixas. Nega sangramentos, tem menstruação normal e não usa medicamentos, álcool ou fitoterápicos. Exame físico: sem

petéquias, sem linfonodomegalia, baço não palpável. Exames: Hb 13,0 g/dL, leucócitos 6.200/mm³ com diferencial normal, plaquetas 41.000/mm³ (confirmadas em tubo com citrato), VCM 88 fL. Esfregaço: plaquetas grandes, sem esquizócitos e sem blastos. Sorologias para HIV, hepatite C e hepatite B negativas, TSH normal, TP e TTPa normais, antígeno fecal de H. pylori negativo, teste de gravidez negativo. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

plaquetas 41.000/mm³ (confirmadas em tubo com citrato)

Resolução. Plaquetopenia isolada com esfregaço de plaquetas grandes, sem outras citopenias, sem esplenomegalia e com causas secundárias afastadas é PTI, e o reflexo é tratar porque o número assusta. O tratamento da PTI, porém, não persegue a contagem: serve para prevenir sangramento grave, que é raro acima de 30.000/mm³. A ASH recomenda observação para o adulto com PTI recém-diagnosticada, assintomático, com plaquetas de 30.000 ou mais, porque o corticoide expõe a efeitos adversos sem benefício nesse grupo. A pseudoplaquetopenia por EDTA foi excluída pela recontagem em citrato, e o mielograma não é necessário em jovem com quadro isolado e esfregaço compatível. A imunoglobulina fica para sangramento importante ou necessidade de subir plaquetas rapidamente.

A) Mielograma antes de decidir
Errada. Seria o passo em idoso, com outras citopenias, esplenomegalia, blastos ou falha de tratamento; o quadro aqui é isolado e compatível com PTI no esfregaço.

B) Observação com hemograma seriado CORRETA
Correta. PTI recém-diagnosticada, assintomática, plaquetas de 41.000: observação com hemograma seriado, conforme a ASH.

C) Prednisona 1 mg/kg/dia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: corticoide se indica com plaquetas abaixo de 30.000 ou com sangramento; aqui seria tratar um número.

D) Imunoglobulina humana endovenosa
Errada. Imunoglobulina é para sangramento relevante ou preparo urgente para procedimento; não se usa em assintomática com 41.000.

Para levar. PTI do adulto com plaquetas de 30.000 ou mais e sem sangramento se observa; o tratamento é para sangramento ou contagem abaixo de 30.000.

ASH 2019 guidelines for immune thrombocytopenia (Neunert et al.); International Consensus Report on ITP 2019 (Provan et al., Blood Adv 2019).

---

38 Endocrinologia · Carcinoma medular com RET positivo: excluir feocromocitoma antes da tireoidectomia

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 34 anos tem nódulo tireoidiano de 2,1 cm cuja punção mostrou carcinoma medular, com calcitonina sérica de 380 pg/mL e CEA de 18 ng/mL. O pai foi operado de tumor de tireoide aos 40 anos e morreu subitamente durante uma colecistectomia. Nega cefaleia, palpitações ou sudorese. Exame: PA 122/78 mmHg, FC 78 bpm, sem linfonodos cervicais palpáveis. Exames: cálcio 9,4 mg/dL, PTH 38 pg/mL. Ultrassonografia cervical

sem linfonodos suspeitos. Pesquisa do proto-oncogene RET: mutação no códon 634. Antes da tireoidectomia, o exame indispensável é:

O DADO QUE DECIDE

Pesquisa do proto-oncogene RET: mutação no códon 634

Resolução. A paciente nega paroxismos e está normotensa, e esse negativo no meio convida a seguir direto para a cirurgia do câncer, no máximo com estadiamento por imagem. Mas o códon 634 do RET é a mutação da neoplasia endócrina múltipla 2A de maior risco, com feocromocitoma em cerca de metade dos portadores, frequentemente silencioso; a morte súbita do pai durante uma cirurgia é a pista de um feocromocitoma não diagnosticado. Todo paciente com carcinoma medular, e obrigatoriamente o portador de RET, precisa ter feocromocitoma excluído por metanefrinas antes de qualquer cirurgia; se presente, ele é operado primeiro, após bloqueio alfa. A calcitonina abaixo de 500 pg/mL e o pescoço sem linfonodos dispensam imagem de estadiamento sistêmico, e o cálcio normal com PTH normal afasta hiperparatireoidismo neste momento.

A) Metanefrinas livres plasmáticas CORRETA
Correta. Feocromocitoma é excluído por metanefrinas em todo carcinoma medular antes da tireoidectomia, sintomático ou não.

B) Tomografia de tórax e abdome ARMADILHA
Errada. Seria indicada com calcitonina acima de 500 pg/mL ou doença cervical extensa, para procurar metástase a distância.

C) Cintilografia com sestamibi
Errada. Seria o exame de localização com hiperparatireoidismo primário bioquímico, que aqui não existe (cálcio e PTH normais).

D) PET-CT com FDG
Errada. PET-FDG tem papel em carcinoma medular avançado e de progressão rápida, não no estadiamento inicial de doença limitada.

Para levar. Carcinoma medular de tireoide: dose metanefrinas antes da tireoidectomia, mesmo sem sintomas; feocromocitoma presente é operado primeiro, após bloqueio alfa.

ATA Revised Guidelines for Medullary Thyroid Carcinoma 2015; Endocrine Society, Pheochromocytoma and Paraganglioma 2014.

---

39 Terapia intensiva · SDRA na obesa: volume corrente pelo peso predito e indicação de prona

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 48 anos, 1,55 m de altura e 98 kg, intubada há 20 horas por pneumonia por influenza com síndrome do desconforto respiratório agudo. Ventilação controlada a volume: volume corrente 500 mL, PEEP 12 cmH2O, FiO2 80%, FR 22 irpm. Pressão de platô 33 cmH2O, pressão de pico 40 cmH2O. Gasometria: pH 7,31, PaCO2 50 mmHg, PaO2 88 mmHg. Sedada, sem drogas vasoativas. Radiografia: opacidades bilaterais. O ajuste do volume corrente e a medida adicional mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

1,55 m de altura e 98 kg

Resolução. 500 mL parecem protetores porque dão cerca de 5 mL/kg do peso real. Mas o volume corrente se calcula pelo peso predito, que depende da altura e do sexo: 45,5 + 0,91 x (155 - 152,4), cerca de 48 kg. Assim, 500 mL são mais de 10 mL/kg do peso predito, e o platô de 33 e a pressão de distensão de 21 confirmam a hiperdistensão. O alvo é 6 mL/kg do peso predito, cerca de 290 mL, com platô até 30 e aumento da FR para compensar o CO2. A relação PaO2/FiO2 é 88/0,8, cerca de 110, abaixo de 150 com PEEP de 12 e FiO2 de 80%: indica posição prona por pelo menos 16 horas por dia, que reduz mortalidade (PROSEVA). ECMO é resgate para hipoxemia refratária depois de ventilação protetora e prona otimizadas.

A) Manter 500 mL / ECMO venovenosa
Errada nas duas metades. Mantém volume lesivo e pula a prona para um resgate que exige falha das medidas anteriores.

B) Manter 500 mL / posição prona ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Acerta a prona, mas mantém um volume que é mais de 10 mL/kg do peso predito; o erro é calcular pelo peso real.

C) Reduzir para cerca de 290 mL / ECMO venovenosa
Errada. Acerta o volume, mas ECMO é para hipoxemia refratária depois de prona e ventilação protetora.

D) Reduzir para cerca de 290 mL / posição prona CORRETA
Correta. Peso predito de cerca de 48 kg dá cerca de 290 mL a 6 mL/kg, e PaO2/FiO2 de 110 abaixo de 150 indica prona.

Para levar. Volume corrente na SDRA é 6 mL/kg do peso PREDITO (altura e sexo), nunca do peso real; PaO2/FiO2 abaixo de 150 indica prona antes de qualquer resgate.

ATS/ESICM/SCCM 2017 e ATS 2024 (ventilação e manejo na SDRA); ARDSNet (N Engl J Med 2000); PROSEVA (N Engl J Med 2013); Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica AMIB/SBPT 2013

---

40 Infectologia · Profilaxia do tétano em ferimento de alto risco com última dose há 7 anos: reforço de dT, sem imunoglobulina

Cronologia **Gabarito C**

Homem de 41 anos, pedreiro, previamente hígido e sem uso de medicações, procura a emergência 5 horas depois de pisar descalço num prego enferrujado, em terreno com entulho e esterco. Exame: T 36,6 °C, ferimento perfurante de cerca de 1,5 cm de profundidade na planta do pé direito, com terra no trajeto, sem sinais flogísticos e sem tecido desvitalizado extenso. Glicemia capilar 96 mg/dL. Traz a caderneta de vacinação: três doses na infância, reforços aos 15 e aos 25 anos e, por último, uma dose de dT aos 34 anos, quando cortou a mão numa obra. Nega alergia a vacinas. Foi feita a limpeza com soro fisiológico e a retirada de corpos estranhos. Quanto à profilaxia do tétano, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

por último, uma dose de dT aos 34 anos

Resolução. Prego enferrujado, terra e esterco fazem um ferimento de alto risco, e o reflexo é somar tudo: vacina e imunoglobulina. Mas a decisão do Ministério da Saúde depende do histórico vacinal, e a caderneta

resolve: três doses ou mais, com a última há 7 anos. No ferimento de alto risco, última dose há menos de 5 anos dispensa a vacina; há 5 anos ou mais, indica um reforço de dT. A imunoglobulina antitetânica (ou o soro) fica para quem tem esquema incompleto, ignorado ou com menos de três doses e, entre os vacinados com reforço indicado, para imunodeprimidos, desnutridos graves e idosos, e ele não está em nenhum desses grupos. O esquema completo de três doses é para quem não comprova vacinação. A limpeza cuidadosa vale para todos e já foi feita.

A) Reforço de dT com imunoglobulina antitetânica ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a conduta no ferimento de alto risco com esquema incompleto ou ignorado, ou no vacinado imunodeprimido, desnutrido grave ou idoso; ele tem esquema completo e é hígido.

B) Apenas a limpeza, sem vacina
Errada. Seria a conduta no ferimento de alto risco com a última dose há menos de 5 anos; a dele foi há 7.

C) Reforço de dT, sem imunoglobulina CORRETA
Correta. Esquema completo com última dose há 7 anos e ferimento de alto risco: um reforço de dT, sem imunoglobulina.

D) Esquema completo de três doses de dT
Errada. Seria o esquema para quem nunca foi vacinado ou não comprova as doses; a caderneta mostra esquema completo com reforços.

Para levar. No ferimento de alto risco, a imunoglobulina antitetânica depende do esquema vacinal, e não da sujeira: esquema completo com última dose há 5 anos ou mais pede só reforço de dT, salvo no imunodeprimido, no desnutrido grave e no idoso.

Ministério da Saúde: Guia de Vigilância em Saúde, 5ª edição (2021), capítulo de tétano acidental; Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014).

---

41 Neurologia · Meningite com glicose liquórica 'normal' em diabético descompensado: razão líquor/sangue de 0,25

Limiar **Gabarito A**

Homem de 52 anos, com diabetes tipo 2 mal controlado, procura o PS por cefaleia progressiva há 3 semanas, febre baixa vespertina e, há 4 dias, visão dupla e sonolência. Exame: Glasgow 14, rigidez de nuca, paresia do VI nervo à esquerda, sem outros déficits. TC de crânio com contraste: discreta dilatação ventricular e realce meníngeo basal. Líquor: 210 células/mm³ (78% linfócitos), proteína 290 mg/dL, glicose 96 mg/dL, Gram, tinta da China e antígeno criptocócico negativos. Glicemia sérica colhida no mesmo momento: 384 mg/dL. HIV não reagente. Sem história de neoplasia. A etiologia mais provável é:

O DADO QUE DECIDE
Glicemia sérica colhida no mesmo momento: 384 mg/dL

Resolução. Uma glicose de 96 mg/dL no líquor parece normal, e com predomínio linfocitário puxa para meningite viral. Mas a glicorraquia só se lê contra a glicemia simultânea: o normal é cerca de 60% a 2/3 da glicemia, e abaixo de 0,5 indica consumo. Aqui a razão é 96/384, cerca de 0,25: hipoglicorraquia acentuada mascarada pela hiperglicemia. Com evolução subaguda de 3 semanas, febre vespertina, par craniano (VI), hidrocefalia e realce meníngeo basal, proteína muito alta e pleocitose linfocitária moderada, o quadro é de meningite tuberculosa, e o tratamento empírico (RIPE com corticoide) começa sem esperar a cultura.

Criptococo também consome glicose, mas tinta da China e antígeno criptocócico negativos o afastam; a meningite carcinomatosa imita o líquor, mas pede neoplasia conhecida e não explica a febre vespertina.

A) Meningite tuberculosa CORRETA
Correta. Razão glicorraquia/glicemia de 0,25, proteína de 290, linfócitos, curso subagudo, VI nervo e realce basal com hidrocefalia.

B) Meningite carcinomatosa
Errada. A carcinomatosa também dá hipoglicorraquia, proteína alta e pares cranianos múltiplos; seria a resposta em paciente com neoplasia conhecida (mama, pulmão, melanoma, linfoma), sem febre, com citologia oncótica positiva.

C) Meningite viral ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Meningite viral tem glicorraquia proporcional à glicemia, proteína levemente elevada e curso agudo; a razão de 0,25 e a proteína de 290 a derrubam.

D) Meningite bacteriana decapitada
Errada. Bacteriana parcialmente tratada pode virar linfocitária, mas exigiria antibiótico prévio e curso agudo; 3 semanas com VI e realce basal são de TB.

Para levar. Glicorraquia se interpreta pela razão com a glicemia simultânea: abaixo de 0,5 (ou de 0,6) é consumo, mesmo com valor absoluto 'normal' no diabético descompensado.

Ministério da Saúde, Manual de Recomendações para o Controle da TB 2019 (atualização 2022); IDSA 2017 (meningites); Thwaites et al., British Infection Society 2009.

---

42 Oncologia · Compressão medular por carcinoma renal com instabilidade: dexametasona e descompressão seguida de radioterapia

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 61 anos com carcinoma renal de células claras e metástases pulmonares pequenas e estáveis, em uso de pembrolizumabe e axitinibe, ECOG 1, tem dor dorsal progressiva há 10 dias, pior ao deitar, e há 24 horas fraqueza nas pernas. Exame: força grau 4 em membros inferiores, hiper-reflexia patelar, nível sensitivo em T8; deambula com apoio. RM de toda a coluna: lesão lítica única em T7, com colapso de 50% do corpo vertebral, retropulsão de fragmento ósseo e compressão medular; SINS 13; sem outras lesões. A medida imediata e o tratamento definitivo mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
SINS 13

Resolução. Compressão medular neoplásica faz pensar em dexametasona e radioterapia, que é o tratamento da maioria. Duas informações mudam o tratamento definitivo: a histologia radiorresistente (carcinoma renal de células claras) e a instabilidade mecânica (colapso de 50%, retropulsão de fragmento, SINS de 13, na faixa de instabilidade). Com lesão em um só nível, déficit há menos de 48 horas, bom estado funcional e doença sistêmica controlada (expectativa de vida acima de 3 meses), a descompressão com estabilização seguida de radioterapia preserva a marcha melhor que a radioterapia isolada (Patchell). A radioterapia não estabiliza a coluna nem remove fragmento ósseo. A dexametasona começa já, porque há déficit neurológico, e biópsia é desnecessária com primário conhecido e imagem compatível.

A) Dexametasona / radioterapia isolada ARMADILHA

Errada. É a isca: radioterapia isolada é a conduta para tumor radiossensível, múltiplos níveis ou prognóstico curto; não corrige instabilidade nem fragmento retropulsado.

B) Aguardar biópsia / radioterapia isolada

Errada nas duas metades: atrasar o corticoide com déficit instalado custa função, e a radioterapia isolada não resolve a instabilidade.

C) Aguardar biópsia / descompressão seguida de radioterapia

Errada. A cirurgia está certa, mas aguardar biópsia é desnecessário com primário conhecido e atrasa corticoide e descompressão.

D) Dexametasona / descompressão seguida de radioterapia CORRETA

Correta. Déficit há 24 horas: dexametasona imediata; lesão única, instável (SINS 13), radiorresistente e com bom prognóstico: descompressão e estabilização, depois radioterapia.

Para levar. Na compressão medular neoplásica, cirurgia seguida de radioterapia em lesão única, instável ou radiorresistente, com bom prognóstico; radioterapia isolada nos demais.

Patchell et al., Lancet (2005); NICE NG234: Spinal metastases and metastatic spinal cord compression (2023); Spine Instability Neoplastic Score (Fisher et al., Spine, 2010)

---

43 Reumatologia · Fibromialgia com FAN 1:80: encerrar a investigação

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 44 anos refere dor difusa há 2 anos, nos dois hemicorpos, acima e abaixo da cintura e no esqueleto axial, com cansaço, sono não reparador e dificuldade de concentração. Nega artrite, rigidez matinal prolongada, fraqueza, febre, perda de peso, fotossensibilidade, úlceras orais e Raynaud. Exame físico: dor à palpação em múltiplos pontos musculares, sem sinovite, força grau 5, pele e mucosas normais. Exames: hemograma, VHS, PCR, CK, TSH, cálcio, 25-hidroxivitamina D, glicemia, função renal e função hepática normais. Trouxe FAN de laboratório externo: reagente 1:80, padrão nuclear pontilhado fino. Índice de dor generalizada 9 e escala de gravidade dos sintomas 7. Quanto à investigação, o mais adequado é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *Nega artrite, rigidez matinal prolongada, fraqueza, febre, perda de peso, fotossensibilidade, úlceras orais e Raynaud*

Resolução. Um FAN reagente costuma disparar o painel de autoanticorpos, e é o que ele faria. Mas FAN em título baixo (1:80) é encontrado em parte considerável da população saudável, e o valor preditivo dele sem clínica compatível é muito baixo. A paciente não tem nenhum dado objetivo de doença autoimune: sem artrite, sem fraqueza, sem lesão de pele ou mucosa, sem Raynaud, com hemograma, provas inflamatórias e CK normais. Ela preenche os critérios de fibromialgia (índice de dor generalizada 7 ou mais com escala de gravidade 5 ou mais, dor em 4 de 5 regiões há mais de 3 meses). Pedir anti-DNA e anti-Sm só aumenta a chance de falso positivo e de rótulo errado; a conduta é encerrar a investigação, explicar o diagnóstico e iniciar exercício aeróbico gradual.

A) Repetir o FAN em 6 meses

Errada. Repetir o FAN não acrescenta: a positividade em título baixo persiste em saudáveis e não muda a conduta.

B) Nenhum exame adicional CORRETA

Correta. Critérios de fibromialgia preenchidos, exame e laboratório normais e FAN 1:80 sem clínica: encerrar a investigação e tratar.

C) Eletroneuromiografia e biópsia muscular

Errada. Força normal e CK normal dispensam investigação de miopatia; biópsia muscular na fibromialgia é o exame a mais.

D) Anti-DNA nativo, anti-Sm e complemento ARMADILHA

Errada. Seria o passo com FAN em título alto e clínica sugestiva de lúpus (citopenia, serosite, nefrite, artrite); sem nada disso, só gera falso positivo.

Para levar. FAN em título baixo sem clínica objetiva não é doença e não pede painel de anticorpos. Fibromialgia com exame e provas inflamatórias normais se trata, não se investiga mais.

ACR 2016 revisão dos critérios de fibromialgia; EULAR 2016 recomendações para fibromialgia; Consenso Brasileiro de FAN em células HEp-2 (2019).

---

44 Cardiologia · Síndrome de Down no adulto: DSAV pelo eixo do ECG e evolução para Eisenmenger

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 27 anos, com deficiência intelectual, fendas palpebrais oblíquas para cima, prega palmar única e hipotireoidismo em uso de levotiroxina, é trazido pela irmã por cansaço progressivo. Ela conta que na infância havia um sopro alto no coração e que a cirurgia foi adiada e depois esquecida. Exame: cianose de lábios e extremidades, baqueteamento digital, SpO2 82% em ar ambiente, impulsão sistólica paraesternal esquerda, B2 única e intensa no foco pulmonar, sopro diastólico decrescente em borda esternal esquerda alta e nenhum sopro sistólico audível. Hemoglobina 20,1 g/dL. ECG: ritmo sinusal, PR de 220 ms, eixo do QRS em -60 graus e sobrecarga ventricular direita. O defeito de base e a fisiologia atual são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

eixo do QRS em -60 graus

Resolução. O fenótipo é de síndrome de Down, e duas cardiopatias disputam a resposta: o defeito do septo atrioventricular (DSAV, o mais característico, cerca de 40%) e a comunicação interventricular isolada (cerca de 30%), a lesão mais lembrada quando se pensa em Eisenmenger, que é a armadilha. A fisiologia atual se lê no exame: 27 anos sem correção, cianose, baqueteamento, policitemia, B2 única e hiperfonética, sopro de Graham Steell (insuficiência pulmonar pela hipertensão) e desaparecimento do sopro sistólico, porque com as pressões equalizadas o shunt se inverte e deixa de gerar turbulência; isso elimina o shunt da esquerda para a direita, que era o sopro alto da infância. O defeito se lê no ECG, que a hipertensão pulmonar não apaga: eixo superior (-60 graus) com PR longo é a assinatura do DSAV, porque o nó atrioventricular e o feixe de His estão deslocados para baixo e para trás. Na CIV com Eisenmenger, a sobrecarga de VD leva o eixo para a direita, e na CIA ostium secundum o eixo também é direito, com Eisenmenger raro e tardio.

A) DSAV / síndrome de Eisenmenger CORRETA

Correta. Eixo superior com PR longo define o DSAV, e cianose, policitemia, P2 intensa, Graham Steell e sopro sistólico ausente definem o Eisenmenger.

B) DSAV / shunt da esquerda para a direita

Errada na segunda metade. O defeito está certo, mas o shunt da esquerda para a direita era a fisiologia da infância; SpO2 de 82%, policitemia e sopro sistólico ausente mostram que ele já se inverteu.

C) CIV / síndrome de Eisenmenger ARMADILHA

Errada na primeira metade, e é a armadilha. A fisiologia está certa, e a CIV é frequente no Down e chega ao Eisenmenger, mas não dá eixo superior: com sobrecarga de VD, o eixo da CIV com Eisenmenger vai para a direita.

D) CIA ostium secundum / síndrome de Eisenmenger

Errada na primeira metade. A CIA ostium secundum tem eixo para a direita e chega ao Eisenmenger tarde e raramente; eixo superior numa CIA aponta o ostium primum, que é uma forma de DSAV.

Para levar. Na síndrome de Down, a cardiopatia característica é o DSAV, reconhecido no ECG por eixo superior e PR longo, que persistem mesmo com hipertensão pulmonar; sem correção, evolui para Eisenmenger: cianose, policitemia, B2 única e intensa, Graham Steell e sopro do shunt que desaparece.

ESC 2020 (adult congenital heart disease); ESC/ERS 2022 (pulmonary hypertension); Braunwald's Heart Disease, 12ª ed.

---

45 Hematologia · Trombocitemia essencial com trombocitose extrema e von Willebrand adquirida: citorredução sem AAS

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 45 anos tem diagnóstico há 2 anos de trombocitemia essencial com mutação de CALR, sem trombose prévia e sem fatores de risco cardiovascular, em acompanhamento sem medicação. Procura atendimento por epistaxe recorrente e menorragia há 1 mês. PA 122 × 78 mmHg. Exames: Hb 11,2 g/dL, leucócitos 9.800/mm³, plaquetas 1.720.000/mm³, TP e TTPa normais, fator de von Willebrand antigênico 62% e atividade (cofator de ristocetina) 18%. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

atividade (cofator de ristocetina) 18%

Resolução. Trombocitemia essencial é doença de trombose, e o rótulo puxa para AAS. O dado que decide é a atividade do fator de von Willebrand: com plaquetas acima de 1.000.000 a 1.500.000/mm³, as plaquetas adsorvem e degradam os multímeros grandes do fator, criando doença de von Willebrand adquirida, com atividade desproporcionalmente baixa em relação ao antígeno (18% contra 62%). Atividade abaixo de 30% contraindica AAS, porque ela já sangra. Pela idade, pelo CALR e sem trombose ela seria de muito baixo risco, mas trombocitose extrema com sangramento é indicação de citorredução (hidroxiureia ou alfapeginterferona), que baixa as plaquetas e devolve os multímeros. O AAS pode ser reconsiderado quando as plaquetas e a atividade do fator normalizarem.

A) AAS em dose baixa ARMADILHA

Errada. É a armadilha: AAS cabe à TE com sintomas vasomotores ou fator de risco vascular, mas com atividade do fator de 18% e sangramento piora a hemorragia.

B) Citorredução associada a AAS
Errada. A citorredução está certa, mas associar AAS com von Willebrand adquirida e sangramento ativo é contraindicado.

C) Citorredução sem AAS CORRETA
Correta. Trombocitose extrema com sangramento e atividade do fator abaixo de 30%: citorredução (hidroxiureia ou interferona), sem AAS.

D) Manter observação
Errada. Observação cabe à TE de muito baixo risco assintomática; sangramento com plaquetas de 1.720.000 exige tratar.

Para levar. Na trombocitemia com plaquetas acima de 1.000.000 a 1.500.000, dose a atividade do fator de von Willebrand: abaixo de 30% contraindica AAS, e o sangramento pede citorredução.

ELN 2018 recommendations for Ph-negative MPN (Barbui et al., Leukemia 2018); NCCN Myeloproliferative Neoplasms 2025.

46

Nefrologia · Hiponatremia aguda grave após ecstasy com crise convulsiva · salina a 3% em bolus, não anticonvulsivante

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 22 anos, sem doenças prévias e sem uso de medicações, é trazida ao pronto-socorro 10 horas após uma festa em que usou ecstasy e bebeu cerca de quatro litros de água. Teve uma crise tônico-clônica generalizada de dois minutos, presenciada, que cessou espontaneamente. Na chegada está sonolenta, Glasgow 12, sem déficit focal, e vomitou duas vezes. PA 136/84 mmHg, FC 102 bpm, temperatura 37,3 °C, glicemia capilar 104 mg/dL. Exames: sódio 117 mEq/L, potássio 3,8 mEq/L, osmolalidade plasmática 246 mOsm/kg, osmolalidade urinária 470 mOsm/kg, sódio urinário 64 mEq/L, CPK 380 U/L. Tomografia de crânio sem lesões. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
sódio 117 mEq/L

Resolução. A crise convulsiva puxa para o anticonvulsivante, o reflexo da fenitoína que ele já mostrou em três cenários. Mas esta é uma crise provocada: hiponatremia aguda (horas) por MDMA, que estimula a liberação de ADH, somada à ingestão de quatro litros de água. A crise, o rebaixamento e os vômitos são sinais de edema cerebral, e o que os trata é subir o sódio rapidamente em 4 a 6 mEq/L, o suficiente para afastar o risco de herniação. A conduta é salina a 3% 150 mL (ou 2 mL/kg) em bolus de 20 minutos, repetível duas ou três vezes conforme o sódio e os sintomas. Na hiponatremia aguda o risco de desmielinização osmótica é baixo, mas o teto de 10 mEq/L em 24 horas continua valendo. SF 0,9% numa urina com osmolalidade de 470 pode até baixar o sódio (dessalinização), e restrição isolada é lenta demais para quem convulsionou. Fenitoína não trata a causa e não é indicada numa crise única provocada que já cessou.

A) Restrição hídrica e sódio em 4 horas
Errada. Restrição hídrica é tratamento da SIADH crônica oligossintomática; aqui há sinais de edema cerebral.

B) Salina a 3% 150 mL em bolus CORRETA
Correta. Hiponatremia aguda com sintomas graves (crise, rebaixamento, vômitos) pede bolus de salina a 3%, com meta de elevar o sódio em 4 a 6 mEq/L nas primeiras horas.

C) SF 0,9% 1.000 mL em uma hora

Errada. Com urina concentrada (470 mOsm/kg), o sódio da salina isotônica é excretado, parte da água é retida e o sódio pode cair ainda mais.

D) Fenitoína intravenosa em dose de ataque ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Anticonvulsivante é para epilepsia ou estado de mal; numa crise provocada e autolimitada por hiponatremia, o tratamento é corrigir o sódio. Se a crise estivesse em curso, o benzodiazepínico viria junto com a salina hipertônica, não a fenitoína.

Para levar. Crise convulsiva por hiponatremia é crise provocada: trate o sódio (salina a 3% em bolus), não com anticonvulsivante; SF 0,9% não corrige SIADH.

Spasovski et al., Diretriz europeia de hiponatremia (2014); SALSA trial (JAMA Intern Med 2021); ILAE, definição de crise sintomática aguda (2010).

---

47 Infectologia · Endocardite mitral por S. aureus sensível à oxacilina com embolia durante o tratamento

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 47 anos, diabético, em hemodiálise por fístula arteriovenosa, sem cateter, é internado por febre e calafrios há 6 dias. Exame na admissão: T 38,7 °C, FC 108 bpm, PA 124 × 70 mmHg, sopro holossistólico 3+/6 em foco mitral, sem estertores ou edema, hemorragias subungueais em dois dedos, exame neurológico normal. Hemoculturas: Staphylococcus aureus em 4 de 4 frascos, sensível a oxacilina. Recebe vancomicina desde a admissão, com hemoculturas de controle do 3º dia negativas. No 5º dia de antibiótico, tem dor súbita em hipocôndrio esquerdo, e a TC mostra infarto esplênico. Ecocardiograma transesofágico no 6º dia: vegetação móvel de 14 mm no folheto anterior da valva mitral, regurgitação mitral moderada, sem abscesso, FE 60%. RM de crânio sem lesões. Sem sinais de insuficiência cardíaca. O antibiótico definitivo e a conduta cirúrgica são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

No 5º dia de antibiótico, tem dor súbita em hipocôndrio esquerdo

Resolução. Duas decisões, e cada uma tem seu rótulo. A hemodiálise puxa a vancomicina, que se faz após a sessão e já está correndo; mas S. aureus sensível à oxacilina se trata com betalactâmico antiestafilocócico (oxacilina ou cefazolina), com menos falha e menos mortalidade que a vancomicina. A ausência de insuficiência cardíaca e de abscesso puxa o tratamento só clínico; mas o caso traz, no meio, uma embolia que ocorreu já sob antibiótico adequado, com vegetação persistente de 14 mm na valva mitral. Vegetação de 10 mm ou mais com evento embólico apesar do tratamento é indicação de cirurgia urgente (nos primeiros dias) pela diretriz europeia de 2023, para prevenir nova embolia, sobretudo cerebral. A RM sem lesão retira o principal motivo para adiar a cirurgia.

A) Vancomicina / antibiótico isolado

Errada. Vancomicina seria correta para MRSA ou alergia grave a betalactâmico, e o tratamento clínico isolado caberia sem embolia e com vegetação pequena.

B) Vancomicina / cirurgia precoce

Errada. Acerta a cirurgia, mas mantém vancomicina num S. aureus sensível à oxacilina, só pela comodidade da hemodiálise.

C) Oxacilina / antibiótico isolado ARMADILHA

Errada. É a armadilha: acerta o antibiótico, mas ignora a embolia esplênica ocorrida sob tratamento com vegetação de 14 mm, que indica cirurgia mesmo sem insuficiência cardíaca.

D) Oxacilina / cirurgia precoce CORRETA

Correta. MSSA pede oxacilina (ou cefazolina), e vegetação de 14 mm com embolia apesar do antibiótico indica cirurgia urgente.

Para levar. S. aureus sensível: troque vancomicina por betalactâmico. Vegetação mitral ou aórtica de 10 mm ou mais com embolia apesar do antibiótico é indicação de cirurgia, mesmo sem insuficiência cardíaca.

ESC Guidelines for the management of endocarditis (2023); AHA Scientific Statement on Infective Endocarditis in Adults (2015).

---

48 Endocrinologia · Glicosúria com glicemia normal em não diabético usando iSGLT2

Omissão **Gabarito D**

Homem de 64 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 30%) por cardiopatia isquêmica, sem diabetes, usa sacubitril-valsartana, bisoprolol, espironolactona e dapagliflozina 10 mg, esta acrescentada há dois meses. Sem poliúria nova ou sede. Exames de rotina: glicemia de jejum 91 mg/dL, HbA1c 5,5%, creatinina 1,28 mg/dL (era 1,15 antes da dapagliflozina), potássio 4,8 mEq/L, bicarbonato 24 mEq/L, fósforo 3,4 mg/dL, ácido úrico 4,9 mg/dL. Urina tipo 1: glicose 4+, proteína negativa, pH 5,5, sem leucocitúria. Diante da glicosúria, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

dapagliflozina 10 mg, esta acrescentada há dois meses

Resolução. Glicosúria 4+ evoca diabetes e leva ao teste de tolerância, ou, com glicemia normal, a uma tubulopatia proximal. A explicação está na lista de drogas: a dapagliflozina inibe o cotransportador SGLT2 do túbulo proximal, que reabsorve a maior parte da glicose filtrada, e produz glicosúria intensa com qualquer glicemia, inclusive normal. É o efeito farmacológico pretendido, e em não diabético não causa hipoglicemia. A síndrome de Fanconi traria fósforo baixo, ácido úrico baixo, acidose e aminoacidúria, ausentes. A creatinina subiu cerca de 11%, a queda hemodinâmica esperada da TFG (aceitável até 30%), e não é motivo para suspender um fármaco que reduz morte e internação na IC. Não há o que investigar.

A) Suspender a dapagliflozina e repetir a urina

Errada. A glicosúria é o efeito do fármaco, e a elevação de 11% da creatinina é a queda inicial esperada; suspender tira o benefício na IC.

B) Pesquisa de tubulopatia proximal

Errada. Seria a pesquisa com glicosúria normoglicêmica sem iSGLT2 e com fosfatúria, hipouricemia ou acidose, que não existem aqui.

C) Teste oral de tolerância à glicose ARMADILHA

Errada. Seria o exame de glicosúria com glicemia limítrofe sem droga que a explique; com HbA1c de 5,5% em uso de iSGLT2, não informa nada.

D) Nenhuma investigação adicional CORRETA

Correta. Glicosúria com glicemia normal em uso de iSGLT2 é o mecanismo de ação da droga.

Para levar. Glicosúria com glicemia normal em quem usa iSGLT2 é o efeito da droga no túbulo proximal; não investigue diabetes nem tubulopatia.

ESC Guidelines for Heart Failure 2021 e atualização focada 2023; KDIGO Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in CKD 2022.

49

Pneumologia · Hipertensão pulmonar do grupo 3 por hipoventilação-obesidade em quem teve TVP

Negativo no meio | Gabarito D

Mulher de 56 anos, IMC 46 kg/m², hipertensa, com trombose venosa profunda de perna esquerda há 5 anos (tratada por 6 meses), ronco alto e sonolência diurna, procura atendimento por dispneia progressiva e edema de membros inferiores há 8 meses. Exame: SpO2 88% em ar ambiente, FC 92 bpm, B2 hiperfonética, turgência jugular, edema bilateral simétrico. Gasometria arterial em vigília, em ar ambiente: pH 7,37, PaO2 58 mmHg, PaCO2 54 mmHg, HCO3 31 mEq/L. Ecocardiograma: PSAP 58 mmHg, VD dilatado, FE do VE 64%, átrio esquerdo normal, função diastólica normal. Cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão sem defeitos de perfusão. Espirometria: VEF1/CVF 0,82, CVF 74% do previsto. A causa mais provável da hipertensão pulmonar é:

O DADO QUE DECIDE

Cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão sem defeitos de perfusão

Resolução. A TVP prévia é verdadeira e leva direto ao grupo 4. Mas o exame de triagem da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é justamente a cintilografia de ventilação e perfusão, de sensibilidade acima de 95%, e ela não tem defeitos de perfusão: isso praticamente exclui o grupo 4. O resto do caso conta outra história: obesidade grau III, ronco e sonolência (apneia do sono) e hipercapnia em vigília (PaCO2 de 54 com bicarbonato de 31, compensação crônica), o que define síndrome de obesidade-hipoventilação, com hipoxemia crônica causando vasoconstrição pulmonar e cor pulmonale. Coração esquerdo normal (átrio esquerdo e função diastólica) afasta o grupo 2, e com uma causa de grupo 3 evidente não se fala em HAP idiopática. A conduta é ventilação não invasiva noturna e perda de peso, não anticoagulação nem vasodilatador pulmonar.

A) Tromboembólica crônica (grupo 4) ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com defeitos segmentares de perfusão na cintilografia; com cintilografia sem defeitos, HPTEC está praticamente excluída, apesar da TVP.

B) Doença cardíaca esquerda (grupo 2)

Errada. Obesidade e HAS lembram IC de fração preservada, mas átrio esquerdo e função diastólica normais não sustentam HP pós-capilar.

C) Hipertensão arterial pulmonar idiopática (grupo 1)

Errada. HAP idiopática é diagnóstico de exclusão; hipercapnia crônica com obesidade grau III explica a HP.

D) Hipoventilação e hipoxemia (grupo 3) CORRETA

Correta. PaCO2 de 54 em vigília com bicarbonato alto, obesidade grau III e apneia do sono: HP por hipoventilação e hipoxemia.

Para levar. Cintilografia V/Q sem defeitos de perfusão afasta HPTEC mesmo com TVP prévia; hipercapnia em vigília no obeso aponta HP do grupo 3, tratada com ventilação e não com anticoagulação.

ESC/ERS 2022 (hipertensão pulmonar); 7º Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar 2024; ATS 2019 (síndrome de obesidade-hipoventilação)

---

50 Gastroenterologia · Diarreia crônica no diabético com gastroparesia: supercrescimento bacteriano, e não metformina

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 63 anos com DM2 há 22 anos, neuropatia periférica e gastroparesia diagnosticada há 3 anos, usa metformina 2 g/dia (há 15 anos), insulina NPH e omeprazol. Há 8 meses tem distensão abdominal pós-prandial, flatulência e 3 a 4 evacuações amolecidas por dia, com perda de 5 kg. Sem sangue e sem febre. Exame: hipotensão postural, abdome distendido e timpânico, sem massas. Exames: hemoglobina 11,2 g/dL, VCM 104 fL, vitamina B12 168 pg/mL (200 a 900), folato sérico 26 ng/mL (3 a 17), anti-transglutaminase IgA negativo com IgA total normal, TSH normal, calprotectina fecal 38 µg/g, elastase fecal 380 µg/g. Colonoscopia normal, com biópsias normais. A causa mais provável da diarreia é:

O DADO QUE DECIDE

folato sérico 26 ng/mL (3 a 17)

Resolução. Metformina causa diarreia e deficiência de B12, e por isso é a resposta que salta. Mas a diarreia da metformina costuma aparecer no início do uso ou após aumento de dose e, sobretudo, não eleva o folato. Aqui a diarreia surgiu 15 anos depois, com distensão e flatulência, em um diabético com neuropatia autonômica (gastroparesia, hipotensão postural) que usa IBP: dismotilidade e hipocloridria são o substrato do supercrescimento bacteriano. A combinação de B12 baixa (consumida pelas bactérias) com folato alto (sintetizado por elas) é a assinatura laboratorial. A elastase normal afasta insuficiência pancreática e as biópsias normais afastam colite microscópica. Confirma-se com teste respiratório com glicose ou lactulose, ou trata-se empiricamente com rifaximina.

A) Colite microscópica
Errada. Colite microscópica dá diarreia aquosa com colonoscopia normal, mas as biópsias mostrariam a lesão; aqui foram normais.

B) Supercrescimento bacteriano do delgado CORRETA
Correta. Neuropatia autonômica e IBP, com distensão, B12 baixa e folato alto: supercrescimento bacteriano do delgado.

C) Insuficiência pancreática exócrina
Errada. Seria a resposta com elastase fecal abaixo de 200 µg/g e esteatorreia; a elastase de 380 µg/g é normal.

D) Efeito adverso da metformina ARMADILHA
Errada. É a isca: metformina dá diarreia e B12 baixa, mas não folato alto; seria a resposta com diarreia logo após início ou aumento da dose, sem distensão e com folato normal.

Para levar. B12 baixa com folato alto em quem tem dismotilidade ou hipocloridria aponta supercrescimento bacteriano do delgado.

ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (2020); North American Consensus on hydrogen and methane-based breath testing (2017)

---

51 Neurologia · Guillain-Barré com CVF abaixo de 20 mL/kg e gasometria normal: intubação eletiva

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 39 anos, internado na enfermaria há 2 dias por fraqueza ascendente iniciada 6 dias após quadro diarreico, com arreflexia global e dissociação proteinocitológica no líquor, recebe imunoglobulina IV (2º de 5 dias). Hoje refere dificuldade para engolir e tosse fraca. Exame: tetraparesia grau 2 em membros inferiores e 3 em superiores, paresia facial bilateral, não consegue contar até 15 numa expiração. FR 22 irpm, SpO2 97% em ar ambiente, PA oscilando entre 90/60 e 170/100 mmHg nas últimas 6 horas. Gasometria arterial: pH 7,41, pCO2 40 mmHg, pO2 88 mmHg. Capacidade vital forçada à beira do leito: 17 mL/kg (na admissão, 35 mL/kg). A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Capacidade vital forçada à beira do leito: 17 mL/kg

Resolução. SpO2 de 97% e gasometria normal parecem tranquilizadoras, mas na fraqueza neuromuscular elas são as últimas a mudar: o paciente hiperventila para compensar até a fadiga súbita, e a hipercapnia aparece já na beira da parada. O que mede a reserva é a força ventilatória, e a regra é 20/30/40: CVF abaixo de 20 mL/kg, PImáx menos negativa que -30 cmH2O ou PEmáx abaixo de 40 cmH2O, ou queda de mais de 30% da CVF, indicam intubação eletiva. Aqui a CVF caiu de 35 para 17 mL/kg, há disfunção bulbar (disfagia, tosse fraca, diparesia facial) e disautonomia, todos preditores de ventilação mecânica (escore EGRIS alto). Ventilação não invasiva é contraindicada com disfunção bulbar, pelo risco de aspiração, e só adia a intubação. Corticoide não tem benefício na síndrome de Guillain-Barré e não se associa à imunoglobulina.

A) Repetir gasometria em 6 horas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Gasometria normal não afasta falência iminente na doença neuromuscular; esperar alterar significa intubar em emergência.

B) Intubação orotraqueal eletiva na UTI CORRETA

Correta. CVF de 17 mL/kg (queda de mais de 50%), disfunção bulbar e disautonomia: intubação eletiva e controlada na UTI.

C) Ventilação não invasiva na UTI

Errada. VNI pode ser usada em miastenia sem disfunção bulbar importante; na SGB com disfagia e tosse fraca aumenta aspiração e atrasa a intubação.

D) Associar metilprednisolona à imunoglobulina

Errada. Corticoide, isolado ou com imunoglobulina, não melhora o desfecho da SGB e não é recomendado.

Para levar. Na SGB e na miastenia, a decisão de intubar é pela CVF (menos de 20 mL/kg) e pressões respiratórias, não pela saturação ou gasometria. Corticoide não trata SGB.

EAN/PNS 2023 (diretriz de Guillain-Barré); Lawn et al. 2001 (regra 20/30/40); Neurocritical Care Society.

---

52 Reumatologia · Síndrome de Sjögren com parótida que cresce: linfoma MALT pelos preditores

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 58 anos tem síndrome de Sjögren primária há 12 anos (anti-Ro e anti-La reagentes), com xerostomia e xeroftalmia, em uso de pilocarpina e colírio lubrificante. Há 5 meses nota aumento progressivo e indolor da parótida esquerda, que não regrediu com dois ciclos de antibiótico prescritos em outro serviço. Nega febre, dor à mastigação, saída de pus pelo ducto e perda de peso. Há 3 meses surgiram lesões purpúricas palpáveis nas pernas. Exame físico: parótida esquerda aumentada, endurecida e indolor, parótida direita normal, sem linfonodomegalias cervicais, púrpura palpável em pernas. Exames: Hb 12,1 g/dL, leucócitos 3.600/mm³ com linfócitos 700/mm³, plaquetas 210.000/mm³, VHS 48 mm/h, PCR 0,4 mg/dL, C3 normal, C4 5 mg/dL (VR 10 a 40), fator reumatoide 340 UI/mL, crioglobulinas positivas, eletroforese de proteínas com pequeno pico monoclonal IgM kappa. Ultrassonografia: parótida esquerda com área hipoecoica de 2,8 cm. O diagnóstico mais provável para o aumento da parótida é:

O DADO QUE DECIDE

C4 5 mg/dL (VR 10 a 40)

Resolução. Aumento de parótida numa paciente com Sjögren parece parte da doença, e é esse rótulo que faz esperar. Mas o aumento é unilateral, progressivo, endurecido e persistente por meses, e vem com os preditores de linfoma do Sjögren: púrpura palpável, crioglobulinemia, C4 baixo, fator reumatoide em título alto, linfopenia e componente monoclonal. Com eles, o risco de linfoma, que já é de 5 a 10% ao longo da vida, sobe muito, e o subtipo mais frequente é o linfoma da zona marginal extranodal (MALT) em glândula salivar. A área hipoecoica na ultrassonografia reforça, e a confirmação é por biópsia da parótida (incisional ou por agulha grossa), e não da glândula labial, que serve ao diagnóstico do Sjögren. A doença por IgG4 dá aumento bilateral de glândulas com anti-Ro negativo, e a parotidite bacteriana tem dor, febre e pus no ducto e responde ao antibiótico.

A) Sialadenite pela síndrome de Sjögren ARMADILHA
Errada. A sialadenite do Sjögren costuma ser bilateral e flutuante; aumento unilateral, endurecido e progressivo com púrpura, crioglobulinas e C4 baixo é linfoma até prova contrária.

B) Doença relacionada à IgG4
Errada. Seria pensada com aumento bilateral e simétrico de glândulas, anti-Ro e anti-La negativos e IgG4 alta; aqui o Sjögren é confirmado e há preditores de linfoma.

C) Linfoma MALT da parótida CORRETA
Correta. Parótida unilateral que cresce, púrpura, crioglobulinemia, C4 baixo, linfopenia e pico monoclonal IgM kappa: linfoma MALT.

D) Parotidite bacteriana crônica
Errada. Teria dor, febre e saída de pus pelo ducto, e responderia ao antibiótico; aqui o aumento é indolor e não cedeu com dois ciclos.

Para levar. No Sjögren, parótida persistente e unilateral, púrpura, crioglobulinemia, C4 baixo e componente monoclonal são preditores de linfoma MALT: biópsia da parótida, sem esperar.

ACR/EULAR 2016 classification criteria for primary Sjögren's syndrome; EULAR 2019 recommendations for the management of Sjögren's syndrome with topical and systemic therapies; WHO Classification of Haematolymphoid Tumours, 5ª ed. (2022).

---

53 Hematologia · Hemoglobinúria paroxística noturna com trombose de veias hepáticas: citometria antes de trombofilia

Negativo no meio · Gabarito A

Mulher de 29 anos, em uso de anticoncepcional oral combinado há 4 anos, é internada por dor em hipocôndrio direito e ascite iniciadas há 10 dias. Refere urina escura pela manhã em alguns dias do último ano e episódios de disfagia. O Doppler mostra trombose das veias hepáticas. Exames: Hb 8,6 g/dL, VCM 102 fL, reticulócitos 4% (110.000/mm³), leucócitos 3.100/mm³, plaquetas 92.000/mm³, LDH 1.450 U/L, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta 2,2 mg/dL, Coombs direto negativo, esfregaço sem esquizócitos, ferritina 18 ng/mL e hemossiderina urinária positiva. Fator V Leiden e mutação G20210A da protrombina ausentes. O exame mais adequado para elucidar o quadro é:

O DADO QUE DECIDE

Coombs direto negativo, esfregaço sem esquizócitos

Resolução. Trombose em mulher com anticoncepcional puxa para trombofilia hereditária, e o reflexo é completar o painel. O caso tem, porém, uma hemólise intravascular que a trombofilia não explica: LDH muito alta, haptoglobina indetectável, hemossiderina urinária, ferropenia por perda urinária de ferro e urina escura matinal. Os negativos no meio decidem a causa da hemólise: Coombs direto negativo afasta mecanismo imune, e esfregaço sem esquizócitos afasta microangiopatia. Hemólise intravascular Coombs negativa com citopenias e trombose em sítio atípico (veias hepáticas) é hemoglobinúria paroxística noturna, e a disfagia é espasmo esofágico pela depleção de óxido nítrico. O diagnóstico é por citometria de fluxo do sangue periférico, mostrando perda das proteínas ancoradas por GPI (CD55, CD59, FLAER). A JAK2 é a principal causa de Budd-Chiari, mas cursa com contagens altas, não com hemólise e citopenias.

A) Citometria de fluxo (CD55, CD59) CORRETA

Correta. Hemólise intravascular com Coombs negativo, citopenias e Budd-Chiari: HPN, confirmada pela citometria de fluxo (CD55, CD59, FLAER).

B) Pesquisa de mutação JAK2 V617F

Errada. JAK2 seria a primeira pesquisa num Budd-Chiari com eritrocitose ou trombocitose; aqui há citopenias e hemólise.

C) Proteínas C, S e antitrombina ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o painel de trombofilia não explica hemólise intravascular, e proteína C, S e antitrombina ficam alteradas na trombose aguda e na hepatopatia.

D) Biópsia de medula com cariótipo

Errada. A medula pode mostrar hipoplasia associada e o cariótipo serviria a uma SMD, mas não diagnosticam HPN; o clone se identifica por citometria no sangue periférico.

Para levar. Trombose em sítio atípico com hemólise intravascular Coombs negativa e citopenias é HPN: peça citometria de fluxo (CD55, CD59, FLAER), não painel de trombofilia.

ICCS/ESCCA 2018 guidelines para diagnóstico de HPN por citometria; EASL 2016 Clinical Practice Guidelines on vascular diseases of the liver.

---

54 Infectologia · Infecção aguda pelo HIV na consulta de início da PrEP com teste rápido não reagente: carga viral antes de decidir

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 26 anos, que faz sexo com homens, procura o serviço para iniciar PrEP. Relata relação anal receptiva sem preservativo com parceria de sorologia desconhecida há 16 dias. Há 4 dias tem febre, odinofagia, mialgia, úlceras orais rasas e exantema maculopapular em tronco. Exame: T 38,3 °C, linfonodos cervicais e axilares de 1,5 cm, faringe hiperemiada, exantema em tronco. Teste rápido anti-HIV (dois testes sequenciais) não reagente hoje. Creatinina 0,9 mg/dL, HBsAg não reagente, VDRL não reagente. Para decidir sobre a PrEP, o exame mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Há 4 dias tem febre, odinofagia, mialgia, úlceras orais rasas e exantema maculopapular em tronco.

Resolução. Perfil de PrEP, dois testes rápidos não reagentes e função renal normal: em geral a PrEP começa no mesmo dia, sem outro exame, e é isso que a regra puxa. Mas o caso traz, no meio, uma síndrome retroviral aguda (febre, faringite, úlceras orais, exantema e linfonodomegalia 2 semanas após exposição de risco), e na infecção aguda os testes de anticorpo ainda podem ser não reagentes. Iniciar PrEP, que tem só duas drogas, numa infecção já estabelecida seleciona resistência. Por isso, com sinais de infecção aguda, adia-se a PrEP e pede-se a carga viral do HIV, que detecta o RNA dias antes dos anticorpos: detectável, é diagnóstico e o caminho é TARV completa; indetectável, inicia-se a PrEP. Sem acesso à carga viral, a PrEP é adiada e o teste repetido em 4 semanas. Mononucleose entra no diferencial, mas não muda a conduta urgente, que é afastar o HIV agudo.

A) Imunoensaio de 3ª geração
Errada. O imunoensaio de 3ª geração detecta só anticorpos, como o teste rápido, e também pode ser negativo nessa fase; a carga viral detecta o RNA dias antes.

B) Sorologia para EBV
Errada. Mononucleose também dá febre, faringite e linfonodomegalia, mas úlceras orais e exantema 16 dias após exposição sexual de risco pedem primeiro afastar o HIV agudo, que é o que muda a conduta.

C) Carga viral do HIV CORRETA
Correta. Sinais de infecção aguda pelo HIV pedem carga viral antes de decidir a PrEP: detectável é diagnóstico, indetectável libera a PrEP.

D) Nenhum exame adicional ARMADILHA
Errada. É a armadilha: dois testes rápidos não reagentes bastam para começar a PrEP no mesmo dia em quem não tem sintomas; com síndrome retroviral aguda, não excluem o HIV.

Para levar. Na consulta de PrEP, sintomas de infecção viral aguda após exposição recente pedem carga viral antes de começar: teste de anticorpo não reagente não exclui HIV agudo.

PCDT para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV (MS, 2022); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024).

---

55 Nefrologia · Síndrome pulmão-rim com sorologias pendentes · pulsoterapia antes do laudo e biópsia mantida

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 58 anos, previamente hígido, refere há três semanas febre baixa, artralgias, perda de 4 kg e escarros com raias de sangue; há dois dias, dispneia. Exame: SpO2 89% em ar ambiente, FR 26 irpm, PA 158/94 mmHg, estertores crepitantes bilaterais, sem lesões cutâneas. Exames: hemoglobina 8,4 g/dL (12,9 g/dL há um mês), plaquetas 310.000/mm³, coagulograma normal, creatinina 1,1 mg/dL há dois meses, 3,8 mg/dL na admissão e 4,6 mg/dL após 24 horas, potássio 5,1 mEq/L; urina com 70% de hemácias dismórficas e cilindros hemáticos. Tomografia de tórax: opacidades em vidro fosco bilaterais. ANCA e anti-MBG foram colhidos, com resultado previsto em 72 horas, e a nefrologia agendou a biópsia renal para daqui a quatro dias. O início do tratamento e a biópsia renal são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

creatinina 1,1 mg/dL há dois meses, 3,8 mg/dL na admissão e 4,6 mg/dL após 24 horas

Resolução. Diante de um diagnóstico ainda sem nome (ANCA, anti-MBG ou imunocomplexo), o impulso é esperar o laudo para tratar certo, o que ele fez nas três glomerulonefrites rapidamente progressivas que errou. Mas síndrome pulmão-rim com creatinina que quadruplicou em semanas e subiu 0,8 mg/dL em 24 horas é emergência: cada dia de atraso custa néfrons que não voltam, e a hemorragia alveolar pode matar. A conduta é pulsoterapia com metilprednisolona (500 a 1.000 mg/dia por três dias) imediatamente, sem esperar sorologias nem biópsia. O corticoide não invalida a biópsia feita nos dias seguintes: crescentes, necrose e o padrão de imunofluorescência (linear, granular ou pauci-imune) continuam visíveis, e a biópsia define o mecanismo, a atividade e a cronicidade, que guiam o restante da indução (ciclofosfamida ou rituximabe, e plasmaférese se for anti-MBG). Com plaquetas e coagulação normais e PA controlável, não há contraindicação.

A) Pulsoterapia imediata / biópsia nos próximos dias CORRETA

Correta. Pulsoterapia já, pela gravidade (hemorragia alveolar e perda de função em horas), e biópsia mantida nos dias seguintes para definir mecanismo e cronicidade.

B) Aguardar sorologias / biópsia nos próximos dias ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A biópsia nos próximos dias está certa, mas esperar 72 horas pelas sorologias para iniciar imunossupressão aceita perda renal irreversível; a glomerulonefrite rapidamente progressiva é urgência terapêutica.

C) Pulsoterapia imediata / biópsia dispensada

Errada. Tratar já está certo, mas a biópsia continua necessária: define o tipo (o anti-MBG pede plasmaférese), mede a cronicidade e não é invalidada por poucos dias de corticoide.

D) Aguardar sorologias / biópsia dispensada

Errada. Erra nas duas metades: atrasa o tratamento e dispensa a informação que só a biópsia dá.

Para levar. Na glomerulonefrite rapidamente progressiva grave (pulmão-rim ou creatinina subindo em dias), pulso de metilprednisolona antes de sorologias e biópsia; a biópsia vem depois e não é invalidada pelo corticoide.

KDIGO 2024 (ANCA-Associated Vasculitis); KDIGO 2021 (Glomerular Diseases), glomerulonefrite rapidamente progressiva e doença anti-MBG; EULAR 2022 (vasculites ANCA).

---

56 Cardiologia · Fibrilação atrial pré-excitada: bloqueador nodal e amiodarona contraindicados

Rótulo verdadeiro | Gabarito C

Homem de 23 anos, sem comorbidades, chega com palpitações há 1 hora. Relata dois episódios de taquicardia regular nos últimos 3 anos, revertidos na emergência com verapamil IV. Exame: lúcido, sem dispneia, PA 116×74 mmHg, perfusão adequada, FC entre 190 e 260 bpm. ECG: ritmo irregularmente irregular, complexos QRS de largura e morfologia variáveis de um batimento para outro, alguns estreitos e outros muito largos, menor intervalo RR de 200 ms. Potássio e magnésio normais. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

complexos QRS de largura e morfologia variáveis de um batimento para outro

Resolução. As crises anteriores que cederam com verapamil são um rótulo verdadeiro: eram taquicardias reentrantes ortodrômicas, e repetir o remédio que funcionou é o reflexo que a banca explora. O traçado de hoje é outro: irregular, com QRS que muda de largura a cada batimento conforme a proporção de condução pela via acessória, e RR mínimo de 200 ms (FC de até 300 bpm), que é a FA pré-excitada. Bloquear o nó atrioventricular (verapamil, diltiazem, betabloqueador, adenosina, digoxina) deixa a via acessória conduzir sozinha e pode degenerar em fibrilação ventricular, e a amiodarona IV, por bloquear também o nó antes de agir na via, está igualmente contraindicada. No paciente estável, usa-se procainamida (ou ibutilida); se houver instabilidade ou falha, cardioversão elétrica sincronizada. Depois, ablação da via acessória. No Brasil a procainamida venosa tem disponibilidade limitada, e na prática a cardioversão elétrica sincronizada costuma ser o caminho mesmo no estável; o que não muda é a proibição do bloqueio nodal.

A) FA com aberrância / verapamil IV ARMADILHA
Errada nas duas metades, e é a armadilha. O verapamil serviu nas crises regulares ortodrômicas; na FA pré-excitada ele acelera a condução pela via e pode precipitar fibrilação ventricular.

B) TV polimórfica / sulfato de magnésio IV
Errada. A TV polimórfica (torsades) tem QRS que gira em torno da linha de base, em geral com QT longo; aqui há QRS estreitos intercalados e ritmo de FA.

C) FA pré-excitada / procainamida IV CORRETA
Correta. Ritmo irregular com QRS de largura variável e RR mínimo de 200 ms é FA pré-excitada; no estável, a procainamida age na via acessória sem bloquear o nó.

D) FA pré-excitada / amiodarona IV
Errada na segunda metade. O diagnóstico está certo, mas a amiodarona IV não é recomendada na FA pré-excitada: seu efeito nodal precede o efeito na via.

Para levar. FA irregular com QRS de largura variável e RR curtíssimo é pré-excitação: nada que bloqueie o nó (verapamil, diltiazem, betabloqueador, adenosina, digoxina, amiodarona IV). Estável, procainamida ou ibutilida; instável, cardioversão.

ESC 2019 (supraventricular tachycardia); ACC/AHA/ACCP/HRS 2023 (atrial fibrillation); ESC 2024 (atrial fibrillation)

---

57 Pneumologia · Derrame pleural reumatoide com ADA alto e contato de tuberculose

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 61 anos, tabagista (30 maços-ano), com artrite reumatoide soropositiva há 14 anos, em uso de metotrexato e prednisona 5 mg/dia, tem derrame pleural à direita há 3 meses, com dor torácica leve. O irmão, com quem divide a casa, terminou o tratamento de tuberculose pulmonar há 4 meses. Nega febre e sudorese. Exame: T 36,8 °C, nódulos subcutâneos em cotovelos, sinovite em punhos, macicez no terço inferior do hemitórax direito. Toracocentese: líquido turvo esverdeado, pH 7,04, glicose 8 mg/dL (glicemia 104 mg/dL), proteína 5,2 g/dL, LDH 1.840 U/L, 2.300 células/mm³ (68% linfócitos), ADA 52 U/L, Gram e cultura para germes comuns negativos, pesquisa direta de BAAR e teste rápido molecular negativos. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

glicose 8 mg/dL (glicemia 104 mg/dL)

Resolução. Imunossupressão, contato domiciliar recente, exsudato linfocítico e ADA de 52 formam o pacote da tuberculose pleural, e o rótulo é verdadeiro: ele tem risco real. Mas a glicose de 8 mg/dL com pH de 7,04 é o número que manda. Tuberculose pleural raramente baixa a glicose abaixo de 30 e o pH abaixo de 7,1; glicose quase zerada com pH muito baixo sem infecção bacteriana é a marca do derrame reumatoide, por bloqueio do transporte de glicose na pleura inflamada e alto consumo local. O perfil completa o quadro: homem, tabagista, AR soropositiva de longa data com nódulos subcutâneos, líquido esverdeado e LDH muito alto. ADA também se eleva no derrame reumatoide (e no empiema), por isso não separa as duas doenças; teste rápido e BAAR negativos não excluem tuberculose, mas não há nada no líquido que a explique melhor que a AR.

A) Linfoma pleural

Errada. Linfoma dá exsudato linfocítico com LDH alto e pode até elevar o ADA, mas glicose quase zerada com pH de 7,04 é rara nele, e não há adenomegalia, esplenomegalia nem sintomas B.

B) Empiema pleural

Errada. Empiema também zera a glicose e baixa o pH, mas é neutrofílico, com febre e bacterioscopia ou cultura muitas vezes positivas; aqui são 68% de linfócitos, sem febre há 3 meses, com culturas negativas.

C) Derrame pleural reumatoide CORRETA

Correta. AR soropositiva antiga com nódulos, homem tabagista, glicose de 8 e pH de 7,04 com cultura negativa: derrame reumatoide.

D) Tuberculose pleural ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. O contato e o ADA de 52 puxam para cá, mas tuberculose pleural não costuma ter glicose abaixo de 30 nem pH abaixo de 7,1, e o ADA também sobe no derrame reumatoide.

Para levar. Glicose pleural abaixo de 30 mg/dL com pH muito baixo e cultura negativa, em AR soropositiva com nódulos, é derrame reumatoide; ADA alto não separa AR de tuberculose.

BTS Guideline for pleural disease 2023; Light RW, Pleural Diseases, 6ª ed. (2013); Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019)

---

58 Oncologia · Hipercalcemia em paciente com câncer: PTH inapropriadamente normal indica hiperparatireoidismo primário

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 64 anos, tratada há 3 anos de carcinoma de mama luminal A estádio I (cirurgia conservadora, radioterapia e anastrozol em curso), assintomática, tem cálcio total de 11,4 mg/dL (8,5 a 10,2) em exames de rotina, confirmado com cálcio iônico de 1,48 mmol/L. Usa anastrozol e losartana; nega suplemento de cálcio ou de vitamina D e tiazídico. Exame normal. Exames: fósforo 2,3 mg/dL, albumina 4,2 g/dL, creatinina 0,8 mg/dL, PTH 58 pg/mL (15 a 65), 25-OH-vitamina D 32 ng/mL, cálcio urinário de 24 h 290 mg, fosfatase alcalina normal. Cintilografia óssea de seguimento, há 2 meses, sem lesões. A causa mais provável da hipercalcemia é:

O DADO QUE DECIDE

PTH 58 pg/mL (15 a 65)

Resolução. Câncer de mama e hipercalcemia montam hipercalcemia da malignidade, e é para lá que o rótulo puxa. Mas o primeiro exame da hipercalcemia é o PTH, e um PTH de 58 pg/mL, lido como normal, é inapropriado: com cálcio iônico alto, a paratireoide normal estaria suprimida (PTH abaixo de cerca de 20 pg/mL), como acontece na hipercalcemia por PTHrP, por metástase lítica ou por calcitriol. PTH alto ou inapropriadamente normal com cálcio alto é hipercalcemia PTH-dependente, e a causa mais comum em ambulatório, inclusive em quem tem câncer, é hiperparatireoidismo primário. O cálcio urinário de 290 mg/24 h afasta hipercalcemia hipocalciúrica familiar, e a cintilografia sem lesões, a fosfatase alcalina normal e a doença estádio I sem recidiva tornam metástase improvável. O passo seguinte é localizar a paratireoide e avaliar critérios cirúrgicos.

A) Metástases ósseas osteolíticas
Errada. Metástases líticas suprimem o PTH e costumam alterar fosfatase alcalina ou cintilografia; aqui o PTH não está suprimido e a cintilografia é normal.

B) Hipercalcemia humoral pelo PTHrP ARMADILHA
Errada. É a isca: PTHrP elevado suprime o PTH; um PTH de 58 pg/mL com cálcio alto não está suprimido, e isso afasta a hipercalcemia humoral maligna.

C) Hiperparatireoidismo primário CORRETA
Correta. Cálcio alto com PTH não suprimido (58 pg/mL), fósforo baixo e calciúria alta: hiperparatireoidismo primário, mesmo com câncer de base.

D) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
Errada. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar tem calciúria baixa (fração de excreção de cálcio abaixo de 0,01); 290 mg/24 h a afasta.

Para levar. Na hipercalcemia, PTH alto ou "normal" é inapropriado e indica causa PTH-dependente mesmo em quem tem câncer; a hipercalcemia da malignidade suprime o PTH.

Endocrine Society Clinical Practice Guideline: Treatment of Hypercalcemia of Malignancy in Adults (2023); Fifth International Workshop on the evaluation and management of primary hyperparathyroidism (2022)

---

59 Endocrinologia · Síndrome poliglandular tipo 2: levotiroxina antes do cortisol precipita crise adrenal

Cronologia **Gabarito B**

Mulher de 29 anos, com vitiligo, procurou a unidade básica há cinco semanas por cansaço, inchaço e queda de cabelo; TSH 9,8 µUI/mL, T4 livre 0,7 ng/dL (0,8 a 1,8), anti-TPO positivo, e iniciou levotiroxina 75 µg/dia. Há dez dias tem piora progressiva da astenia, náuseas, vômitos, dor abdominal e tontura ao levantar. Nega febre, diarreia ou viagem. Exame: PA 84/50 mmHg deitada, FC 118 bpm, mucosas secas, escurecimento de cicatrizes antigas e de pregas palmares, tireoide sem bócio, sem tremor. Exames: sódio 126 mEq/L, potássio 5,9 mEq/L, glicemia 61 mg/dL, creatinina 1,5 mg/dL, cálcio 9,6 mg/dL. A causa mais provável da descompensação atual é:

O DADO QUE DECIDE

escurecimento de cicatrizes antigas e de pregas palmares

Resolução. A piora começou semanas depois de iniciar levotiroxina, com taquicardia, e a leitura de excesso leva a culpar a dose. Mas excesso de hormônio tireoidiano não produz potássio de 5,9, sódio de 126, glicemia de 61 nem escurecimento da pele. A cronologia diz outra coisa: a levotiroxina acelera o metabolismo do cortisol e aumenta a demanda, e numa insuficiência adrenal ainda não reconhecida isso precipita a crise. O caso tem a assinatura de insuficiência adrenal primária: hiperpigmentação de cicatrizes e pregas, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia e hipotensão. Com vitiligo e Hashimoto, é síndrome poliglandular tipo 2, e o TSH inicial pode até ter sido elevado em parte pela própria falta de cortisol. A conduta é hidrocortisona venosa imediata; em suspeita de SPA2, o cortisol é avaliado e reposto antes da levotiroxina.

A) Hipotireoidismo ainda não compensado
Errada. Hipotireoidismo ainda não compensado explica cansaço e até hiponatremia, mas não hipercalemia, hipotensão nem escurecimento de cicatrizes.

B) Crise adrenal precipitada pela levotiroxina CORRETA
Correta. Hiperpigmentação, hipercalemia, hiponatremia e hipoglicemia após iniciar levotiroxina: a reposição tireoidiana precipitou a crise de uma insuficiência adrenal primária oculta.

C) Tireotoxicose por excesso de levotiroxina ARMADILHA
Errada. Seria a causa com perda de peso, tremor e TSH suprimido; excesso de levotiroxina não explica hipercalemia, hipoglicemia nem hiperpigmentação, e a taquicardia aqui é de hipovolemia.

D) Gastroenterite com desidratação
Errada. Não há diarreia nem febre, e gastroenterite não explica hipercalemia, hipoglicemia e escurecimento de cicatrizes.

Para levar. Em autoimunidade poliglandular, avalie o cortisol antes de iniciar levotiroxina; se ambos faltam, hidrocortisona primeiro, porque a levotiroxina pode precipitar crise adrenal.

Endocrine Society, Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency 2016; ATA Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism 2014.

---

60 Neurologia · NMO rotulada de esclerose múltipla que piora com fingolimode: anti-aquaporina-4

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 36 anos, parda, com diagnóstico de esclerose múltipla feito há 2 anos em outro serviço após neurite óptica bilateral grave (acuidade final 20/200 no olho direito), usa fingolimode há 8 meses. Nesse período teve 3 semanas de soluços e vômitos incoercíveis, com endoscopia normal, e agora apresenta, há 5 dias, paraparesia, nível sensitivo em T6 e retenção urinária. RM de coluna: lesão centromedular com hipersinal em T2 de C7 a T8, com realce. RM de encéfalo: lesão na área postrema, sem lesões periventriculares ovoides ou justacorticais. Bandas oligoclonais ausentes no líquor. Além da pulsoterapia com metilprednisolona, o exame a solicitar agora é:

O DADO QUE DECIDE

lesão centromedular com hipersinal em T2 de C7 a T8

Resolução. O rótulo é o diagnóstico prévio de esclerose múltipla e a droga em uso; quem o aceita procura complicação do fingolimode (LEMP) ou acompanha atividade de EM. Mas o quadro não é de EM: mielite longitudinalmente extensa (mais de 3 segmentos vertebrais, centromedular), síndrome de área postrema (soluços e vômitos incoercíveis), neurite óptica bilateral grave com sequela e bandas oligoclonais ausentes são os critérios centrais de neuromielite óptica. O exame que define é o anti-aquaporina-4 sérico por ensaio celular; se negativo, pede-se anti-MOG. O diagnóstico muda o tratamento: fingolimode, natalizumabe, interferon beta e alentuzumabe não protegem e podem precipitar surtos graves na NMO, e a manutenção passa a ser rituximabe, inebilizumabe, satralizumabe ou eculizumabe. LEMP dá lesões subcorticais de substância branca sem realce importante e não causa mielite.

A) Potencial evocado visual
Errada. Potencial evocado visual documenta lesão do nervo óptico, já evidente pela clínica, e não separa EM de NMO.

B) Anticorpo anti-aquaporina-4 sérico CORRETA
Correta. Mielite extensa, síndrome de área postrema e neurite óptica grave sem bandas oligoclonais pedem anti-AQP4, que confirma NMO e muda a droga de manutenção.

C) Nova RM de encéfalo em 3 meses
Errada. Repetir RM é monitoramento de EM; adiar o diagnóstico mantém uma droga que pode piorar a NMO.

D) Pesquisa de vírus JC no líquor ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Vírus JC se pesquisa na suspeita de LEMP (lesões subcorticais progressivas, sem mielite), sobretudo com natalizumabe; aqui o quadro é de surto de NMO.

Para levar. Mielite de 3 ou mais segmentos, soluços e vômitos incoercíveis ou neurite óptica grave bilateral: pedir anti-AQP4. Drogas de EM (fingolimode, natalizumabe, interferon) pioram a NMO.

IPND 2015 (critérios de NMOSD); ECTRIMS/EAN 2023; Consenso brasileiro de NMOSD (ABN 2023).

---

61 Hematologia · Anemia hemolítica por crioaglutinina na pneumonia por Mycoplasma: índices falsos e Coombs só C3d

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Estudante de 21 anos, previamente hígido, iniciou há 12 dias tosse seca, cefaleia e febre baixa; a radiografia mostrou infiltrado intersticial bilateral e ele recebeu sulfametoxazol-trimetoprima por 5 dias, sem melhora, trocado depois por azitromicina. Hoje procura atendimento por urina escura e cansaço, e conta que as pontas dos dedos ficam arroxeadas no frio. Exame: icterícia 1+/4, SpO2 95%, crepitações em bases. Hemograma automatizado: Hb 8,1 g/dL, hematócrito 16%, VCM 124 fL, CHCM 50 g/dL, reticulócitos 7%. LDH 980 U/L, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta 3,4 mg/dL. Coombs direto: anti-C3d positivo, anti-IgG negativo. Esfregaço: aglutinação de hemácias, sem esquizócitos e sem corpúsculos de Heinz. O mecanismo da hemólise é:

O DADO QUE DECIDE

aglutinação de hemácias

Resolução. O rótulo verdadeiro é a sulfonamida: hemólise após sulfametoxazol leva à deficiência de G6PD, e o VCM de 124 ainda puxa para megaloblastose. Os índices, porém, são artefato: Hb de 8,1 com hematócrito de 16% dá CHCM de 50 g/dL, impossível fisiologicamente, e isso acontece quando hemácias aglutinadas passam como uma célula grande no contador. Aglutinação no esfregaço, acrocianose no frio, Coombs positivo só para complemento e pneumonia atípica com 2 a 3 semanas de evolução fecham anemia hemolítica por crioaglutinina, um anticorpo IgM anti-I que o Mycoplasma pneumoniae induz por mimetismo. A IgM liga a hemácia na periferia fria, fixa complemento e se solta ao reaquecer, por isso o Coombs só detecta C3d. A hemolisina de Donath-Landsteiner também dá Coombs C3d, mas é IgG não aglutinante, mais comum em criança após virose. A conduta é tratar a infecção, aquecer o paciente e os hemocomponentes; corticoide não funciona.

A) Hemolisina bifásica de Donath-Landsteiner
Errada. A hemoglobinúria paroxística a frio também tem Coombs C3d, mas o anticorpo é IgG bifásico, não aglutina e predomina em crianças após virose.

B) IgM anti-I fixadora de complemento CORRETA
Correta. Aglutinação no esfregaço, CHCM espúrio, acrocianose e Coombs só C3d após pneumonia atípica: crioaglutinina IgM anti-I do Mycoplasma.

C) IgG anti-Rh com sequestro esplênico
Errada. Seria o mecanismo da AHAI quente, com Coombs IgG positivo e esferócitos; aqui o anti-IgG é negativo.

D) Oxidação da hemoglobina por sulfonamida ARMADILHA
Errada. É a armadilha: hemólise oxidativa na G6PD tem Coombs negativo e corpúsculos de Heinz ou células mordidas, e não aglutina hemácias.

Para levar. Hemólise após pneumonia atípica com Coombs só C3d, aglutinação no esfregaço e VCM ou CHCM absurdos é crioaglutinina IgM anti-I: aquecer e tratar a infecção; corticoide não serve.

BSH 2017 guideline on autoimmune haemolytic anaemia (Hill et al.); consenso internacional sobre AHAI (Jäger et al., Blood Reviews 2020).

---

62 Reumatologia · Pneumocistose na indução da nefrite lúpica lida como hemorragia alveolar

Negativo no meio **Gabarito D**

Mulher de 29 anos tem LES com nefrite classe IV diagnosticada há 7 semanas, tratada com pulso de metilprednisolona seguido de prednisona 60 mg/dia (hoje 50 mg/dia) e micofenolato 2 g/dia, sem profilaxia antimicrobiana. Há 6 dias apresenta tosse seca, febre de 38,3 °C e dispneia progressiva, hoje aos mínimos esforços. Nega hemoptise, dor torácica e edema. Exame físico: FR 30 irpm, SpO2 85% em ar ambiente, PA 118 x 72 mmHg, estertores finos discretos em bases, sem turgência jugular, sem edema. Exames: Hb 10,4 g/dL (10,6 g/dL há 1 semana), leucócitos 6.100/mm³ com linfócitos 350/mm³, plaquetas 196.000/mm³, LDH 690 U/L, creatinina 1,1 mg/dL (1,9 ao diagnóstico), EAS com 4 hemácias por campo (60 ao diagnóstico), C3 e C4 normais (baixos ao diagnóstico), anti-DNA nativo 1:40 (1:640 ao diagnóstico). TC de tórax: vidro fosco difuso, bilateral e simétrico, com predomínio peri-hilar e preservação da periferia, sem consolidações, nódulos ou derrame. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Hb 10,4 g/dL (10,6 g/dL há 1 semana)

Resolução. LES com nefrite proliferativa, vidro fosco difuso e hipoxemia é o cenário em que se pensa primeiro em hemorragia alveolar, e a conduta seria mais pulso e plasmaférese. Mas os negativos derrubam a hemorragia: sem hemoptise, hemoglobina estável em uma semana e um lúpus que está respondendo (creatinina, sedimento, complemento e anti-DNA melhorando), quando a hemorragia alveolar costuma vir com doença em atividade, nefrite ativa e queda abrupta de hemoglobina. O que o caso tem é o perfil da pneumocistose: 7 semanas de prednisona acima de 20 mg/dia com micofenolato, linfopenia grave, nenhuma profilaxia, tosse seca com febre, hipoxemia desproporcional à ausculta, LDH alta e vidro fosco peri-hilar que poupa a periferia. A confirmação vem do lavado broncoalveolar ou do escarro induzido com pesquisa de Pneumocystis, e beta-D-glucana alta reforça; o tratamento é sulfametoxazol-trimetoprima em dose plena. A lição de prevenção: prednisona de cerca de 20 mg/dia ou mais por 4 semanas ou mais, associada a outro imunossupressor, pede profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprima.

A) Pneumonite lúpica aguda

Errada. A pneumonite lúpica aguda acompanha lúpus em atividade, em geral com serosite, e tem consolidações ou vidro fosco basal; aqui o complemento normalizou e o anti-DNA caiu.

B) Hemorragia alveolar lúpica ARMADILHA

Errada. Seria a resposta com hemoptise ou queda de 2 g/dL ou mais na hemoglobina, lúpus em atividade e lavado progressivamente hemorrágico; aqui a hemoglobina está estável e a doença responde ao tratamento.

C) Edema pulmonar hipervolêmico

Errada. Seria pensado na sobrecarga de volume da nefrite, mas não há turgência jugular nem edema, a função renal melhorou e há febre.

D) Pneumonia por Pneumocystis jirovecii CORRETA

Correta. Prednisona alta com micofenolato sem profilaxia, linfopenia, LDH alta, hipoxemia desproporcional e vidro fosco peri-hilar que poupa a periferia: pneumocistose.

Para levar. No LES em indução, vidro fosco difuso com hemoglobina estável e doença em resposta é infecção oportunista até prova contrária, não hemorragia alveolar. Prednisona de 20 mg/dia ou mais por 4 semanas com outro imunossupressor pede profilaxia para Pneumocystis.

EULAR 2023 update of the recommendations for the management of SLE (prevenção de infecções); KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis; ECIL-5 2016 guidelines for Pneumocystis jirovecii pneumonia in non-HIV patients.

---

63 Infectologia · Histoplasmose disseminada na aids com contato domiciliar de tuberculose: a pápula umbilicada com antígeno criptocócico negativo

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 36 anos, com HIV diagnosticado nesta internação, CD4 28 células/mm³, trabalhou nos últimos 3 meses na reforma de um casarão abandonado no interior de Minas Gerais. Há 6 semanas tem febre diária, perda de 9 kg, diarreia e tosse seca. O irmão, com quem divide o quarto, tratou tuberculose pulmonar no ano passado. Exame: T 38,8 °C, PA 100 × 64 mmHg, linfonodos cervicais de 1,5 cm, fígado a 4 cm e baço a 5 cm do rebordo costal, pápulas umbilicadas e úlceras rasas em face e palato. Hb 8,2 g/dL, leucócitos 2.100/mm³, plaquetas 64.000/mm³, LDH 1.480 U/L, ferritina 8.900 ng/mL, ALT 88 U/L, fosfatase alcalina 610 U/L, antígeno criptocócico sérico não reagente. Radiografia de tórax: infiltrado micronodular difuso. Baciloscopia de escarro negativa em 2 amostras. O agente mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

pápulas umbilicadas e úlceras rasas em face e palato

Resolução. O irmão com tuberculose, o infiltrado micronodular e a febre consumptiva com CD4 de 28 montam a tuberculose miliar, e a baciloscopia negativa não afastaria a hipótese. Mas o exame da pele traz o que a TB não explica: pápulas umbilicadas e úlceras rasas de mucosa oral. Na aids avançada, pápula umbilicada é lesão de fungo disseminado (criptococo ou histoplasma), e não de micobactéria; com o antígeno criptocócico sérico não reagente, que tem sensibilidade muito alta na criptococose disseminada, sobra o Histoplasma. O restante concorda: pancitopenia, LDH acima de 1.000 U/L e ferritina muito alta, hepatoesplenomegalia, fosfatase alcalina elevada e exposição a poeira de construção abandonada (fezes de morcego e de aves). Confirmam o antígeno urinário, a hemocultura para fungos e o mielograma ou a biópsia de pele; o tratamento é anfotericina B lipossomal na indução e itraconazol depois.

A) Complexo Mycobacterium avium

Errada. MAC disseminado causa febre, diarreia, anemia e fosfatase alcalina alta com CD4 abaixo de 50, mas não faz lesões umbilicadas de pele nem úlceras orais.

B) Cryptococcus neoformans

Errada. Criptococose disseminada também faz pápulas umbilicadas, mas o antígeno criptocócico sérico não reagente praticamente a afasta.

C) Histoplasma capsulatum CORRETA

Correta. Pápulas umbilicadas e úlceras orais com antígeno criptocócico negativo, pancitopenia, LDH e ferritina muito altas e exposição a poeira de construção abandonada.

D) Mycobacterium tuberculosis ARMADILHA

Errada. É a armadilha: miliar explicaria febre, micronódulos, pancitopenia e o contato domiciliar, mas não faz pápulas umbilicadas nem úlceras de mucosa.

Para levar. Na aids avançada, pápula umbilicada aponta fungo disseminado: com antígeno criptocócico negativo, é histoplasmose até prova em contrário, mesmo com contato de TB na história.

PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024); OPAS/OMS Guidelines for diagnosing and managing disseminated histoplasmosis among people living with HIV (2020).

---

64 Cardiologia · Choque cardiogênico no infarto multiarterial: noradrenalina e angioplastia só da artéria culpada

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 66 anos chega 3 horas após o início de dor torácica, com supradesnivelamento de ST de V1 a V6, DI e aVL. PA 76×50 mmHg, FC 112 bpm, extremidades frias, enchimento capilar de 5 segundos, estertores em bases, SpO2 91% com oxigênio, lactato 4,8 mmol/L, sem sopros novos. Ecocardiograma à beira do leito: acinesia anterior extensa, FE 25%, sem complicação mecânica, sem derrame. No cateterismo, há oclusão da descendente anterior proximal e lesões de 80% na coronária direita e na circunflexa. O suporte hemodinâmico inicial e a estratégia de revascularização são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

lesões de 80% na coronária direita e na circunflexa

Resolução. Com três vasos doentes e o paciente em choque, a intuição é tratar tudo de uma vez, e é a armadilha. No choque cardiogênico, a angioplastia multiarterial no procedimento índice aumentou morte e diálise em 30 dias em relação à abordagem só da artéria culpada (CULPRIT-SHOCK), e as lesões não culpadas são tratadas depois, estagiadas. No suporte, com PAS abaixo de 90 e hipoperfusão, o vasopressor de escolha é a noradrenalina, e o inotrópico entra a seguir se a perfusão não melhorar. O balão intra-aórtico de rotina não reduziu mortalidade (IABP-SHOCK II) e ficou reservado para complicação mecânica ou ponte selecionada; o dispositivo microaxial pode ser considerado em casos escolhidos (DanGer Shock), mas não é o suporte inicial universal. A grade se resolve pelas duas metades: noradrenalina, e não balão; culpada, e não multiarterial.

A) Balão intra-aórtico / só a artéria culpada

Errada na primeira metade. A estratégia de revascularização está certa, mas o balão intra-aórtico de rotina não reduz mortalidade; seria opção numa CIV ou insuficiência mitral aguda.

B) Noradrenalina / só a artéria culpada CORRETA

Correta. Noradrenalina como primeiro vasopressor e angioplastia apenas da descendente anterior, deixando as outras lesões para depois.

C) Noradrenalina / multiarterial no mesmo procedimento ARMADILHA

Errada na segunda metade, e é a armadilha. O suporte está certo, mas tratar as lesões não culpadas no mesmo procedimento piorou desfechos no choque; seria aceitável fora do choque, estagiado.

D) Balão intra-aórtico / multiarterial no mesmo procedimento
Errada nas duas metades: balão de rotina e multiarterial imediata, as duas condutas que pioraram ou não mudaram desfecho.

Para levar. Infarto em choque cardiogênico: angioplastia só da artéria culpada no procedimento índice (as demais depois), noradrenalina como vasopressor inicial, e sem balão intra-aórtico de rotina.

ESC 2023 (acute coronary syndromes); CULPRIT-SHOCK (NEJM 2017); IABP-SHOCK II (NEJM 2012); DanGer Shock (NEJM 2024); ESC 2021 (heart failure)

---

65 Hepatologia · Hepatite C curada sem fibrose avançada: nenhum exame de rastreamento de carcinoma hepatocelular

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 56 anos, com hepatite C crônica adquirida por transfusão em 1988, foi tratada com sofosbuvir e velpatasvir por 12 semanas. Antes do tratamento: elastografia hepática transitória de 6,2 kPa, plaquetas 248.000/mm³, FIB-4 de 1,1 e ultrassonografia normal. Doze semanas após o fim do tratamento, HCV-RNA indetectável e ALT normal. Não usa álcool, IMC 23 kg/m², sem diabetes; HBsAg não reagente e anti-HBs reagente; não usa drogas e não tem nova exposição de risco. Quanto ao rastreamento de carcinoma hepatocelular a partir de agora, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

elastografia hepática transitória de 6,2 kPa

Resolução. Depois de hepatite C, muita gente mantém ultrassonografia semestral por segurança, e é o excesso que a questão cobra. O rastreamento de carcinoma hepatocelular após resposta virológica sustentada só se mantém em quem tinha fibrose avançada ou cirrose (F3 ou F4, com elastografia em geral acima de 10 a 12,5 kPa), porque nesses o risco persiste após a cura. Esta paciente tinha elastografia de 6,2 kPa, FIB-4 de 1,1 e plaquetas normais, ou seja, fibrose ausente ou mínima, e não tem outro fator de lesão hepática (álcool, esteatose, vírus B). Sem exposição de risco contínua, não há necessidade de repetir HCV-RNA. Não há exame de rastreamento a pedir: ela recebe alta do seguimento da hepatite C, com a orientação de que o anti-HCV seguirá reagente.

A) Alfafetoproteína semestral
Errada. Alfafetoproteína isolada não é método de rastreamento (baixa sensibilidade) e só complementa a ultrassonografia em quem tem indicação, que ela não tem.

B) Ultrassonografia semestral ARMADILHA
Errada. É a isca: ultrassonografia semestral se mantém após a cura em quem tinha F3 ou F4; com 6,2 kPa, o risco não a justifica.

C) Nenhum exame de rastreamento CORRETA
Correta. Resposta virológica sustentada, elastografia de 6,2 kPa e nenhum outro fator de lesão: sem rastreamento de carcinoma hepatocelular, alta do seguimento.

D) Elastografia hepática anual
Errada. Elastografia seriada acompanha fibrose avançada ou outra doença hepática ativa, e não hepatite C curada sem fibrose; tampouco rastreia carcinoma.

Para levar. Após a cura da hepatite C, rastreamento de carcinoma hepatocelular só em F3 ou F4; sem fibrose avançada e sem outro fator, nenhum exame e alta.

AASLD-IDSA HCV Guidance (2023); EASL recommendations on treatment of hepatitis C (2020); PCDT de Hepatite C e Coinfecções (Ministério da Saúde, 2019)

---

66 Nefrologia · Acidose com ânion gap e gap osmolar altos · etilenoglicol x metanol pelo órgão-alvo

Negativo no meio | Gabarito C

Homem de 41 anos, mecânico, é encontrado sonolento na oficina ao lado de um galão sem rótulo, cerca de 20 horas depois de ter sido visto pela última vez. Exame: Glasgow 13, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem queixa visual, fundoscopia normal, FR 30 irpm com respiração profunda, PA 150/90 mmHg. Exames: pH 7,10, bicarbonato 6 mEq/L, pCO2 19 mmHg, sódio 140 mEq/L, cloro 102 mEq/L, glicose 98 mg/dL, ureia 54 mg/dL, creatinina 2,6 mg/dL e subindo, cálcio total 7,3 mg/dL, lactato 2,3 mmol/L, beta-hidroxibutirato 0,3 mmol/L, etanol indetectável, osmolalidade medida de 330 mOsm/kg. O agente mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

sem queixa visual, fundoscopia normal

Resolução. Acidose com ânion gap de 32 (140 - 102 - 6) e gap osmolar de cerca de 36 (calculada 2 × 140 + 98/18 + 54/6, perto de 294, contra 330 medida) fecham intoxicação por álcool tóxico, e o metanol é o primeiro nome que vem, ainda mais num galão sem rótulo. Quem separa os dois são o órgão-alvo e os negativos: o metanol vira ácido fórmico, que lesa a retina e o nervo óptico (visão turva, escotoma, hiperemia ou edema de papila, midríase pouco reativa), e aqui, com cerca de 20 horas de evolução e acidose já grave (fase em que o ácido fórmico já lesa a retina), não há queixa visual e a fundoscopia é normal. O etilenoglicol vira glicolato e oxalato, que precipita com o cálcio nos túbulos: lesão renal aguda progressiva e hipocalcemia (7,3 mg/dL), exatamente o que o caso mostra. O isopropanol dá gap osmolar com cetose, mas sem acidose de ânion gap elevado, e a cetoacidose alcoólica exigiria beta-hidroxibutirato alto. Conduta: fomepizol (ou etanol) e hemodiálise pela acidose grave e pela lesão renal.

A) Isopropanol
Errada. O isopropanol é metabolizado a acetona: dá gap osmolar e cetose, sem acidose metabólica de ânion gap elevado.

B) Etanol com cetoacidose
Errada. O etanol está indetectável e o beta-hidroxibutirato é de 0,3 mmol/L, o que afasta cetoacidose alcoólica.

C) Etilenoglicol CORRETA
Correta. Ânion gap e gap osmolar altos com lesão renal aguda progressiva, hipocalcemia e visão preservada: etilenoglicol, cujo oxalato precipita com o cálcio no túbulo.

D) Metanol ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a resposta com queixa visual, fundoscopia alterada ou lesão de putâmen na imagem; lesão renal com hipocalcemia não é a assinatura do metanol.

Para levar. Ânion gap e gap osmolar altos: o metanol ataca o olho; o etilenoglicol ataca o rim, com hipocalcemia e cristais de oxalato; o isopropanol dá gap osmolar sem acidose.

EXTRIP Workgroup, recomendações para intoxicação por metanol (Crit Care Med 2015); American Academy of Clinical Toxicology, diretriz de etilenoglicol (1999); Harrison 21ª ed. (Acute Poisoning).

---

67 Emergência · Intoxicação por tricíclico prescrito para fibromialgia: bicarbonato, não fisostigmina

Droga a deduzir **Gabarito A**

Mulher de 38 anos é trazida à emergência 2 horas após ingerir várias cartelas de um medicamento que usa há 1 ano, em dose baixa à noite, "para a dor da fibromialgia e para dormir". Está sonolenta (Glasgow 12), com pupilas midriáticas, pele quente e seca, mucosas secas, bexiga palpável e ruídos hidroaéreos diminuídos. PA 94 × 58 mmHg, FC 128 bpm, SpO2 96% em ar ambiente, glicemia 112 mg/dL. ECG: taquicardia sinusal, QRS de 136 ms, onda R de 4 mm em aVR. Gasometria: pH 7,33. A medida mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

QRS de 136 ms, onda R de 4 mm em aVR

Resolução. A droga não é nomeada, mas dose baixa noturna para dor de fibromialgia e insônia é amitriptilina (ou ciclobenzaprina, de estrutura tricíclica). O quadro anticolinérgico é evidente e convida ao antídoto anticolinérgico, a fisostigmina. Mas o que mata no tricíclico é o bloqueio dos canais de sódio do miocárdio: QRS acima de 100 ms e R em aVR acima de 3 mm predizem convulsão e arritmia ventricular. O tratamento é bicarbonato de sódio 1 a 2 mEq/kg em bolus, repetido até estreitar o QRS, buscando pH de 7,45 a 7,55: a carga de sódio e a alcalinização revertem o bloqueio. Fisostigmina é contraindicada com QRS alargado (relatos de assistolia), e flumazenil pode precipitar convulsão. Carvão ativado é opção com via aérea protegida; lavagem gástrica não é rotina.

A) Bicarbonato de sódio em bolus CORRETA

Correta. Tricíclico com QRS de 136 ms e R de 4 mm em aVR: bicarbonato de sódio em bolus até estreitar o QRS.

B) Fisostigmina intravenosa ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Seria o antídoto numa síndrome anticolinérgica pura (atropina, anti-histamínico) com QRS normal; no tricíclico com QRS largo pode causar bradiarritmia e assistolia.

C) Lavagem gástrica

Errada. Lavagem gástrica não melhora desfecho e aumenta aspiração; não trata a cardiotoxicidade, que é a urgência.

D) Flumazenil intravenoso

Errada. Flumazenil reverte benzodiazepínico, mas em coingestão com tricíclico desmascara convulsões; não tem papel aqui.

Para levar. Intoxicação por tricíclico com QRS acima de 100 ms pede bicarbonato de sódio em bolus; fisostigmina e flumazenil são contraindicados.

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11ª ed.; AHA 2023 (manejo de intoxicações com risco à vida)

---

68 Endocrinologia · Estado hiperosmolar hiperglicêmico: volume antes da insulina

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 79 anos, com diabetes tipo 2 em metformina e gliclazida, é trazida da instituição de longa permanência por sonolência progressiva há quatro dias, após infecção urinária. Exame: Glasgow 11, mucosas muito secas, PA 86/52 mmHg, FC 118 bpm, T 37,8 °C, peso estimado 55 kg. Exames: glicemia 912 mg/dL, sódio 141 mEq/L, potássio 4,9 mEq/L, ureia 128 mg/dL, creatinina 2,3 mg/dL, pH 7,34, bicarbonato 20 mEq/L, beta-hidroxibutirato 0,8 mmol/L, osmolalidade efetiva calculada 333 mOsm/kg. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

PA 86/52 mmHg, FC 118 bpm

Resolução. Glicemia de 912 é o rótulo que pede insulina já. No estado hiperosmolar, porém, o problema central é o déficit de água e sódio (cerca de 100 a 200 mL/kg), e a paciente está hipotensa. A insulina desloca glicose e, com ela, água do intravascular para a célula; dada antes da reposição de volume, pode precipitar colapso circulatório e queda brusca da osmolalidade. Por isso a primeira medida é soro fisiológico a 0,9%, e a insulina contínua (sem necessidade de bolus) entra depois da expansão inicial, com potássio de 4,9 permitindo; a diretriz britânica (JBDS) só a inicia quando a glicemia deixa de cair com o fluido isolado, salvo cetonemia acima de 1 mmol/L, e a alternativa correta vale pelas duas leituras, porque em nenhuma a insulina precede a expansão. O sódio corrigido de cerca de 154 mEq/L não muda o fluido inicial, que é isotônico; a solução hipotônica só se considera depois, se a osmolalidade não cair. Beta-hidroxibutirato de 0,8 e pH de 7,34 afastam cetoacidose relevante.

A) SF 0,45% pelo sódio corrigido
Errada. O fluido inicial de qualquer crise hiperglicêmica com hipovolemia é isotônico; a solução a 0,45% é ajuste posterior.

B) Bicarbonato e insulina contínua
Errada. Não há acidose que indique bicarbonato (pH 7,34).

C) SF 0,9% e, depois, insulina contínua CORRETA
Correta. Expansão com SF 0,9% primeiro, e insulina contínua só depois da expansão inicial, com potássio adequado.

D) SF 0,9% com insulina em bolus já ARMADILHA
Errada. Insulina em bolus junto com a primeira expansão, em paciente hipotensa e hiperosmolar, arrisca colapso e queda rápida da osmolalidade; seria mais aceitável na cetoacidose com volume restabelecido.

Para levar. No estado hiperosmolar hipovolêmico, o volume vem antes da insulina: SF 0,9% primeiro, insulina contínua sem bolus depois, com queda de osmolalidade lenta.

ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS consensus report: Hyperglycemic crises in adults with diabetes (Umpierrez et al., Diabetes Care 2024); JBDS-IP, Management of the hyperosmolar hyperglycaemic state in adults (Diabet Med 2023).

69 Neurologia · Estado de mal epiléptico sem acesso venoso: midazolam IM antes de qualquer imagem

Cronologia **Gabarito D**

Homem de 45 anos, cerca de 80 kg, com epilepsia em uso irregular de valproato, é trazido pelo SAMU em crise tônico-clônica generalizada que começou há 8 minutos, presenciada pela esposa, sem recuperação da consciência entre os abalos. Na sala de emergência a crise persiste; SpO2 91% com máscara não reinalante, glicemia capilar 112 mg/dL, PA 168/96 mmHg. Após duas tentativas, a equipe ainda não conseguiu acesso venoso periférico. A esposa relata que ele caiu da própria altura no início da crise e bateu a cabeça. A conduta imediata mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

crise tônico-clônica generalizada que começou há 8 minutos

Resolução. Crise tônico-clônica que dura mais de 5 minutos é estado de mal, e a partir desse ponto cada minuto sem benzodiazepínico reduz a chance de resposta, porque os receptores GABA-A são internalizados. O trauma craniano é verdadeiro e vai exigir TC, mas a imagem vem depois de interromper a crise: o paciente em convulsão nem pode ser escaneado com segurança. Sem acesso venoso, o benzodiazepínico de primeira linha é o midazolam 10 mg IM (acima de 40 kg), tão eficaz quanto o lorazepam IV no estudo RAMPART e mais rápido de administrar; alternativas são midazolam intranasal ou bucal. Fenitoína, levetiracetam ou valproato são a segunda etapa, depois do benzodiazepínico. Diazepam é a finalista errada: pela via intramuscular, lipossolúvel e de absorção errática, atinge nível eficaz tarde demais; só serve IV ou retal. A hipoxemia em geral melhora quando a crise para.

A) Fenitoína por acesso intraósseo
Errada. Fenitoína é droga da segunda etapa, após o benzodiazepínico; usar o acesso intraósseo para ela pula a primeira linha.

B) Diazepam 10 mg intramuscular
Errada. Diazepam serve por via IV ou retal; pela via intramuscular a absorção é lenta e errática e o nível eficaz chega tarde. O benzodiazepínico para o músculo é o midazolam, hidrossolúvel.

C) TC de crânio antes de medicar ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A TC é necessária pelo trauma, mas depois de controlar a crise; investigar antes de tratar o estado de mal piora o prognóstico.

D) Midazolam 10 mg intramuscular CORRETA
Correta. Estado de mal com 8 minutos e sem acesso venoso: midazolam 10 mg IM agora, e depois imagem e droga de segunda linha.

Para levar. Estado de mal: benzodiazepínico até 5 a 10 minutos, antes de imagem e de exame. Sem veia, midazolam 10 mg IM.

AES 2016 (estado de mal convulsivo); Neurocritical Care Society 2012; RAMPART (NEJM 2012); ESETT (NEJM 2019).

70 Hematologia · Reação transfusional anafilática na deficiência de IgA x TRALI: diagnóstico e hemocomponente futuro

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 38 anos, com úlcera duodenal que sangrou e já foi tratada por endoscopia, recebe concentrado de hemácias. Tem sinusites de repetição desde a adolescência e diagnóstico de doença celíaca há 2 anos. Cerca de 5 minutos após o início da transfusão, apresenta rubor facial, urticária no tronco, rouquidão, sibilos difusos e PA de 70 × 40 mmHg, sem febre, com SpO2 de 89% em ar ambiente. A transfusão é interrompida e ele recebe adrenalina intramuscular, com melhora em minutos. A radiografia de tórax feita a seguir não mostra infiltrados. O diagnóstico e o hemocomponente indicado para transfusões futuras são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

A radiografia de tórax feita a seguir não mostra infiltrados

Resolução. Dispneia com hipoxemia durante a transfusão puxa para TRALI, e o diagnóstico se ancora na saturação de 89%. O que decide a primeira metade é o resto do quadro: início em minutos, urticária, rouquidão, sibilos e hipotensão com resposta rápida à adrenalina é anafilaxia, e a radiografia sem infiltrados afasta TRALI, que por definição tem infiltrado bilateral novo em até 6 horas, sem broncoespasmo nem urticária. A segunda metade vem do antecedente: sinusites de repetição e doença celíaca sugerem deficiência de IgA, cujo anticorpo anti-IgA reage com o plasma do doador. Nesses pacientes os componentes devem ser lavados (removendo o plasma) ou vir de doador com deficiência de IgA. Desleucocitar retira leucócitos, não proteínas plasmáticas, e serve para reação febril e aloimunização.

A) TRALI / hemácias lavadas
Errada. O componente lavado está certo para a anafilaxia, mas não há TRALI sem infiltrado pulmonar bilateral.

B) Reação anafilática / hemácias lavadas CORRETA
Correta. Urticária, sibilos e hipotensão em minutos, sem infiltrado, num paciente com pistas de deficiência de IgA: anafilaxia, e transfusões futuras com hemácias lavadas.

C) Reação anafilática / hemácias desleucocitadas
Errada. O diagnóstico está certo, mas a desleucocitação não remove a IgA do plasma do doador e não previne nova anafilaxia.

D) TRALI / hemácias desleucocitadas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: ancora na hipoxemia; TRALI exige infiltrado na radiografia e não tem urticária nem broncoespasmo.

Para levar. Urticária, sibilos e hipotensão em minutos são anafilaxia transfusional (pense em deficiência de IgA) e pedem componente lavado; TRALI é hipoxemia com infiltrado bilateral, sem urticária.

Ministério da Saúde, Guia para uso de hemocomponentes (2015); ANVISA, Marco conceitual e operacional de hemovigilância (2015); definição revisada de TRALI (Vlaar et al., Transfusion 2019).

71 Infectologia · Leucoencefalopatia multifocal progressiva na aids: confirmar antes de tratar toxoplasmose

Negativo no meio **Gabarito B**

Mulher de 42 anos, com HIV e uso irregular da TARV, CD4 64 células/mm³, IgG para toxoplasmose reagente e sem profilaxia, é internada por perda progressiva de força no braço e na perna direitos e dificuldade para falar há 5 semanas, sem cefaleia, febre ou crises. Exame: Glasgow 15, afasia de expressão, hemiparesia direita grau 3, hemianopsia homônima direita, sem papiledema. RM de encéfalo: lesões confluentes da substância branca subcortical frontoparietal e occipital esquerdas, hiperintensas em T2/FLAIR e hipointensas em T1, envolvendo as fibras em U, sem realce pelo gadolínio e sem efeito de massa. O exame mais adequado para confirmar o diagnóstico é:

O DADO QUE DECIDE

sem realce pelo gadolínio e sem efeito de massa

Resolução. CD4 abaixo de 100, IgG para toxoplasma reagente, sem profilaxia e com déficit focal: o candidato monta neurotoxoplasmose e trata de prova. Mas a toxoplasmose dá lesões com realce anelar, edema e efeito de massa, em núcleos da base e junção córtico-subcortical, com cefaleia e febre. Aqui a imagem é de desmielinização da substância branca subcortical, com fibras em U, sem realce e sem efeito de massa, em quadro subagudo sem febre: é a leucoencefalopatia multifocal progressiva, pelo vírus JC. O exame que confirma com segurança é a PCR para JC no líquor (especificidade alta, sensibilidade moderada); a biópsia fica para PCR negativa com dúvida persistente. Não há antiviral eficaz: o tratamento é otimizar a TARV para reconstituir a imunidade.

A) Biópsia cerebral estereotáxica
Errada. Biópsia é o degrau seguinte se a PCR for negativa; fazê-la primeiro é o exame a mais.

B) PCR para vírus JC no líquor CORRETA
Correta. Lesões desmielinizantes subcorticais sem realce nem efeito de massa: PCR para JC no líquor confirma a LEMP.

C) Prova terapêutica com sulfadiazina ARMADILHA
Errada. É a armadilha: prova terapêutica seria a conduta com lesões de realce anelar e efeito de massa; sem realce e sem efeito de massa, a toxoplasmose não explica a imagem.

D) PCR para EBV no líquor
Errada. PCR para EBV apoia linfoma primário do SNC, que forma massa com realce, geralmente periventricular.

Para levar. Lesão de substância branca sem realce e sem efeito de massa na aids é LEMP até prova em contrário: PCR para JC no líquor e TARV otimizada; prova terapêutica para toxoplasma é para lesão com realce e massa.

NIH/CDC/IDSA Guidelines for Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV (LEMP, atualização 2024); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024).

72 Reumatologia · Padrão tomográfico da doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide e na esclerose sistêmica

Grade X / Y **Gabarito A**

Os padrões tomográficos de doença pulmonar intersticial mais frequentes na artrite reumatoide e na esclerose sistêmica são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

na artrite reumatoide e na esclerose sistêmica

Resolução. A generalização que derruba é achar que toda pneumopatia de doença do tecido conjuntivo é não específica. Isso vale para a esclerose sistêmica, as miopatias inflamatórias e a doença mista, em que predomina a pneumonia intersticial não específica, com vidro fosco basal e preservação subpleural. A artrite reumatoide é a exceção: o padrão mais comum é a pneumonia intersticial usual, com reticulação subpleural basal, bronquiectasias de tração e faveolamento, como na fibrose pulmonar idiopática. Os fatores de risco são homem, idade, tabagismo e títulos altos de fator reumatoide e anti-CCP, e o padrão usual tem pior prognóstico e responde pouco ao corticoide. Por isso a fibrose progressiva da artrite reumatoide pode receber antifibrótico, enquanto na esclerose sistêmica o micofenolato é a base.

A) Pneumonia intersticial usual / não específica CORRETA
Correta. A artrite reumatoide é a doença do tecido conjuntivo em que predomina a pneumonia intersticial usual; na esclerose sistêmica predomina a não específica.

B) Pneumonia intersticial não específica / usual
Errada nas duas metades. Inverte as duas doenças.

C) Pneumonia intersticial não específica / não específica ARMADILHA
Errada na primeira metade. A não específica é o padrão da esclerose sistêmica e das miopatias, mas não o da artrite reumatoide.

D) Pneumonia intersticial usual / usual
Errada na segunda metade. A pneumonia intersticial usual ocorre na esclerose sistêmica, mas é minoria.

Para levar. Doença do tecido conjuntivo com pneumopatia costuma ser não específica, exceto a artrite reumatoide, que é usual como a fibrose pulmonar idiopática.

ACR 2023 Guideline for the Screening, Monitoring and Treatment of ILD in Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases; ATS/ERS/JRS/ALAT 2022 IPF and progressive pulmonary fibrosis guideline.

---

73 Hepatologia · Hepatotoxicidade por paracetamol em ingestão escalonada: o nomograma não vale

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 41 anos, etilista de 60 g/dia, com dor de dente há 3 dias, tomou paracetamol 1 g a cada 3 a 4 horas nesse período, por conta própria, além de dois comprimidos de associação com codeína; a última dose foi há 10 horas. Chega com náuseas e dor em hipocôndrio direito. Exame: anictérico, lúcido, PA 128 × 80 mmHg, FC 96 bpm. Exames: AST 640 U/L, ALT 780 U/L, bilirrubina total 1,2 mg/dL, INR 1,3, creatinina 1,0 mg/dL, glicose 92

mg/dL, pH 7,38, lactato 1,8 mmol/L. Paracetamol sérico de 9 µg/mL, abaixo da linha de tratamento do nomograma de Rumack-Matthew para o horário. Sorologias virais em andamento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

tomou paracetamol 1 g a cada 3 a 4 horas nesse período

Resolução. O nível sérico abaixo da linha do nomograma tranquiliza, e é a isca. O nomograma de Rumack-Matthew só se aplica a ingestão aguda única com horário conhecido; em ingestão escalonada (doses repetidas supraterapêuticas ao longo de horas ou dias) ele não estima risco. Este homem tomou de 6 a 8 g/dia por 3 dias, é etilista (menos glutationa e indução do CYP2E1) e já tem ALT de 780 U/L, valor que o álcool sozinho não explica. Em ingestão escalonada, transaminases elevadas ou paracetamol detectável indicam N-acetilcisteína, que protege mesmo tardiamente. Não se espera sorologia para iniciar: o antídoto é seguro e o atraso custa fígado. Repetir o nível em 4 horas é o recurso da ingestão aguda única de horário incerto ou de liberação prolongada; aqui não muda nada e só atrasa o antídoto.

A) Não tratar: nível abaixo da linha ARMADILHA
Errada. É a isca: o nomograma vale para ingestão aguda única; na escalonada, com ALT de 780 U/L, o nível baixo não afasta hepatotoxicidade.

B) N-acetilcisteína intravenosa imediata CORRETA
Correta. Ingestão supraterapêutica repetida com transaminases elevadas: N-acetilcisteína intravenosa já, independentemente do nível sérico.

C) Repetir o nível sérico em 4 horas
Errada. Repetir o nível serve à ingestão aguda única com horário incerto ou formulação de liberação prolongada; na ingestão escalonada com ALT elevada, só atrasa a N-acetilcisteína.

D) Aguardar sorologias antes de tratar
Errada. Hepatite viral entra no diferencial, mas a N-acetilcisteína é segura e tempo-dependente; não se espera sorologia para iniciá-la.

Para levar. Nomograma de Rumack-Matthew só para ingestão aguda única com horário conhecido; em ingestão escalonada, ALT elevada ou paracetamol detectável indicam N-acetilcisteína.

Chiew et al., Updated guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand (Med J Aust, 2020); EASL Clinical Practice Guidelines on acute (fulminant) liver failure (2017)

---

74 Pneumologia · Pneumonite de hipersensibilidade não fibrótica: afastar o antígeno antes de tratar

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 52 anos, professora, que nunca fumou, tem tosse seca e dispneia aos médios esforços há 5 meses, com piora à noite e melhora parcial nas 2 semanas de férias que passou na casa da filha. Há 1 ano trocou o enxoval por edredom e travesseiros de pena de ganso. Nega artralgia, Raynaud, refluxo e uso de medicações. Exame: SpO2 95% em ar ambiente, estertores finos esparsos, sem baqueteamento. TCAR: nódulos centrolobulares mal definidos em vidro fosco, predominando nos terços médios e superiores, com atenuação em mosaico e aprisionamento aéreo na expiração, sem reticulado, bronquiectasias de tração ou faveolamento. FAN e fator reumatoide negativos. CVF 78% do previsto, DLCO 66%. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Há 1 ano trocou o enxoval por edredom e travesseiros de pena de ganso

Resolução. A TCAR é de pneumonite de hipersensibilidade não fibrótica (nódulos centrolobulares em vidro fosco, mosaico e aprisionamento, sem fibrose), há uma exposição plausível com relação temporal (penas há 1 ano) e melhora fora de casa. Com quadro leve (SpO2 95%, CVF 78%), a primeira e mais eficaz medida é afastar o antígeno: retirar edredom e travesseiros e reavaliar sintomas e função em 4 a 8 semanas. Corticoide fica para doença grave, com hipoxemia ou queda funcional importante, ou para quem não melhora após o afastamento. Biópsia só se o quadro permanecer indefinido, e antifibrótico é para fibrose pulmonar progressiva, que ela não tem.

A) Afastar as penas e reavaliar CORRETA
Correta. PH não fibrótica leve com antígeno identificado: o afastamento é diagnóstico e terapêutico, e a reavaliação define se é preciso mais.

B) Prednisona 0,5 mg/kg/dia ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Corticoide é para PH grave ou que não melhora com o afastamento; começar antes trata o efeito e mantém a causa.

C) Criobiópsia transbrônquica
Errada. Biópsia é para TCAR indeterminada ou exposição não identificada; aqui imagem e história já são concordantes.

D) Antifibrótico com nintedanibe
Errada. Antifibrótico é para fibrose pulmonar progressiva (INBUILD); a TCAR não mostra fibrose.

Para levar. Na pneumonite de hipersensibilidade, a conduta começa pela exposição: perguntar, identificar e afastar. Corticoide e biópsia vêm depois, se o afastamento não bastar.

ATS/JRS/ALAT 2020 (diagnóstico de pneumonite de hipersensibilidade); CHEST 2021 (diagnóstico e avaliação da pneumonite de hipersensibilidade); Diretrizes SBPT para doenças pulmonares intersticiais (2012)

75

Cardiologia · Hipertensão resistente com hipocalemia atribuída ao tiazídico: rastreio de hiperaldosteronismo primário

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Homem de 41 anos, com hipertensão há 3 anos, usa losartana 100 mg, anlodipino 10 mg e hidroclorotiazida 25 mg, com adesão confirmada por contagem de comprimidos. PA de consultório 158×98 mmHg e MAPA com média de vigília de 152×96 mmHg. Sem apneia do sono ao questionário e à poligrafia, sem uso de anti-inflamatório ou descongestionante. Exames: sódio 144 mEq/L, potássio 3,2 mEq/L, bicarbonato 30 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, TSH normal. O médico atribui o potássio baixo ao diurético. O próximo passo na investigação é:

O DADO QUE DECIDE

potássio 3,2 mEq/L, bicarbonato 30 mEq/L

Resolução. O tiazídico é um rótulo verdadeiro: ele causa hipocalemia, e a explicação do médico do caso convida a suspender e esperar. Mas há hipertensão resistente verdadeira (três classes em dose plena com diurético, MAPA confirmando, adesão comprovada, apneia excluída), e hipertensão resistente é indicação de

rastreio de hiperaldosteronismo primário com ou sem hipocalemia; hipocalemia com o diurético, sódio no limite alto e alcalose só reforçam. O rastreio é bioquímico, com a relação aldosterona/renina, após corrigir o potássio; BRA e tiazídico elevam a renina e podem dar falso negativo, mas não impedem começar, e um resultado positivo segue para confirmação. A tomografia de adrenais vem depois da confirmação bioquímica, e pedi-la antes é o exame do degrau seguinte, que acha incidentaloma em quem não tem a doença.

A) Relação aldosterona/renina CORRETA
Correta. Hipertensão resistente com hipocalemia: rastrear hiperaldosteronismo primário com aldosterona e renina, corrigido o potássio.

B) Suspender o tiazídico e repetir o potássio ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Aceita o rótulo do diurético e adia o diagnóstico da causa secundária mais comum de hipertensão resistente.

C) Tomografia de adrenais
Errada. A imagem só vem após a confirmação bioquímica; antes dela, mostra incidentalomas não funcionantes e leva a adrenalectomia errada.

D) Doppler de artérias renais
Errada. A estenose de artéria renal se investiga com piora de função renal após BRA, assimetria renal, sopro abdominal ou edema agudo recorrente; não há nenhum.

Para levar. Hipertensão resistente, hipocalemia espontânea ou induzida por diurético, incidentaloma adrenal ou HAS com apneia do sono: rastrear hiperaldosteronismo com relação aldosterona/renina, e só depois da confirmação pedir imagem.

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC/SBH/SBN 2020); ESC 2024 (hypertension); Endocrine Society 2016 (primary aldosteronism)

76

Nefrologia · Lesão renal pós-operatória em uso de furosemida · fração de excreção de ureia: pré-renal x necrose tubular

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 72 anos, no terceiro dia de pós-operatório de colectomia direita com ileostomia, teve hipotensão no intraoperatório (PAM de 58 mmHg por cerca de 40 minutos). Desde ontem recebe furosemida 40 mg IV de 12 em 12 horas por edema de membros inferiores, com albumina de 2,4 g/dL. O débito da ileostomia foi de 1.800 mL nas últimas 24 horas. Exame: PA 102/60 mmHg, FC 106 bpm, mucosas secas, sem turgência jugular, sem estertores, edema 2+, abdome flácido. Exames: creatinina de 0,9 para 2,3 mg/dL, ureia 112 mg/dL, sódio 134 mEq/L; urina com densidade 1,024, cilindros hialinos, sem cilindros granulosos ou células tubulares; fração de excreção de sódio 2,6% e fração de excreção de ureia 24%. A causa mais provável da lesão renal é:

O DADO QUE DECIDE

fração de excreção de ureia 24%

Resolução. Hipotensão intraoperatória de 40 minutos e fração de excreção de sódio de 2,6% parecem fechar necrose tubular aguda isquêmica. Mas a FENa só vale sem diurético: a furosemida bloqueia a reabsorção de sódio na alça e eleva a FENa mesmo quando o túbulo está íntegro e ávido por volume. A ureia é reabsorvida no túbulo proximal e no ducto coletor medular, segmentos que a furosemida não atinge, e por isso a fração de excreção de ureia abaixo de 35% continua indicando lesão pré-renal no paciente em diurético. Tudo

combina: débito alto da ileostomia, mucosas secas, taquicardia, ureia desproporcional à creatinina, urina concentrada (densidade 1,024) e sedimento só com cilindros hialinos, sem os cilindros granulosos pigmentados da necrose tubular. O edema vem da hipoalbuminemia, não de excesso intravascular. Conduta: suspender a furosemida e repor volume, repondo também as perdas da ileostomia.

A) Lesão pré-renal por hipovolemia CORRETA

Correta. FEUreia de 24% (abaixo de 35%) com furosemida em uso, urina concentrada e sedimento brando: pré-renal pela perda da ileostomia, agravada pelo diurético.

B) Necrose tubular aguda isquêmica ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A FENa de 2,6% e a hipotensão intraoperatória apontam necrose tubular, mas a FENa está falsamente alta pela furosemida; a necrose tubular traria FEUreia acima de 50%, urina isostenúrica e cilindros granulosos.

C) Nefrite intersticial aguda

Errada. Nefrite intersticial exigiria exposição a droga implicada por mais tempo, com leucocitúria e cilindros leucocitários; o sedimento é brando.

D) Síndrome compartimental abdominal

Errada. Exigiria pressão intra-abdominal acima de 20 mmHg com disfunção orgânica e abdome tenso; o abdome é flácido e a ileostomia drena bem.

Para levar. Com diurético em uso, a FENa perde valor; use a fração de excreção de ureia: abaixo de 35% é pré-renal, acima de 50% sugere necrose tubular.

KDIGO 2012 (Acute Kidney Injury); Carvounis et al., Kidney Int 2002 (fração de excreção de ureia); Harrison 21ª ed. (Acute Kidney Injury).

---

77 Endocrinologia · Hiperferritinemia metabólica e alcoólica: calcular a saturação antes de pensar em ferro

Limiar **Gabarito C**

Homem de 49 anos, com diabetes tipo 2, hipertensão, hipertrigliceridemia e IMC de 34 kg/m², bebe cerca de seis doses de destilado por dia há dez anos. É encaminhado por ferritina elevada em exames de rotina. Nega transfusões, história familiar de hepatopatia ou de hemocromatose, artralgia ou disfunção erétil. Exame: circunferência abdominal de 112 cm, fígado palpável a 3 cm do rebordo, sem estigmas de cirrose. Exames: hemoglobina 15,1 g/dL, VCM 101 fL, AST 46 U/L, ALT 50 U/L, GGT 410 U/L, plaquetas 290.000/mm³, PCR 6 mg/L, ferritina 1.180 ng/mL, ferro sérico 74 µg/dL, capacidade total de ligação do ferro 352 µg/dL. Ultrassonografia: esteatose acentuada, sem sinais de hipertensão portal. A conduta mais adequada em relação à ferritina é:

O DADO QUE DECIDE

ferro sérico 74 µg/dL, capacidade total de ligação do ferro 352 µg/dL

Resolução. Ferritina acima de 1.000 ng/mL em homem de meia-idade evoca hemocromatose, e o reflexo é pedir o HFE. O número que separa os vizinhos não vem pronto: a saturação de transferrina é o ferro dividido pela capacidade total, 74/352, cerca de 21%. Abaixo de 45%, não há sobrecarga de ferro a investigar, e a ferritina reflete o que o caso descreve: síndrome metabólica com esteatose, álcool em dose alta (GGT 410, VCM 101) e inflamação. A conduta é tratar a causa, com abstinência, perda de peso e controle do diabetes, e

repetir a ferritina, que cai em semanas a meses. O FIB-4 calculado (cerca de 1,1) também não pede elastografia neste momento.

A) Flebotomias semanais
Errada. Flebotomia trata sobrecarga confirmada; sem ela, só produz anemia.

B) Ressonância magnética com quantificação de ferro
Errada. A ressonância quantifica ferro hepático quando há suspeita real de sobrecarga (saturação alta, HFE não conclusivo); não é o passo com saturação normal.

C) Abstinência alcoólica e controle metabólico CORRETA
Correta. Saturação de cerca de 21% com álcool e síndrome metabólica é hiperferritinemia dismetabólica e alcoólica: tratar a causa e repetir a ferritina.

D) Pesquisa das mutações C282Y e H63D ARMADILHA
Errada. O HFE se pede com saturação de transferrina de 45% ou mais; com 21%, a genética não está indicada e um achado de heterozigose só confundiria.

Para levar. Diante de ferritina alta, calcule a saturação de transferrina primeiro: abaixo de 45% em obeso, diabético ou etilista não é hemocromatose e não pede HFE nem ressonância.

EASL Clinical Practice Guidelines on Haemochromatosis 2022; ACG Clinical Guideline: Hereditary Hemochromatosis 2019; AASLD MASLD Practice Guidance 2023.

---

78 Infectologia · Malária grave importada da África, lúcido e tolerando via oral: a creatinina define o artesunato

Grade X / Y · Gabarito A

Engenheiro de 42 anos retornou há 12 dias de 3 meses de trabalho em Luanda, Angola, sem quimioprofilaxia. Teve malária por Plasmodium vivax há 6 anos, quando morava em Manaus, tratada com cloroquina e primaquina. Há 4 dias tem febre com calafrios, cefaleia e mialgia. Está lúcido e aceita líquidos e comprimidos, sem vômitos. Exame: T 39,2 °C, FC 112 bpm, PA 114 × 70 mmHg, Glasgow 15, ictérico 2+/4+, baço palpável, sem sangramentos. Urinou cerca de 400 mL nas últimas 24 horas. Hb 9,6 g/dL, plaquetas 42.000/mm³, glicemia 88 mg/dL, creatinina 3,4 mg/dL, bilirrubina total 4,8 mg/dL, lactato 1,8 mmol/L. Gota espessa: numerosos trofozoítos jovens em anel, parasitemia estimada de 6%, sem formas maduras no sangue periférico. A espécie mais provável e o tratamento inicial são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
creatinina 3,4 mg/dL

Resolução. A malária vivax prévia é verdadeira e lembra recaída por hipnozoítos, mas a infecção atual vem de Angola, onde predomina o P. falciparum, e o esfregaço tem o perfil dele: parasitemia alta só com trofozoítos jovens em anel, porque as formas maduras ficam sequestradas na microcirculação. Definida a espécie, a segunda decisão é a gravidade, e é nela que está a armadilha: o paciente está lúcido, estável e tolera a via oral, o que convida ao esquema oral. Mas malária grave não exige coma: creatinina acima de 3 mg/dL com oligúria e icterícia com bilirrubina acima de 3 mg/dL em parasitemia elevada são, cada uma, critério de gravidade. Malária grave por falciparum se trata com artesunato intravenoso (ou intramuscular) por pelo menos 24 horas e até tolerar a via oral, completando depois com combinação baseada em artemisinina. O artemeter-lumefantrina oral é o tratamento da forma não complicada.

A) P. falciparum / artesunato intravenoso CORRETA

Correta. Falciparum pela procedência e pelo esfregaço, e grave pela lesão renal (creatinina de 3,4 mg/dL) e pela icterícia, mesmo lúcido: artesunato intravenoso.

B) P. falciparum / artemeter-lumefantrina oral ARMADILHA

Errada. É a armadilha: acerta a espécie, mas artemeter-lumefantrina oral é para a malária não complicada; lucidez e via oral não anulam a creatinina de 3,4 mg/dL e a icterícia.

C) P. vivax / cloroquina e primaquina

Errada. Cloroquina com primaquina trata a malária vivax não complicada; a procedência africana e a parasitemia alta só com anéis apontam falciparum.

D) P. vivax / artesunato intravenoso

Errada. Artesunato venoso também trataria a vivax grave, mas a espécie está errada: Angola e o esfregaço indicam falciparum.

Para levar. Malária grave não é só coma: creatinina acima de 3 mg/dL, icterícia com parasitemia alta, hipoglicemia, acidose, choque ou sangramento já exigem artesunato parenteral, mesmo com o paciente lúcido.

Guia de Tratamento da Malária no Brasil (MS, 2021); WHO Guidelines for Malaria (2024).

79

Hepatologia · Ascite refratária com hipertensão pulmonar e insuficiência tricúspide: TIPS contraindicado

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 66 anos com cirrose por álcool (abstinente há 3 anos), Child-Pugh B8 e MELD 14, tem insuficiência tricúspide importante e FE de VE de 60% ao ecocardiograma; o cateterismo cardíaco direito mostrou pressão média da artéria pulmonar de 48 mmHg. Há 5 meses a ascite volta a exigir paracentese de grande volume a cada 3 semanas, apesar de restrição de sódio, e ele não tolera espironolactona acima de 100 mg/dia por hiponatremia (sódio 128 mEq/L). Sem encefalopatia prévia e sem sangramento. Exame: PA 102 × 64 mmHg, turgência jugular a 45 graus com onda v proeminente, ascite volumosa, edema de membros inferiores 2+. Exames: bilirrubina 1,8 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL, plaquetas 92.000/mm³. Doppler sem trombose portal. A conduta mais adequada para a ascite é:

O DADO QUE DECIDE

pressão média da artéria pulmonar de 48 mmHg

Resolução. Ascite que exige paracentese a cada 3 semanas apesar de restrição de sódio, com intolerância a diurético, é ascite refratária, e a conduta de manual é TIPS. Mas a primeira linha traz insuficiência tricúspide importante e pressão média da artéria pulmonar de 48 mmHg medida por cateterismo: o TIPS desvia de uma vez o sangue portal para o átrio direito, aumenta a pré-carga e precipita insuficiência cardíaca direita e piora da hipertensão pulmonar. Insuficiência cardíaca, insuficiência tricúspide grave e hipertensão pulmonar grave (pressão média acima de 45 mmHg) contraindicam o procedimento. Resta paracentese de grande volume seriada com albumina (6 a 8 g por litro retirado quando acima de 5 litros) e a avaliação para transplante. Aumentar diurético é inviável com sódio de 128 e intolerância já documentada.

A) Paracenteses seriadas com albumina CORRETA

Correta. Com TIPS contraindicado pela hipertensão pulmonar e pela insuficiência tricúspide, paracenteses de grande volume com albumina controlam a ascite refratária.

B) Shunt peritoneovenoso

Errada. O shunt peritoneovenoso foi abandonado por oclusão, infecção e coagulopatia e sobrecarrega o mesmo coração direito.

C) TIPS com prótese recoberta ARMADILHA

Errada. É a isca: TIPS seria a resposta na ascite refratária sem doença cardíaca; com pressão média pulmonar de 48 mmHg e insuficiência tricúspide importante, descompensa o coração direito.

D) Furosemida em dose dobrada

Errada. A ascite já é refratária por intolerância a diurético (hiponatremia); dobrar a dose agrava o sódio e a função renal.

Para levar. Antes de indicar TIPS, procure insuficiência cardíaca, insuficiência tricúspide grave e hipertensão pulmonar: com elas, a ascite refratária se trata com paracentese e albumina.

AASLD Practice Guidance on ascites, SBP and hepatorenal syndrome (2021); EASL Clinical Practice Guidelines on decompensated cirrhosis (2018); Baveno VII (2022); Boyer e Haskal, AASLD Practice Guidelines: role of TIPS in the management of portal hypertension (2010)

---

80 Neurologia · Oftalmoplegia internuclear na mulher jovem: lado do FLM e etiologia desmielinizante

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 27 anos procura o ambulatório por visão dupla ao olhar para os lados há 5 dias. Há 1 ano teve perda visual dolorosa no olho esquerdo, com recuperação espontânea em 6 semanas, sem investigação. Nega cefaleia, ptose e piora ao fim do dia. Exame: no olhar para a esquerda, o olho direito não ultrapassa a linha média, e o olho esquerdo abduz com nistagmo; no olhar para a direita, os movimentos são completos e conjugados. A convergência é normal, com adução completa do olho direito. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem ptose, força e reflexos normais. A topografia da lesão e a etiologia mais provável são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

o olho direito não ultrapassa a linha média, e o olho esquerdo abduz com nistagmo

Resolução. Só um olho falha, e só na adução: o direito não aduz no olhar para a esquerda, enquanto o esquerdo abduz normalmente com nistagmo. Isso é oftalmoplegia internuclear, lesão do fascículo longitudinal medial, que leva o comando do núcleo do VI de um lado ao núcleo do III do outro. A lesão fica do lado do olho que não aduz (FLM direito), e não do lado do nistagmo, que é onde o apressado a coloca. A convergência preservada prova que o reto medial e o III nervo funcionam: o defeito é na via internuclear, não no músculo nem no nervo. Lesão da FRPP esquerda paralisaria o olhar conjugado para a esquerda dos dois olhos, inclusive a abdução do esquerdo, que aqui está íntegra. Na mulher jovem, com neurite óptica prévia, a causa é desmielinizante (esclerose múltipla, frequentemente bilateral); no idoso vascular, a OIN unilateral é em geral isquêmica.

A) FLM esquerdo / desmielinizante ARMADILHA

Errada na topografia, e é a armadilha. Põe a lesão do lado do nistagmo de abdução; esse nistagmo aparece no olho contralateral à lesão, e o FLM lesado é o do lado do olho que não aduz.

B) FLM esquerdo / isquêmica

Errada nas duas metades. Lado do nistagmo, não do olho que falha, e etiologia do idoso vascular com instalação súbita.

C) FLM direito / desmielinizante CORRETA

Correta. Olho direito que não aduz, com convergência preservada, localiza o FLM direito; mulher jovem com neurite óptica prévia aponta desmielinização.

D) FLM direito / isquêmica

Errada na etiologia. Seria a resposta no idoso hipertenso e diabético com instalação súbita; aos 27 anos com neurite óptica prévia, a causa é desmielinizante.

Para levar. OIN: a lesão do FLM está do lado do olho que não aduz; o outro faz nistagmo de abdução; convergência preservada. Jovem: EM; idoso: AVC.

Neuro-oftalmologia (Walsh and Hoyt, 7ª ed.); Harrison 22ª ed., cap. Neuro-Ophthalmology.